АҚМОЛА ОБЛЫСЫ

APOCP

KOKSHETAU HIGHER MEDICAL COLLEGE

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ

ALIKHANOV University

Central Asian Institute for Medical Research



75 KOKSHETAU HIGHER MEDICAL COLLEGE

КӨКШЕТАУ ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІНІҢ 75-ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН, APOCP 13-ШІ АЙМАҚТЫҚ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ

МАТЕРИАЛДАР ЖИНАҒЫ

COLLECTION OF MATERIALS

THE 13TH APOCP INTERNATIONAL REGIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE 75TH ANNIVERSARY OF KOKSHETAU HIGHER MEDICAL COLLEGE

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

МЕЖДУНАРОДНОЙ 13-ОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ APOCP, ПОСВЯЩЁННОЙ 75-ЛЕТИЮ КОКШЕТАУСКОГО ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА

KOKSHETAU - 2025

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫ
«КӨКШЕТАУ ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» МКҚК

КӨКШЕТАУ ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІНІҢ 75-ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН, АРОСР 13-ШІ АЙМАҚТЫҚ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАР ЖИНАҒЫ

Қатысушыларға

COLLECTION OF MATERIALS THE 13TH APOCP INTERNATIONAL REGIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE 75TH ANNIVERSARY OF KOKSHETAU HIGHER MEDICAL COLLEGE

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ 13-ОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ АРОСР, ПОСВЯЩЕННОЙ 75-ЛЕТИЮ КОКШЕТАУСКОГО ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА

KOKSHETAU – 2025

УДК 377 (574)
ББК 74.56 (5Қаз)
К67

Рецензенттер:
Медицина ғылымдарының докторы, профессор К. Р. Рүстемова
Медицина ғылымдарының кандидаты, Денсаулық сақтау үздігі Н.П. Пягай

Жалпы редакциясын басқарған: ғылыми -әдістемелік бөлімінің басшысы З.К.Иткусова
Техникалық редакторы: А.С.Резниченко
Редакция алқасының мүшелері: И.И. Мокрова, З.К. Иткусова, З.М. Халитова

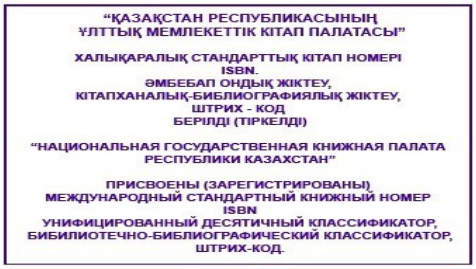
Көкшетау жоғары медициналық колледжінің 75-жылдығына арналған, АРОСР 13-ші Аймақтық Халықаралық конференциясының материалдар жинағы = Сборник материалов Международной 13-ой Региональной конференции АРОСР, посвященной 75-летию Кокшетауского высшего медицинского колледжа = Collection of materials of the 13th APOCP International Regional Conference dedicated to the 75th anniversary of Kokshetau Higher Medical College. – Көкшетау 2025 г.
«Көкшетау жоғары медициналық колледжі» МКҚК, 2025 ж. – қазақша, орысша, ағылшынша.

Жинаққа Көкшетау жоғары медициналық колледжінің 75 жылдығына арналған АРОСР Халықаралық 13-Аймақтық конференциясының материалдары енгізілген. Басылымда ұсынылған ғылыми мақалалар мен баяндамалар Медицина, Денсаулық сақтау және медициналық білім беру саласындағы заманауи үрдістер мен жетістіктерді көрсетеді. Жинақ практикалық денсаулық сақтау мамандарын, ғылыми қызметкерлерді, оқытушыларды, сондай -ақ медициналық оқу орындарының студенттерін қызықтырады.

В сборник включены материалы Международной 13-й Региональной конференции АРОСР, посвященной 75-летию Кокшетауского высшего медицинского колледжа. Представленные в издании научные статьи и доклады отражают современные тенденции и достижения в области медицины, здравоохранения и медицинского образования. Сборник представляет интерес для специалистов практического здравоохранения, научных сотрудников, преподавателей , а также студентов медицинских учебных заведений .

The collection includes the materials of the 13th International Regional Conference of the AAPR, dedicated to the 75th anniversary of the Kokshetau Higher Medical College. The scientific articles and reports presented in the publication reflect current trends and achievements in the field of medicine, healthcare and medical education. The collection is of interest to practical healthcare professionals, researchers, teachers, as well as students of medical schools.

ISBN 978-601-08-5528-1


"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КІТАП ПАЛАТАСЫ"
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТАНДАРТТЫҚ КІТАП НОМЕРІ ISBN.
ӘМБЕБАП ОНДЫҚ ЖІКТЕУ,
КІТАПХАНАЛЫҚ-БИБЛИОГРАФИЯЛЫҚ ЖІКТЕУ,
ШТРИХ - КОД
БЕРІЛДІ (ТІРКЕЛДІ)
"НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"
ПРИСВОЕНЫ (ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ КНИЖНЫЙ НОМЕР ISBN
УНИФИЦИРОВАННЫЙ ДЕСЯТИЧНЫЙ КЛАССИФИКАТОР,
БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ КЛАССИФИКАТОР,
ШТРИХ-КОД.



© «Көкшетау жоғары медициналық колледжі» МКҚК, 2025

Құрметті қонақтар, әріптестер, құрметті қатысушылар!

Ақмола облысының Денсаулық сақтау басқармасы мен Көкшетау жоғары медициналық колледжінің басшылығы атынан Азия-Тынық мұхиты қатерлі ісігінің алдын алу жөніндегі ұйымының 13-ші өңірлік халықаралық конференциясының барлық қатысушыларына " Қатерлі ісіксіз болашақ үшін бірге — медбикелер, дәрігерлер, ғалымдар!" колледждің 75 жылдығына арналған.

Конференция Денсаулық сақтау мамандарын, ғылыми қызметкерлерді, оқытушылар мен студенттерді тәжірибе алмасу және онкологияның өзекті мәселелерін талқылау үшін біріктіре отырып, ай мақтың Медициналық қауымдастығы үшін маңызды оқиға болды. Жинақта ғылыми зерттеулердің нәтижелерін, онкологиялық аурулардың алдын алу, диагностикалау және емдеудің инновациялық тәсілдерін, сондай -ақ медициналық білім берудегі заманауи үрдістерді көрсететін материалдар ұсынылған. Бірыңғай медициналық кластерде ғылым мен білім беру бірлестігі емдеудің озық әдістерін енгізуге және жоғары білікті мамандарды даярлауға ықпал етеді.

Барлық қонақтарға, спикерлер мен ұйымдастырушыларға белсенді қатысқаны және конференцияның табысына қосқан үлесі үшін шын жүректен алғыс ай тамыз. Онкологиялық қызметті дамытуға және пациенттердің өмір сүру сапасын арттыруға бағытталған әрі қарайғы ғылыми жетістіктер, нәтижелі пікірталастар мен жаңа бірлескен жобалар тілейміз.



Ермек
Нариман Ермекұлы
АРОСР Аймақтық
конференция
төрағасы DBA, DPA

Уважаемые гости, коллеги, дорогие участники!

От имени управления здравоохранения Акмолинской области и руководства Кокшетауского высшего медицинского колледжа выражаем глубокую признательность всем участникам Международной 13-й Региональной конференции Азиатско- Тихоокеанской организации по профилактике рака «Вместе для будущего без рака — Медсестры, Врачи, Ученые!», приуроченной к 75-летию Кокшетауского высшего медицинского колледжа.

Конференция стала ярким и значимым событием в жизни медицинского сообщества региона, объединившим ведущих специалистов здравоохранения, представителей науки и образования, практикующих врачей , преподавателей и студентов. Это масштабное научно-практическое мероприятие способствовало обмену опытом, укреплению профессиональных связей и обсуждению актуальных вопросов профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний . Материалы, представленные в данном сборнике, отражают результаты научных исследований, а также современные тенденции развития сестринского дела и медицинского образования. Синергия науки, практики и образования в рамках единого медицинского кластера открывает новые перспективы в подготовке высококвалифицированных специалистов и внедрении передовых методов лечения, направленных на сохранение здоровья и улучшение качества жизни населения.

Выражаем искреннюю благодарность всем участникам, спикерам и организаторам конференции за активное участие, высокий профессионализм и личный вклад в развитие медицинской науки. Пусть достигнутые результаты станут основой для новых научных свершений, плодотворного сотрудничества и совместных проектов во имя здоровья и долголетия человека.

Dear guests, colleagues, and dear participants!

On behalf of the organizing committee of the 13th Asia-Pacific Regional Cancer Prevention Organization Conference "Together for a Cancer-free Future — Nurses, Doctors, Scientists!" dedicated to the 75th anniversary of Kokshetau Higher Medical College, we would like to express our sincere gratitude to all participants for their active participation, high professionalism and personal contribution to the development of medical science and practice.

The conference has become a significant event for the entire medical community of the region and the country. The forum brought together leading healthcare professionals, representatives of academic and clinical medicine, teachers, researchers and students. It has become a platform for the exchange of scientific achievements, discussion of advanced approaches to the prevention, diagnosis and treatment of oncological diseases. The materials presented in the collection reflect the wealth of ideas, the depth of scientific research and the desire of the medical community to find effective ways to improve oncological care. Special attention is paid to innovative areas of nursing and medical education development based on the principles of evidence-based medicine and interdisciplinary interaction. The conference clearly showed that combining the efforts of science, education and practical healthcare is the key to the introduction of advanced technologies and the training of a new generation of specialists capable of responding to modern medical challenges.

The Organizing Committee expresses its gratitude to all participants, partners and organizers for fruitful cooperation, enthusiasm and commitment to professional growth. We wish you further scientific success, inspiration, new ideas and achievements for the sake of human health and well-being.



Игісін Нұрбек Сағынбекұлы

APOCP DBA, DPA Аймақтық конференциясының тең төрағасы



Молдағали Рүстем Салкиұлы

Көкшетау жоғары медициналық колледжінің директоры

Expanding the role of nurses in healthcare systems

Dairov Amantai
Executive master of business administration in healthcare (EMBA),
Kokshetau higher medical college

Abstract

Nurses are the backbone of healthcare systems, yet their potential remains underutilized in many countries. Kazakhstan, like other nations, faces challenges related to demographic changes, a growing burden of chronic diseases, and uneven distribution of health workforce. This paper reviews the strategic directions of the Nursing Development Plan of Kazakhstan (2024–2026) and international evidence to substantiate the expansion of nursing roles. Special emphasis is given to regulatory reforms, education, advanced nursing practice, digitalization, and the prestige of the profession.

Key words: role of nurses, development of nursing, nursing care.

Introduction

Healthcare systems worldwide are under pressure from an increasing prevalence of chronic diseases, population ageing, and workforce shortages. According to the World Health Organization (WHO), there are approximately 29 million nurses and midwives globally, with a projected shortage of 4.5 million by 2030 (WHO, 2020).

In Kazakhstan, the number of nurses was estimated at 741 per 100,000 population (7.4 per 1,000) in 2022 (WHO, 2022). However, this level remains below the OECD average of 89 per 10,000, with Kazakhstan reporting only 69 per 10,000 (OECD, 2018). Furthermore, only 17% of physicians and nurses serve rural areas, although 41% of the population lives there (Human Resources for Health, 2024).

These data highlight the urgent need to expand the role of nurses in Kazakhstan's healthcare system.

Methods

This study is based on a policy review of the Nursing Development Plan of the Republic of Kazakhstan for 2024–2026, combined with international literature on advanced nursing practice, health workforce distribution, and nursing burnout. Statistical data were drawn from WHO, OECD, the Kazakh National Statistics Committee, and peer-reviewed publications.

Results

Regulatory Framework

The Kazakh Ministry of Health plans to revise national regulations, including:

- updating state educational standards,
- modernizing nursing care protocols,
- improving certification procedures,
- developing payment mechanisms for advanced nursing services.

Education and Research

The Plan foresees the creation of a consortium of nursing schools at universities and medical colleges to produce clinical guidelines and training materials. Monitoring of graduate employment and satisfaction with education is also envisaged.

Advanced Nursing Practice

Internationally, nurse practitioners (NPs) have proven their effectiveness in primary care, chronic disease management, and preventive services (National Academies, 2021). Kazakhstan intends to adapt this model, integrating advanced practice nurses into ambulatory, hospital, and home-care settings.

Workforce Distribution

According to national statistics, nurse density in Kazakhstan has fluctuated between 7.17 and 7.56 per 1,000 population in recent years (KazStat, 2023). However, workforce maldistribution persists, with rural areas being underserved despite incentive programs.

Burnout and Retention

A recent study reported high levels of burnout among nurses in 24-hour hospitals in Kazakhstan (PMC, 2024). Preventive measures, psychosocial support, and better workload distribution are essential.

Digitalization

The Nursing Development Plan emphasizes telemedicine and telenursing as solutions to improve access in rural regions (Wikipedia, Telenursing).

Discussion

Expanding the role of nurses offers several benefits:

- Improved access to care in rural and underserved areas.
- Cost-effectiveness, as task-shifting from physicians to nurses can reduce expenditure without compromising quality.
- Patient satisfaction, which often increases with nurse-led care.

- Professional prestige, strengthening the attractiveness of nursing for young professionals.

At the same time, challenges include ensuring legal support for expanded functions, aligning educational programs, and providing financial incentives.

Conclusion

The expansion of nursing roles is a strategic priority for Kazakhstan and globally. Regulatory reforms, educational modernization, advanced practice training, digital solutions, and measures to prevent burnout are essential.

By empowering nurses as autonomous healthcare providers, Kazakhstan can enhance equity, quality, and resilience of its health system while addressing global workforce shortages.

References

1. World Health Organization. Nursing and Midwifery Fact Sheet. Geneva: WHO, 2020. Available at: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/nursing-and-midwifery

2. World Health Organization. Kazakhstan Country Office Report. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2022. Available at: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/380239/9789289059787-eng.pdf?sequence=1

3. OECD. OECD Reviews of Health Systems: Kazakhstan 2018. Paris: OECD Publishing, 2018. Available at: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2018/02/oecd-reviews-of-health-systems-kazakhstan-2018_g1g89393/9789264289062-en.pdf

4. Human Resources for Health. Evaluation of incentive schemes for rural health workers in Kazakhstan (2009–2020). BioMed Central, 2024. Available at: https://human-resources-health.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12960-024-00905-0

5. PMC. Burnout among nurses in Kazakhstan: a cross-sectional study. 2024. Available at: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11946353/

6. The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. The Future of Nursing 2020–2030: Charting a Path to Achieve Health Equity. Washington, DC: The National Academies Press, 2021. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK573922/

7. Agency for Strategic Planning and Reforms of the Republic of Kazakhstan. Statistical data on health resources (Nurses and midwives per 1,000 population, 2010–2023). Astana, 2023. Available at: https://stat.gov.kz/upload/medialibrary/704/qz2vdobaagxq4y89mruv876qfv93cvkt/3.c.1-%D0%90.xlsx

8. Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan. Nursing Development Plan 2024–2026. Astana: MoH RK, 2024. Order No. 759 dated 30.10.2024

9. ПР СД РК на 2024-26 гг..

10. Wikipedia. Telenursing. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Telenursing

Қазіргі заманғы білім беру стандарттарын енгізу: мультидисциплинарлық өзара әрекеттесу тәжірибесі

Байгульжина Жазира[1], Сейсембекова Маншук[2], Жумагалиева Асия[2]

[1]Оқу-тәрбие жөніндегі директордың орынбасары

[2]арнайы пәндер оқытушысы, магистр

Павлодар медициналық жоғары колледж

Аңдатпа. *Бұл мақалада қазіргі заманғы білім беру стандарттарын енгізудің негізгі бағыттары қарастырылады. Мультидисциплинарлық өзара әрекеттесудің медициналық колледж студенттерін даярлаудағы орны мен маңызы талданады. Аурухана мамандарымен бірлескен тәжірибелік жұмыс жасау ерекшеліктері нақты мысалдармен көрсетіледі. Сонымен қатар, халықаралық тәжірибелерге шолу жасалып, болашаққа ұсыныстар берілді.*

Кілт сөздер: *білім беру стандарттары, мультидисциплинарлық тәсіл, тәжірибелік оқыту, аурухана мамандары, халықаралық тәжірибе.*

Аннотация. *В статье рассматриваются основные направления внедрения современных образовательных стандартов. Анализируется роль междисциплинарного взаимодействия в подготовке студентов медицинского колледжа. Особенности совместной работы с врачами и специалистами больницы представлены на конкретных примерах. Кроме того, сделан обзор международного опыта и представлены предложения на будущее.*

Ключевые слова: *образовательные стандарты, мультидисциплинарный подход, практическое обучение, специалисты больницы, международный опыт.*

Abstract. *This article discusses the main directions of implementing modern educational standards. It analyzes the role of multidisciplinary interaction in the training of medical college students. The specifics of joint work with hospital specialists are illustrated with practical examples. In addition, international experiences are reviewed and future recommendations are provided.*

Keywords: *educational standards, multidisciplinary approach, practical training, hospital specialists, international experience.*

Кіріспе

Қазақстандағы білім беру жүйесі соңғы онжылдықта қарқынды дамып келеді. Жаңа реформалар, стандарттар мен инновациялар оқу процесін заман талабына сай бейімдеуге

бағытталған. Әсіресе медициналық білім беру саласы ерекше назарда, себебі денсаулық сақтау саласына жоғары кәсіби білікті мамандар қажет. Медициналық колледждерде оқытудың жаңа стандарттарын енгізу арқылы студенттердің теориялық және практикалық білімдері үйлестіріліп, мамандардың кәсіби даярлығы арта түсуде. Бұл үдерісте мультидисциплинарлық өзара әрекеттесу тәсілі негізгі рөл атқарады.

Негізгі бөлім

Қазіргі заманғы білім беру стандарттарының ерекшеліктері.

Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі халықаралық стандарттарға сәйкес жаңартылуда. Жаңа стандарттар құзыреттілікке негізделген тәсілді енгізуді көздейді. Медициналық колледждерде бұл студенттердің клиникалық ойлау қабілетін дамытуға, практикалық машықтарды жетілдіруге және кәсіби құндылықтарды қалыптастыруға бағытталған [1, 88 б.].

Мультидисциплинарлық тәсілдің артықшылықтары

Мультидисциплинарлық тәсіл – әртүрлі сала мамандарының бірлесіп жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Мысалы, дәрігер, мейірбике, әлеуметтік қызметкер, психолог және фармацевт бір науқастың денсаулығын кешенді қарастырады. Бұл болашақ мамандарға науқасқа тек медициналық тұрғыдан ғана емес, әлеуметтік, психологиялық тұрғыдан да қолдау көрсетуге үйретеді [2, 151 б.]. Осылайша, студент кешенді кәсіби ойлауды меңгереді.

Медициналық колледж студенттері мен аурухана мамандары арасындағы бірлескен жұмыс тәжірибесі.

Клиникалық тәжірибе кезеңінде студенттер аурухана мамандарымен тығыз байланыста болады. Олар тәжірибелі дәрігерлердің, мейірбикелердің, лаборанттардың жетекшілігімен жұмыс істеп, пациенттерге күтім жасауды, медициналық процедураларды орындауды үйренеді. Бұл тәжірибе студенттерге кәсіби жауапкершілікті сезінуге және ұжымдық жұмысқа бейімделуге көмектеседі.

Симуляциялық орталықтар мен тәжірибелік сабақтар

Медициналық колледждерде симуляциялық орталықтар кеңінен қолданылуда. Бұл орталықтарда студенттер клиникалық жағдайларды модельдеу арқылы тәжірибе жинақтайды. Аурухана мамандарының қатысуымен өткізілетін сабақтар студенттердің кәсіби дағдыларын нығайтып, теориялық білімді практикада қолдануға үйретеді.

Введите текст

Халықаралық тәжірибелер. Дамыған елдерде мультидисциплинарлық тәсіл білім берудің негізгі құрамдас бөлігі болып табылады. Мысалы, Финляндия, Германия және Жапония медициналық білім беруде студенттерді ерте кезден бастап аурухана мамандарымен интеграцияланған оқытуға тартады. Қазақстан осы тәжірибелерді ескере отырып, өз білім беру жүйесін жетілдіруде [3, 151 б.].

Жаңа зерттеулер мен ұсыныстар

Қазіргі таңда медициналық білім беруде жаңа зерттеулердің бағыттары ерекше маңызға ие. Әлемдік тәжірибеге сүйене отырып, Қазақстандағы медициналық колледждерде де мультидисциплинарлық тәсілді кеңінен енгізу қажеттілігі туындап отыр.

Мультидисциплинарлық тәсілді барлық медициналық колледждерде енгізу – соңғы зерттеулер көрсеткендей, бұл әдіс студенттердің клиникалық ойлау қабілетін дамытады, әртүрлі мамандармен жұмыс істей білуін қалыптастырады.

Ауруханалармен әріптестікті күшейту – дуальды білім беру моделін енгізу арқылы студенттер тәжірибелік дағдыларды терең меңгереді. Зерттеулер көрсеткендей, мұндай әріптестік түлектердің кәсіби бейімделуін жылдамдатады.

Симуляциялық технологияларды кеңейту – халықаралық тәжірибе дәлелдегендей, симуляциялық орталықтар студенттердің қателіктерін 40%-ға азайтады және қауіпсіз ортада тәжірибе жасауға мүмкіндік береді.

Халықаралық тәжірибелермен алмасу – соңғы жылдары жүргізілген зерттеулер мультидисциплинарлық тәжірибе алмасу студенттердің кәсіби көкжиегін кеңейтетінін көрсетті.

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарына көбірек тартылуы – ғылыми ізденістерге ерте араласқан студенттердің кәсіби бейімделуі әлдеқайда табысты жүреді. Бұл бағытта арнайы ғылыми үйірмелер мен жобаларды дамыту өзекті болып табылады.

Қорытынды

Қазіргі заманғы білім беру стандарттарын енгізу – медициналық мамандарды кәсіби даярлаудың маңызды шарты. Мультидисциплинарлық өзара әрекеттесу студенттердің кәсіби біліктілігін арттырып қана қоймай, олардың ұжымдық жұмыс жасау қабілетін дамытады. Ауруханамамандарымен бірлескен тәжірибе студенттердің теориялық білімдерін практикамен ұштастырып, мамандардың кәсіби қалыптасуына ықпал етеді. Халықаралық тәжірибелерді ескере отырып, Қазақстанда да білім беру жүйесі

үздіксіз дамып келеді. Бұл үдеріс болашақта денсаулық сақтау сапасының артуына тікелей әсер етеді.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы. Медициналық білім беру бойынша ұсынымдар.

2. European Observatory on Health Systems. Interdisciplinary education in healthcare. Brussels, 2022.

3. European Observatory on Health Systems. Interdisciplinary education in healthcare. Brussels, 2022.

4. International Council of Nurses. Nursing education and multidisciplinary collaboration. Geneva, 2020.

5. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі. Білім беру стандарттары.

6. Қазақстандық медициналық білім журналы. Мультидисциплинарлық тәсіл және инновациялар. Алматы, 2023.

7. Медициналық колледждер мен ауруханалар арасындағы әріптестік тәжірибесі туралы әдістемелік нұсқаулықтар.

8. WHO. Global standards for quality health-care education. Geneva, 2021.

Реализация совместного образовательного проекта «Школа команды врача общей практики» как основа формирования профессиональных компетенций будущих медицинских специалистов

Куликова Марина[1], Бакалец Наталья[2]

[1]Методист, к.м.н., [2]доцент заведующий кафедрой поликлинической терапии и общеврачебной практики с курсом ФПКиП

[1]Гомельский государственный медицинский колледж, [2]Гомельский государственный медицинский университет

Аннотация. *В работе описан опыт организации и промежуточные результаты реализации совместного образовательного проекта, направленного на формирование профессиональных компетенций и обеспечение продуктивного взаимодействия будущих медицинских работников в совместной деятельности по оказанию доступной и качественной медицинской помощи пациентам, подготовка к оперативному решению задач, возникающих в практической деятельности.*

Ключевые слова: *образовательный проект, врач общей практики, медицинские*

специалисты, профессиональные компетенции, симуляционные тренинги.

Введение

Активное внедрение современных медицинских технологий, повышение требований к профессиональной компетентности медицинских работников определяют необходимость усиления практического аспекта подготовки специалистов, основанного на пациент-ориентированном подходе.

В целях улучшения взаимодействия при оказании медицинской помощи пациентам Министерством здравоохранения Республики Беларусь 16.11.2018 г. приказом №1185 было утверждено Положение о работе команды врача общей практики.

Согласно данным Министерства здравоохранения Республики Беларусь работа по внедрению института врача общей практики в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения всех регионов ведется успешно. В стране сформировано более 3 тыс. команд, состоящих из врача общей практики, помощника врача по амбулаторно-поликлинической помощи и медицинской сестры общей практики. Разработаны и утверждены алгоритмы работы команды ВОП. Внедрение института ВОП в амбулаторно-поликлинические организации и работа в команде уже показали свою эффективность [1].

Цель – проанализировать промежуточные результаты образовательного проекта.

Материалы и методы исследования – обобщение опыта, анкетирование с последующей аналитической обработкой материала.

Результаты исследования и обсуждение

В 2021 году на базе учреждения образования «Гомельский государственный медицинский колледж» был создан и успешно стартовал совместный образовательный проект – «Школа команды врача общей практики» (далее – Школа).

Инициаторами создания проекта являются УО «Гомельский государственный медицинский колледж» (далее – ГомГМК) совместно с кафедрой общественного здоровья и здравоохранения с курсом ФПКиП и кафедрой поликлинической терапии и общеврачебной практики с курсом ФПКиП УО «Гомельский государственный медицинский университет» (далее – ГомГМУ).

Данный проект является первым в Республике Беларусь, объединившим будущих специалистов практического здравоохранения – членов команды ВОП на этапе их обучения и подготовки в университете и колледже.

Было разработано Положение о Школе и организованы занятия-тренинги для врачей-интернов (проходящих интернатуру по специальности «Общая врачебная

практика»), студентов выпускного курса медицинского университета и учащихся выпускного курса медицинского колледжа специальностей «Лечебное дело» и «Сестринское дело».

Основной целью проекта является обеспечение продуктивного взаимодействия будущих членов команды ВОП в совместной деятельности по оказанию доступной и качественной медицинской помощи пациентам, совершенствование социально-коммуникативных навыков с учетом этико-деонтологических принципов, подготовка членов команды ВОП к оперативному решению задач, возникающих в практической деятельности.

Занятия Школы проводятся на базе Лаборатории по отработке навыков ГомГМК в форме тренинга и носят циклический характер. Тренинг включает 2 занятия и проводится в течение двух дней. Каждое занятие состоит из нескольких блоков: небольшой лекции с постановкой ситуационной задачи, обсуждения этой задачи и демонстрации ее решения.

Работают 4 команды ВОП. В состав каждой команды входят врач-интерн (или старшекурсник ГомГМУ), будущий помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи (учащийся выпускного курса медицинского колледжа специальности «Лечебное дело») и будущая медицинская сестра (учащийся выпускного курса специальности «Сестринское дело»).

В качестве стандартизированных пациентов в тренинге участвуют тьюторы Лаборатории по отработке навыков колледжа (специально подготовленные учащиеся колледжа, исполняющие роли пациентов и их родственников согласно сценарию).

Действия команды оценивают члены экспертной комиссии, которыми являются руководители Школы, специалисты практического здравоохранения и ведущие преподаватели кафедры поликлинической терапии ГомГМУ и ГомГМК.

За ходом тренинга следят старшекурсники медицинского университета и медицинского колледжа. Они имеют возможность принимать участие в обсуждении и задавать возникающие в ходе тренинга вопросы.

Анализ деятельности и контроль качества обучения в Школе осуществляется руководителями Школы по итогам года.

Цели и задачи тренинга:

адаптация будущих членов команды ВОП в команде, их самоутверждение, самосовершенствование и формирование профессиональных умений и навыков;

оптимальное распределение должностных обязанностей между членами команды в соответствии с выполняемыми ими функциями;

обеспечение продуктивного взаимодействия будущих членов команды ВОП в совместной деятельности по обеспечению доступной и качественной медицинской помощи пациентам;

предупреждение типичных ошибок, противоречий и затруднений в организации работы команды ВОП, поиск возможных путей их преодоления;

подготовка членов команды ВОП к оперативному решению задач, возникающих в практической деятельности.

В ходе тренинга рассматриваются различные вопросы оказания первичной медицинской помощи командой ВОП в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения, демонстрируются варианты решения ситуационных задач, практические навыки выполнения медицинских манипуляций.

Каждое занятие тренинга разделено на 4 блока по 45 мин (общая длительность занятия – 3 часа).

Программа занятий Школы постоянно совершенствуется. Так в апреле 2023 года в программу был включен практический этап «Обучение родственников уходу за пациентом в рамках паллиативной помощи», предполагающий демонстрацию выполнения медицинских манипуляций учащимися ГомГМК, участвующими в тренинге в качестве медицинской сестры и помощника врача общей практики. Учащиеся не просто выполняют манипуляции, определенные программой тренинга, но и подробно объясняют алгоритм и правила их выполнения, обучают «родственников пациента», в роли которых на данном этапе тренинга выступают врачи-интерны команд.

С января 2024 года в программу Школы включены симуляционные тренинги по оказанию неотложной помощи командой ВОП – «Оказание медицинской помощи командой врача общей практики при внезапной сердечной смерти» и «Оказание медицинской помощи командой врача общей практики при остром коронарном синдроме».

С целью изучения результативности проведения семинаров-тренингов Школы, нами было проведено анкетирование участников и присутствующих на занятиях старшекурсников медицинского колледжа. В анкетировании приняли участие 52 участника тренингов и 148 старшекурсников колледжа специальности «Лечебное дело» и «Сестринское дело».

По мнению абсолютного большинства участников тренинга, занятия Школы

систематизируют знания и практические навыки, полученные во время учебы, дают возможность окунуться в профессиональную среду, по-новому взглянуть на особенности взаимоотношений с будущими коллегами и с пациентами, способствует умению концентрироваться, повышению уровня профессиональных знаний, умений и навыков, коммуникативной компетентности. Особый интерес у большинства участников вызывают симуляционные тренинги по оказанию неотложной помощи и паллиативной помощи. Так же абсолютное большинство участников тренинга благодарны за возможность принять участие в работе Школы и считают этот опыт очень полезным для себя. Кроме того, считают, что занятия Школы команды ВОП в целом нужны на этапе обучения и профессионального становления медицинского специалиста.

Присутствующие на занятиях Школы и наблюдавшие за ходом занятий старшекурсники медицинского колледжа считают данный опыт очень полезным для себя (89% респондентов), хотели бы принимать непосредственное участие в тренингах (78% респондентов), считают, что данные занятия нужно проводить с учащимися колледжа всех специальностей (48% респондентов).

Заключение

Подводя итог, нужно отметить, что совместный образовательный проект «Школа команды врача общей практики» является уникальным и актуальным. Практика показывает, что реализация данного проекта укрепляет профессиональные компетенции и готовность специалистов, способствует развитию социально-коммуникативных навыков медработников, формированию алгоритмов эффективного взаимодействия в команде. А также готовит членов команды ВОП к оперативному решению задач, возникающих в практической деятельности уже на этапе обучения в медицинском колледже и университете.

Проект продолжает работу и будет развиваться и в текущем учебном году. Составлен план проведения семинаров-тренингов. В рамках реализации данного проекта планируется внедрение новых форм взаимодействия между УО «Гомельский государственный медицинский колледж» и УО «Гомельский государственный медицинский университет».

Список использованных источников:

1. Внедрение института врача общей практики практически завершено – Минздрав [Электронный ресурс] / Нац. Центр прав.информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. – Режим доступа: https://www.belta.by/society/view/vnedrenie-instituta-vracha-obschej-praktiki-prakticheski-zaversheno-minzdrav-427719-2021/. – Дата доступа: 08.06.2023.

2. Редненко, В.В. Симуляционные тренинги в медицине. Практическое руководство. / В.В.

Редненко [и др.]; под ред. А.Т. Щастного. – Витебск: ВГМУ, 2021. – 173 с.

3. Сущинский, В. Э. Организация работы в «команде» врача общей практики по оказанию первичной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических организациях Республики Беларусь: учебно-методическое пособие / В.Э Сущинский [и др.]. – Минск: БГМУ, 2020. – 185 с.

4. Щастный, А.Т. Биомедицинская этика и коммуникации в здравоохранении: учебно-методическое пособие / А.Т. Щастный [и др.]; под ред. А.Т. Щастного. – Витебск: ВГМУ, 2018. – 310 с.

5. Яромич, И.В. Сестринское дело и манипуляционная техника. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 330 с.

Опыт кокшетауского высшего медицинского колледжа по организации трудоустройства выпускников колледжа

Махметова Гульмира

Заместитель директора по УПР, Кокшетауский высший медицинский колледж

Аңдатпа

Мақалада Көкшетау жоғары медицина колледжінің түлектерді жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу тәжірибесі қарастырылады. Колледждің медициналық ұйымдармен өзара іс-қимылының негізгі бағыттары, жас мамандарды қолдау түрлері және соңғы жылдардағы түлектердің жұмыспен қамтылуын мониторингтеу нәтижелері ұсынылған.

Аннотация

В статье рассматривается опыт работы Кокшетауского высшего медицинского колледжа по содействию трудоустройству выпускников. Представлены основные направления взаимодействия колледжа с медицинскими организациями, формы поддержки молодых специалистов, а также результаты мониторинга занятости выпускников за последние годы.

Annotation

The article examines the experience of Kokshetau Higher Medical College in facilitating the employment of graduates. It presents key directions of cooperation with healthcare organizations, support mechanisms for young specialists, and employment monitoring results over recent years.

Түйінді сөздер: жұмыспен қамту, түлектер, медицина колледжі, бос жұмыс орындары жәрмеңкесі, жұмыспен қамтуды мониторингтеу.

Ключевые слова: трудоустройство, выпускники, медицинский колледж, ярмарка вакансий, мониторинг занятости.

Keywords: employment, graduates, medical college, job fair, employment monitoring.

Введение

Подготовка конкурентоспособных специалистов и их успешное трудоустройство является одной из приоритетных задач Кокшетауского высшего медицинского колледжа. В условиях реформирования здравоохранения и дефицита кадров особую значимость приобретает эффективное взаимодействие колледжей с социальными партнерами.

Основная часть

1. Организация работы по трудоустройству

В колледже создана система содействия трудоустройству выпускников, включающая:

• ведение базы данных выпускников и работодателей;

• информирование о вакантных должностях и кадровых потребностях медицинских организаций Акмолинской области;

• организацию дней открытых дверей -диалоговых площадок с представителями медицинских и иных организаций;

• проведение ежегодной «Ярмарки вакансий»;

• индивидуальное консультирование студентов и их родителей по вопросам трудоустройства;

• взаимодействие с управлением здравоохранения Акмолинской области.

2. Проведение ярмарки вакансий

Ежегодно в колледже проводится ярмарка вакансий выпускников, цель которой содействие трудоустройству выпускников — прямое взаимодействие работодателей и студентов [1]. Задача работодателей - подобрать перспективных молодых специалистов, согласно условиям труда и социальных гарантий. Гарантии, предоставляемые молодым специалистам, служат своевременная заработная плата, жилье (благоустроенное жилье, комната в общежитии, частный дом); подъемные средства 100 МРП.

На мероприятие приглашаются главные врачи, руководители сестринских служб, руководители службы управления человеческими ресурсами, представители частных клиник и аптечных сетей.

Результатом становится выдача ходатайств о трудоустройстве, а также распределение выпускников на производственную и преддипломную практики по месту будущего трудоустройства. Преимущества прохождения практики по месту будущего трудоустройства: студент заранее знакомится с коллективом, работает в реальной

условиях, применяя свои компетенции, полученные в колледже; формируется дисциплина, уверенность и чувство ответственности как медицинского работника; получает опыт под руководством ментора, что ускоряет профессиональное становление [2,3].

3. Мониторинг трудоустройства

В колледже ведётся постоянный мониторинг занятости, так по итогам 2024–2025 учебного года: выпущено 440 специалистов; из них трудоустроены по специальности 381 (87%); продолжает обучение в вузах 36 (8%), призванные в вооруженные силы Республики Казахстан 3 (1%), находятся в декретном отпуске 18 (18%) [4].

Мониторинг проводится в тесном взаимодействии с медицинскими организациями по каждой специальности и включает подтверждение прибытия выпускников к месту работы согласно удостоверению о направлении на трудоустройство, выданному колледжем вместе с дипломом.

4. Результаты и перспективы

Опыт колледжа показывает, что системный подход к организации трудоустройства обеспечивает высокий уровень занятости выпускников. Планируется дальнейшее развитие цифровых инструментов (онлайн-платформа вакансий), усиление профориентационной работы.

Заключение

Организация эффективного трудоустройства выпускников — важная составляющая качества образовательного процесса. Опыт Кокшетауского высшего медицинского колледжа демонстрирует, что сотрудничество с работодателями, проведение диалоговых площадок, ярмарок вакансий и мониторинг занятости способствуют успешной интеграции молодых специалистов в систему здравоохранения.

Список использованных источников:

1. Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 г. № 360-VI ЗРК. Статьи 238-240

2. Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 г. № 319- III статья 47, пункт 17

3. Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан.

4. Материалы педагогического совета ГККП «Кокшетауский высший медицинский колледж», 2024–2025 гг.

Стрессоустойчивость, как важный фактор эффективной профессиональной

деятельности и сохранения профессионального долголетия медицинских работников среднего звена

Курзанова Светлана[1], Куликова Марина[2]

[1] Руководитель практики, [2] методист

Гомельский государственный медицинский колледж

Аннотация

В работе рассмотрены вопросы механизма возникновения стресса, причин и результатов воздействия его на организм с целью изучения проблемы влияния стресса на профессиональную деятельность медицинских работников среднего звена. Проанализированы и описаны результаты собственного исследования, которое было проведено преподавателем и учащимися специальности «Сестринское дело» во время прохождения учебной практики в учреждениях здравоохранения г. Гомеля.

Ключевые слова: *стресс, стрессоустойчивость, медицинский работник, пациент, профессиональное долголетие.*

Введение

Профессиональная деятельность медицинского работника заключается в удовлетворении потребностей человека при их частичном или полном отсутствии, снижении качества жизни пациента. В медицинской сестре (брате), фельдшере, принимающих активное участие в лечебном процессе, пациенты нередко видят не только человека, облегчающего своими действиями физическое состояние. Именно с ней (ним) хочется поделиться своими переживаниями, возникающими при медицинском вмешательстве, а порой и переживаниями из личной жизни, порожденными болезнью. От качества и полноты оказанной медицинской помощи зависит успех всего лечебного процесса, важным условием обеспечения которого является умение медицинской сестры (брата), фельдшера установить с пациентом эмоциональный контакт, вызывать у него чувство уверенности и надежду на выздоровление.

Взаимодействие с пациентами (оказание медицинской помощи, выполнение медицинских манипуляций) подразумевает большую физическую и психологическую нагрузку медицинского работника, что может способствовать развитию стресса. Стресс является одним из состояний психического напряжения. Он же и является составной частью жизни каждого человека, и без него нельзя обойтись так же, как без еды и питья.

Стресс влияет на душевное и физическое состояние человека. Если умеренный стресс полезен и помогает нам выполнять повседневные задачи, то избыточный стресс может вызывать физические и психические расстройства. Поэтому важно обучать будущих медицинских работников навыкам преодоления стресса, что помогает

уменьшить чувство растерянности перед трудной ситуацией и благоприятно влияет на психическое и физическое самочувствие.

Материалы и методы исследования – анализ научно-практической и методической литературы по проблематике исследования, анкетирование с последующей обработкой результатов, системный контроль ЧСС и АД.

Результаты исследования и их обсуждение

С целью изучения проблемы влияния стресса на профессиональную деятельность медицинской сестры (брата), учащимися Гомельского медицинского колледжа под руководством преподавателя было проведено исследование: изучение механизма возникновения стресса, определение причин и результатов воздействия его на организм.

Исследование проводилось на базе организации здравоохранения г. Гомеля. В исследовании приняли участие 50 медицинских сестер в возрасте от 21 до 62 лет.

Было проведено анонимное анкетирование с последующим анализом результатов. Для определения воздействия стрессовых факторов на организм, в частности на ССС проводился контроль ЧСС и АД ежедневно в начале и в конце рабочей смены в течение всего периода исследования. В результате наших исследований было установлено, что значения пульса и артериального давления у медицинских сестер к концу смены повышаются.

На вопрос «Часто ли Вы подвергаетесь стрессу?» утвердительно ответили все опрошенные медицинские работники. Причинами стресса были названы: большая нагрузка на работе – 60%, семейные проблемы – 6%, проблемные пациенты – 20%, проблемы в личной жизни – 8%, конфликты в коллективе – 2%. Как видно по результатам опроса, причины проявления стресса разнообразны, но основной является большая нагрузка на работе. Необходимо уметь правильно распределять свое рабочее время и отдых, избегать постоянных переработок. Нельзя работать «на износ», − он наступит быстрее, чем вы можете предположить.

Так же медицинские сестры отметили первопричину стресса в «проблемных» пациентах. Пациенты бывают разные и к каждому очень важно найти правильный подход. При установлении контакта с пациентом необходимо выяснить его проблемы, учитывать как внешнюю, так и внутреннюю картину заболевания.

В течение рабочего времени, медсестры отмечают раздражительность (40% опрошенных), состояние депрессии (30%), а также отмечается нежелание работать (14%), рассеянность (12%) и редко (4%) – грубость в отношении к пациентам. Невнимательность, рассеянность может навредить здоровью пациента, ухудшить его не только физическое, но и психическое состояние. А, как мы знаем, медицина ошибок не прощает. Т.о. мы

можем говорить о том, что состояния раздражительности, депрессии (причинами могут быть так же бытовые проблемы) резко снижают работоспособность медицинской сестры, что может негативно повлиять пациента и заметно ухудшить результаты лечения.

В результате воздействия стрессоров индивид нередко пытается искусственно заместить испытываемые негативные ощущения «приятными» внешними факторами: начинает переедать, совершает рискованные, импульсивные действия. Наше исследование показало, что большинство опрошенных «заедают» свой стресс (44% респондентов), что может привести к негативным последствиям. Общение с друзьями помогает 10% респондентов. Спорт, прогулки на свежем воздухе жизни помогают справиться с влиянием стресса на организм у 40% опрошенных медицинских сестер. Предпочитают обращаться за психологической помощью к специалисту 6% опрошенных.

На вопрос «Употребляете ли Вы алкоголь, как средство для снятия стресса?» дали отрицательный ответ 100% опрошенных.

Все мы разные и у каждого сформированы свои шаблоны мышления и поведения. У каждого свой жизненный опыт, и у каждого собственное отношение к возникающим ситуациям. Проявления стрессового состояния – сугубо индивидуальны.

Заключение

В результате изучения механизма развития стресса и анализируя ответы медицинских работников, принявших участие в исследовании, можем говорить о том, что, медицинские работники при выполнении профессиональных обязанностей в высокой степени подвержены стрессу. Важно знать правильную тактику предупреждения и «снятия» стресса. Медицинским сестрам (братьям) организации здравоохранения была предложена информация о правилах, которым нужно следовать, что бы сохранить эмоциональное благополучие и профессиональное долголетие:

- Сбалансировать время труда и отдыха.
- Рациональное питание.
- Регулярно заниматься физической культурой и спортом.
- Найти себе хобби.
- Работу оставлять на работе, бытовые проблемы – за стенами организации здравоохранения.
- К каждому пациенту находить индивидуальный подход.
- Принимать участие в общественных мероприятиях.
- Прежде, чем делать какие-либо выводы, подробно проанализировать возникшую ситуацию.

Важным результатом данной работы является и то, что учащиеся, принявшие

участие в работе, получили неоценимый опыт, знания и понимание исследуемой проблемы. Участие в исследовании дало возможность по-новому взглянуть на особенности медицинской профессии, в частности на ее сложность и профессиональные риски и позволит им в дальнейшем уметь сохранять эмоциональную стабильность в процессе своей профессиональной деятельности.

Список использованных источников:

1. Аболин, Л.М. Психологические механизмы эмоциональной устойчивости человека / Л.М. Аболин. – Казань: АСАм, 2001. – 195 с.

2. Бычкова, В.С. Самооценка стрессоустойчивости личности / В.С.Бычкова, Ж.А. Мелконян // Вестник научных конференций. – 2019. – № 3–3 (43). – С. 44–46.

3. Дюкова, А.М. Проблема стрессоустойчивости в современной психологии / А.М. Дюкова // В сборнике: Проблемы конфликторазрешения в современном обществе. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Юго-Западный государственный университет. – Курск, 2020. – С. 134–136.

4. Чернова, А.Д. Развитие стрессоустойчивости при учете когнитивных стилей / А.Д. Чернова // Студенческий вестник. – 2020. – № 29-1 (128). – С. 28–29.

Сестринское дело в онкологии: практика, сопровождение, лидерская позиция в мультидисциплинарной команде

Байгульжина Жазира[1], Сейсембекова Маншук[2], Жумагалиева Асия[2]

[1] Заместитель директора по учебно-воспитательной работе,

[2]преподаватель специальных дисциплин, магистр

Павлодарский медицинский высший колледж

Аннотация. *В статье рассматриваются ключевые аспекты сестринской деятельности в онкологии: организация ухода, сопровождение пациента на всех этапах лечения, а также лидерская роль медицинской сестры в мультидисциплинарной команде. Подчёркивается значение коммуникативной и клинической компетентности медсестры, а также важность её участия в принятии решений.*

Ключевые слова*: сестринское дело, онкология, сопровождение пациента, лидерство, медицинская сестра, медицинский колледж, доказательная практика.*

Аңдатпа. *Мақалада онкология саласындағы мейіргерлік қызметтің негізгі аспектілері қарастырылады: науқасқа күтім ұйымдастыру, емдеу кезеңдеріндегі*

кешенді сүйемелдеу және мультидисциплинарлық топтағы медбикенің көшбасшылық рөлі. Мейіргердің коммуникативтік және клиникалық құзыреттілігі, шешім қабылдауға қатысуы ерекше атап өтіледі.

***Түйінді сөздер**: мейіргерлік іс, онкология, науқасты сүйемелдеу, көшбасшылық, мейірбике, медицина колледжі, дәлелді тәжірибе.*

***Abstract**. The article explores key aspects of nursing in oncology, including patient care management, support throughout all treatment stages, and the leadership role of nurses within a multidisciplinary team. Emphasis is placed on the nurse's communication and clinical competencies, as well as their involvement in decision-making processes.*

***Keywords**: nursing, oncology, patient support, leadership, nurse, medical college, evidence-based practice.*

Введение

Онкологические заболевания остаются одной из ведущих причин смертности во всем мире, в том числе и в Казахстане. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно диагностируется более 19 миллионов новых случаев злокачественных опухолей, и этот показатель продолжает расти. В таких условиях перед системой здравоохранения стоит задача не только своевременной диагностики и лечения, но и комплексного сопровождения пациентов, включающего психологическую, социальную и паллиативную помощь.

В центре этих процессов находится медицинская сестра. Именно она чаще всего проводит с пациентом больше времени, чем другие члены команды, является связующим звеном между врачами, родственниками и самим пациентом. Сегодня медицинская сестра-это не только исполнитель назначений врача, но и активный участник лечебного процесса, а в ряде направлений - лидер в организации ухода.

Практика сестринского дела в онкологии

Сестринская практика в онкологии имеет ряд особенностей, отличающих её от работы в других областях медицины.

1. Уход за пациентами, получающими противоопухолевое лечение

- Подготовка пациента к химиотерапии, лучевой терапии, хирургическому лечению.

- Контроль состояния пациента во время инфузионных процедур и наблюдение за возможными осложнениями.

- Обеспечение безопасного обращения с цитостатическими препаратами.

2. Контроль симптомов и осложнений

- Купирование боли, тошноты, рвоты, слабости, нарушений сна.

- Работа с последствиями лечения: алопеция, мукозиты, периферическая нейропатия, лимфостаз.

- Ведение пациентов в период ремиссии и рецидива.

3. Психоэмоциональная поддержка

- Построение доверительных отношений.

- Поддержка пациента в сложных жизненных обстоятельствах.

- Проявление гуманности и эмпатии.

Сопровождение пациента. Онкологическое заболевание- это не только медицинский диагноз, но и глубокое жизненное испытание. Современная модель сестринской помощи ориентируется на сопровождение пациента на всех этапах [1, с. 75].

Этапы сопровождения:

1. Диагностический этап: информирование пациента, обучение навыкам самоухода, поддержка семьи.

2. Лечение: контроль за назначениями, оценка побочных эффектов, индивидуальный сестринский процесс.

3. Реабилитация: помощь в восстановлении активности, обучение адаптации, работа с родственниками.

4. Паллиативная помощь: обеспечение качества жизни, купирование боли, поддержка семьи.

Лидерская позиция медсестры в мультидисциплинарной команде

Современная онкология строится на принципах мультидисциплинарности. В команде работают онкологи, хирурги, радиологи, психологи, социальные работники. Однако роль медицинской сестры в этой системе особая.

Основные аспекты лидерства медсестры:

- Координация ухода и взаимодействие с командой.

- Просветительская работа с пациентами и их семьями.

- Клиническая экспертиза и принятие решений в рамках компетенции.

- Эмоциональное лидерство и снижение тревожности пациента [2, с. 93].

В Казахстане активно внедряются международные стандарты сестринской практики, развивается высшее сестринское образование, что создаёт условия для укрепления лидерской позиции медсестры.

Роль медицинского колледжа в развитии онкологического сестринского дела

Медицинский колледж играет ключевую роль в подготовке кадров для практического здравоохранения, в том числе для онкологической службы. В условиях роста онкологической заболеваемости именно система среднего медицинского образования становится фундаментом качественного ухода за пациентами.

Основные направления деятельности колледжа:

1. Образовательная подготовка: включение модулей по онкологии, обучение алгоритмам сестринского процесса.

2. Симуляционное обучение: использование тренажёров и клинических ситуаций.

3. Формирование лидерских качеств: развитие инициативности и ответственности.

4. Научно-исследовательская деятельность: участие студентов и преподавателей в исследованиях и конференциях.

5. Партнёрство с клиническими базами: практика на базе онкологических диспансеров, сотрудничество с врачами.

Таким образом, колледж является не только учебным заведением, но и центром развития онкологического сестринства, соединяющим образование, практику и научную деятельность.

Преподавательский аспект

Как преподаватель медицинского колледжа, я считаю важным подчеркнуть:

- обучение будущих медсестер должно включать специальные модули по онкологии;

- практические занятия необходимо проводить с использованием симуляционных технологий;

- необходимо формировать коммуникативные навыки и умение работать в команде;

- важно развивать лидерские качества у студентов.

Заключение

Сестринское дело в онкологии — это сложная и ответственная область медицины, где профессионализм сочетается с высоким уровнем человечности. Практическая работа, сопровождение пациента и лидерская позиция медсестры в мультидисциплинарной команде формируют основу эффективного противоракового лечения.

Сегодня от преподавателей зависит подготовка нового поколения медсестёр, способных не только выполнять назначения, но и вести пациента, быть для него опорой и лидером в команде. Развитие сестринского дела в онкологии — это путь к повышению качества жизни пациентов и укреплению системы здравоохранения Казахстана.

Список использованных источников:

1. Гончарова Н. А. Сестринский уход в онкологии: учебное пособие. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 208 с.

2. WHO Cancer Fact Sheet – World Health Organization, 2023. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer.

3. Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года №360-VI ЗРК.

4. Серикова Л. Б. Роль медсестры в мультидисциплинарной команде при оказании паллиативной помощи // Сестринское дело. – 2022. – №3. – С. 45–48.

5. Джунусова Г. Е. Современные подходы к подготовке медицинских сестёр в условиях реформы здравоохранения Республики Казахстан // Медицинское образование и наука. – 2021. – №2. – С. 12–16.

Опыт интеграции сестринских исследований в образовательном процессе прикладного бакалавриата: формирование профессиональных и исследовательских компетенций у студентов

The experience of integrating nursing research into the educational process of an applied bachelor's degree: the formation of professional and research competencies among students

Мокрова Инна

Педагог-исследователь, Кокшетауский высший медицинский колледж

Аңдатпа

Мақалада мейірбике ісінің қолданбалы бакалаврларын даярлауға зерттеу қызметін интеграциялау тәжірибесі ұсынылған, ол бірінші курстан бастап бейіндік пәндерді оқу, курстық және дипломдық жұмыстарды орындау, конференцияларға қатысу және зерттеу нәтижелерін практикаға енгізу арқылы жүзеге асырылады. Зерттеу құзыреттіліктерін қалыптастыру кезеңдері, іске асырылған жобалардың мысалдары және өңірдің медициналық ұйымдарымен өзара іс-қимыл нысандары сипатталған. Зерттеулердің практикалық маңыздылығына және олардың мейірбикелік көмек сапасына әсеріне ерекше назар аударылады. Орта медициналық білім беру жүйесінде дәлелді мейіргерлік практиканы дамытудың қазіргі проблемалары мен перспективалары айқындалды.

Түйіндісөздер: *зерттеу құзыреттілігі, мейірбикелік зерттеулер, дәлелді практика.*

Аннотация

В статье представлен опыт интеграции исследовательской деятельности в подготовку прикладных бакалавров сестринского дела, которая осуществляется с первых курсов обучения через изучение профильных дисциплин, выполнение курсовых и дипломных работ, участие в конференциях и внедрение результатов исследований в практику. Описаны этапы формирования исследовательских компетенций, примеры реализованных проектов и формы взаимодействия с медицинскими организациями региона. Особое внимание уделено практической значимости исследований и их влиянию на качество сестринской помощи. Выделены существующие проблемы и перспективы развития доказательной сестринской практики в системе среднего медицинского образования.

Ключевые слова: *исследовательские компетенции, сестринские исследования, доказательная практика.*

Annotation

The article presents the experience of integrating research activities into the preparation of applied bachelor's degrees in nursing, which is carried out from the first years of study through the study of specialized disciplines, the completion of term papers and theses,

participation in conferences and the implementation of research results in practice. The stages of formation of research competencies, examples of implemented projects and forms of interaction with medical organizations in the region are described. Special attention is paid to the practical significance of research and its impact on the quality of nursing care. The existing problems and prospects for the development of evidence-based nursing practice in the secondary medical education system are highlighted.

Keywords: *research competencies, nursing research, evidence-based practice.*

В современных условиях развитие сестринского дела неразрывно связано с повышением роли научных исследований в клинической практике. Сестринские исследования являются важным компонентом системы здравоохранения, направленным на получение фактических данных для улучшения результатов ведения пациентов, совершенствования сестринской практики и внесения вклада в развитие здравоохранения. Согласно рекомендациям ВОЗ, сестринские кадры должны обладать не только клиническими и коммуникативными компетенциями, но и исследовательскими, позволяющими продвигать принципы доказательной медицины в повседневную практику.

На протяжении всего учебного периода в рамках освоения образовательных курсов, студенты прикладного бакалавриата Кокшетауского высшего медицинского колледжа делают эффективные шаги в практике исследований в рамках компетенций:

ПК-2. Научный подход и доказательная сестринская практика;

ПК-2.1 Интерпретация информации и принятие решений, основанных на доказательствах;

ПК-2.2 Планирование и осуществление сестринских исследовательских проектов;

ПК-2.3 Эффективное распространение результатов научных исследований. Исследовательские проекты носят фундаментально-прикладной характер и направлены на перспективное формирование компетенций в рамках организации процесса научных исследований, планирования/реализации исследовательских проектов и интеграции результатов научных исследований в клинической практике.

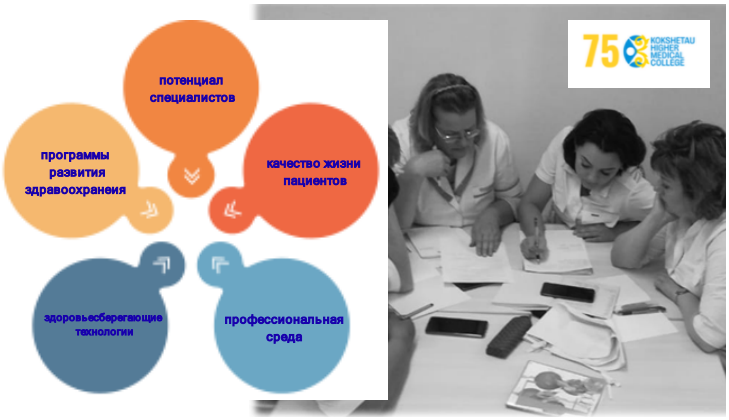
Развитие профессиональных компетенций прикладных бакалавров сестринского дела в акцентной области научного подхода и доказательной сестринской практики, формируется с первого курса обучения, опосредовано при освоении каждой дисциплины и целенаправленно в таких, как «Принципы планирования и проведения исследований в сестринском деле», «Биостатистика и оформление результатов

исследовательской работы», «Выполнение курсовой работы» и «Доказательная сестринская практика» [1, с. 33].

Выбор проблемы исследования всегда является ответственным и сложным моментом. Для студентов со сроком обучения 3,5 года отправными ориентирами для начала исследования являются опыт клинического обучения при прохождении практики, который помогает им определить/увидеть проблему, что определит основу будущей исследовательской работы. Студенты, обучающиеся по ускоренной траектории 1,5 года, имеющие базовое профессиональное образование и практический опыт, рассматривают возможности улучшения собственной практики в рамках качественного пациент-ориентированного ухода улучшения качества жизни пациента и в целом сестринского процесса.

Важно, что темы курсовых работ обсуждаются/согласуются совместно с высококвалифицированными специалистами медицинских организаций – социальными партнерами, заинтересованными в объективных исследованиях и трудоустройстве выпускников [1, с. 124]. Весомым направлением сотрудничества является участие коллег практического здравоохранения в качестве рецензентов и научных руководителей. В реализацию дипломных исследовательских проектов вовлечены медицинские организации Акмолинской области. Курсовые исследовательские работы представляют собой консолидацию результатов самостоятельного исследования студентов актуальных проблем в области избранной специальности (рис.1).

Рисунок 1



Уровень сформированности профессиональных компетенций выпускников прикладного бакалавриата определяется по итогам защиты курсовых проектов и как следствие общие итоги независимой экзаменации. В конечном итоге результаты исследования носят опытно-практическую, опытно-экспериментальную, теоретическую направленность и являются критерием профессиональной подготовки к

самостоятельной трудовой деятельности.

Сегодня сестринскому сообществу важно осуществлять научный поиск, доказывать эффективность сестринских практик и внедрять полученные результаты в ежедневную практику. Успешное продвижение научных идей начинается в рамках микро проектов, курсовых работ, защите клинической практик, конференциях научно-исследовательских работ (НИР) на уровне колледжа, области, государства и международном уровне.

Результаты большей части исследовательских работ имеют своё продолжение в написании статей и выпуске их в печатных изданиях областного, республиканского и международного уровня. Одним из примеров практического применения результатов исследования являются «Рекомендации по профилактике предопухолевых и опухолевых заболеваний молочной железы» внедренные в ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» г. Кокшетау с целью повышения охвата скринингом целевой группы женщин, исследователем и разработчиком является Новокрещенова Г.В. Практическую значимость (акты внедрения, информационные сайты) имеют результаты состоявшихся дипломных проектов:

- ✓ Мусенова Р. Д. - «Транспортировка пациентов с психическими заболеваниями на этапе скорой помощи», научный руководитель Дыдыгина Е.О.;
- ✓ Пригородовой Н. В. - «Вопросы профилактики варикозного расширения вен у медицинских сестер операционного блока», научный руководитель Ярошинская И.К.;
- ✓ Лойченко Е. В. - «Психологические аспекты работы с пациентами при проведении МРТ», научный руководитель Ярошинская И.К.;
- ✓ Солониной Е. Н. - «Анализ самооценки сестринского сообщества многопрофильной областной больницы в рамках удовлетворенности профессией», научный руководитель Мокрова И.И.;
- ✓ Хусаиновой К. К. - «Особенность деятельности медицинской сестры в эндоскопическом исследовании», научный руководитель Дыдыгина Е.О.

Подводя итог можно уверенно утверждать, что система формирования профессиональных и исследовательских компетенций выстроена поэтапно и даёт ощутимые результаты - выпускники приобретают исследовательские умения, критическое мышление и навыки доказательной практики. Тем не менее, есть потенциал для углубления методологической подготовки и повышения качества реальных результатов. Наряду с этим сохраняются проблемы:

- Низкая потребность медицинских организаций в сестринских исследованиях.

-Отсутствие заинтересованности сестринской службы МО в проведении исследований, внедрении результатов и коммерциализации.

- Теоретизация исследовательских работ.

- Недостаточный уровень академической честности и приверженности этическим аспектам исследовательской работы.

Качество сестринской практики, престиж профессии медицинской сестры напрямую зависит от уровня сестринской науки. Развитие доказательной сестринской практики позволяет непрерывно оценивать свою деятельность в поиске новых эффективных и успешных способов выполнения своей работы. В поиске качества и доступности медицинской помощи мы должны постоянно стремиться к реализации в сестринской практике научно-обоснованных подходов.

Список использованных источников:

1. Руководство для высших медицинских колледжей в вопросах реализации программы прикладного бакалавриата, Астана, 2019 г.

2. Методические рекомендации по реализации пилотного проекта по внедрению прикладного бакалавриата в организациях высшего и послевузовского образования. Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан Национальный центр развития высшего образования. Астана 2023 г.

Практико-ориентированное сестринское исследование влияния диспансеризации на снижение нагрузки служб экстренной помощи

Головина Оксана[1], Дыдыгина Елена[2], Досмұқан Алуа

[1] Педагог- мастер, [2] педагог – исследователь, студентка

Кокшетауский высший медицинский колледж

Аннотация.

В статье представлены результаты сестринского исследования, направленного на оценку эффективности диспансеризации пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями в контексте снижения обращаемости за экстренной медицинской помощью. Проведён анализ взаимосвязи между охватом диспансерным наблюдением и частотой вызовов скорой помощи на основании отчётных данных медицинской организации. Установлено, что активное участие медицинских сестёр в информировании, консультировании и сопровождении пациентов способствует повышению приверженности диспансеризации, снижению числа обострений хронических заболеваний и уменьшению

нагрузки на службы неотложной помощи.

Ключевые слова: сестринские исследования, диспансеризация, профилактика, хронические заболевания, экстренная медицинская помощь, приверженность лечению.

Введение.

В Республике Казахстан ежегодно фиксируется более семи миллионов вызовов скорой помощи, значительная часть которых связана с обострениями хронических заболеваний. В 2022 году в рамках диспансеризации было выявлено свыше 540 тысяч случаев заболеваний, что подтверждает высокую эффективность профилактических осмотров. Однако нерегулярное наблюдение пациентов приводит к запущенным состояниям и росту экстренных обращений. Системная и качественная диспансеризация позволяет своевременно выявлять заболевания, корректировать лечение и снижать нагрузку на службы экстренной помощи. В этом процессе ключевую роль играют специалисты сестринского дела, обеспечивающие постоянное взаимодействие между пациентом и системой здравоохранения.

Гипотеза исследования: систематическая диспансеризация при активном сестринском сопровождении способствует снижению числа экстренных обращений за счет организации контроля над заболеванием и вовлечения пациента и родственников.

Исследовательский вопрос: как диспансеризация пациентов с артериальной гипертензией влияет на частоту случаев экстренных вызовов, и каким образом сестринское консультирование повышает её эффективность?

Цель: оценить влияние системной диспансеризации на снижение потребности в экстренной медицинской помощи и определить роль сестринских вмешательств в этом процессе.

Задачи:

1. Изучить понятие и цели диспансеризации, обозначить роль медицинской сестры расширенной практики в её организации.
2. Определить основные причины, снижающие приверженность пациентов к диспансеризации.
3. Проанализировать взаимосвязь между уровнем диспансеризации и частотой вызовов скорой медицинской помощи.

Материалы и методы.

В исследовании использованы:

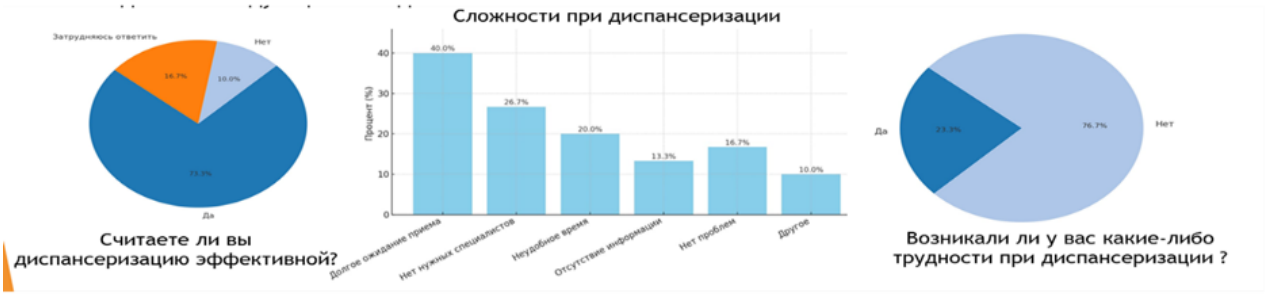
- ✓ отчетные данные ТОО ‘Viamedis’ о диспансеризации пациентов и вызовах скорой помощи;
- ✓ клинические сестринские руководства;

✓ результаты анкетирования пациентов с артериальной гипертензией с использованием платформы *Google Forms*;

✓ литературные источники по организации профилактической работы

Проанализированы данные за 9 месяцев 2024 года по группам риска (артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, их сочетания). Сопоставлены плановые и фактические показатели диспансеризации и динамика вызовов скорой помощи.

Анкетирование: Основными источниками информации стали респонденты от 18- 60 лет находящиеся на диспансерном учете по сердечно -сосудистым заболеваниями. Путем анкетирования были сделаны следующие выводы

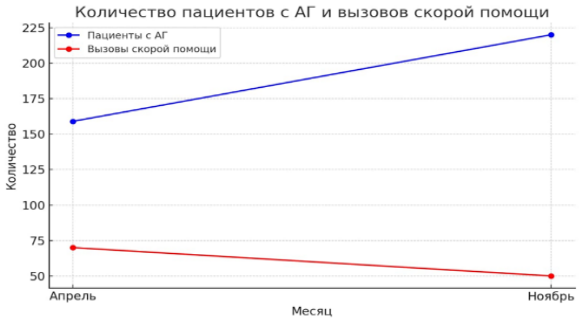


Примечание - [составлено автором]

1.Анкетирование показало, что пациенты в целом положительно относятся к диспансерному наблюдению.

2.Отмечена важность сестринского участия в информировании, мотивации и сопровождении пациентов.

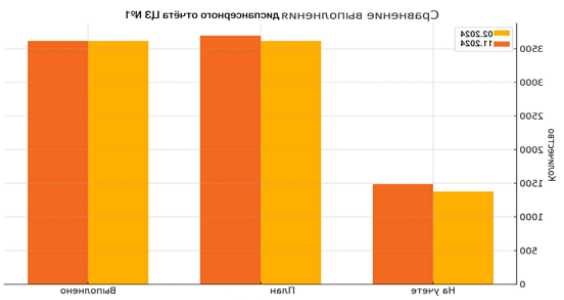
3.Роль медицинской сестры является ключевой: от качества её работы зависит соблюдение рекомендаций и уровень доверия к системе наблюдения в целом



- Синяя линия на графике показывает рост числа пациентов, взятых под наблюдение.

Красная линия показывает снижение количества вызовов скорой помощи, особенно по 4 категории, которая включает вызовы без угрозы жизни (например, резкое повышение давления

Результаты работы диспансерного кабинета :



1.Отмечается рост числа пациентов, вовлеченных в диспансеризацию в течение 9 месяцев

2.Диспансеризация способствовала увеличению охвата медицинским наблюдением пациентов с артериальной гипертензией.

3. План за 9 месяцев выполнен полностью, что отражает эффективность организации работы и достижение целевых индикаторов деятельности медицинской организации.

Показатель	Данные	Комментарий на основе статистических данных бюро национальнойй статистики агенства РК
Смертность от хронических неинфекционных заболеваний (ХНЗ)	>60% всех смертей	Особенно высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний —
Ожидаемая продолжительность жизни	~73 года	Ниже у пациентов с заболеваниями сердечно сосудистой системой
Рост вызовов скорой помощи	+15-20%	Немотивированный отказ от прикрепления к диспансерному кабинету
Общее количество вызовов скорой	>4,5 млн	Рекорд за последние 5 лет
Основные причины вызовов	Гипертонические кризы Острый коронарный синдром	30-40% можно предотвратить путем системного наблюдения медицинской сестрой расширенной практики

Данные демонстрируют значительную нагрузку на систему здравоохранения Казахстана, обусловленную высокой распространённостью хронических заболеваний и неотложных состояний.

Повышение уровня диспансеризации может существенно снизить смертность, уменьшить количество неотложных случаев и улучшить общее состояние здоровья населения.

Результаты исследования:

1. **Увеличение охвата диспансеризацией.** За период исследования количество пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении увеличилось на 40%. Это позволило выделить контингент пациентов с артериальной гипертензией для регулярного медицинского сопровождения.

2. **Снижение числа вызовов скорой помощи.** Количество вызовов по причине неосложнённого гипертонического криза снизилось на 38,4% - с 70 в апреле до 50 в ноябре 2024 года.

3. **Выраженная отрицательная зависимость.** Установлена корреляционная связь между ростом охвата диспансерным наблюдением и снижением числа вызовов скорой помощи ($r \approx -1$). Это подтверждает профилактический эффект диспансеризации.

4. **Роль медицинской сестры.** Анкетирование показало, что пациенты положительно оценивают сестринское сопровождение. Основные факторы успешности – своевременное информирование, доступность консультаций и индивидуальный подход.

Обсуждение

Результаты исследования подтверждают, что диспансеризация при участии специалистов сестринского дела способствует формированию у пациентов устойчивой приверженности лечению. Сестринское сопровождение, направленное на обучение пациентов, контроль выполнения рекомендаций и профилактику осложнений, обеспечивает снижение числа экстренных обращений и оптимизацию ресурсов здравоохранения. Так же выявлены проблемы, препятствующие вовлеченности пациентов в диспансеризацию: неудобное время приёма, дефицит информации, отсутствие и длительное ожидание приёма узких специалистов. Частично решение этих вопросов возможно через совершенствование организации сестринской службы и расширение функций медицинской сестры расширенной практики.

Заключение

Проведённое исследование подтверждает: эффективная диспансеризация с активным участием специалистов сестринского дела является важным инструментом профилактики экстренных состояний при хронических заболеваниях. Повышение охвата диспансерным наблюдением и развитие сестринского консультирования позволяют снизить нагрузку на службы экстренной помощи, улучшить качество жизни пациентов и укрепить профилактическое направление здравоохранения.

Список использованных источников:

1. Всемирная организация здравоохранения. Профилактика хронических заболеваний. – [Электронный ресурс]: https://www.who.int/health-topics/noncommunicable-diseases
2. Гусев А. Н. Общественное здоровье и здравоохранение. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 368 с.
3. Google Forms. Электронная платформа для анкетирования. – [Электронный ресурс]: https://docs.google.com/forms/
4. Журнал «Здравоохранение Казахстана». – [Электронный ресурс]: https://journal.zdrav.kz
5. Козлова Н. А. Сестринское дело в терапии. – М.: Академия, 2019. – 272 с.
6. Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10).
7. Министерство здравоохранения Республики Казахстан. – [Электронный ресурс]: https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm
8. Национальный центр общественного здравоохранения РК. – [Электронный ресурс]: https://hls.kz/

9. Национальные клинические протоколы Республики Казахстан. – [Электронный ресурс]: https://dsm.gov.kz/ru/pravila-i-protokoly
10. ТОО «Viamedis». Отчётные данные о диспансеризации и вызовах скорой помощи (внутренний документ).

Инновационные технологии в паллиативной помощи:
синтез науки, технологий и милосердия

Ковзалова Людмила Николаевна
Преподаватель специальных дисциплин, магистр
Северо-Казахстанский высший медицинский колледж имени Жұмағали Тлеулин

Аңдатпа

Мақалада паллиативті көмек жүйесінде қолданылатын заманауи инновациялы технологиялар қарастырылады. Олардың пациенттердің өмір сүру сапасын жақсартуға, физикалық және эмоционалдық азапты жеңілдетуге, сондай-ақ отбасыларға психоәлеуметтік қолдауды күшейтуге әсері қарастырылады. Паллиативті медицинадағы технологиялық прогресс адамгершілік, эмпатия және кәсіби этика қағидаларымен үйлесуі керек екендігі атап өтілді. Заманауи технологиялар адамның қатысуын және жанашырлығын алмастыру үшін емес, жекелендірілген және тиімді күтімге жағдай жасау құралы ретінде қарастырылады.

Түйінді сөздер: паллиативтік көмек, инновация, телемедицина, робототехника, жасанды интеллект, өмір сапасы.

Abstract

The article examines current innovative technologies used in the palliative care system. Their impact on improving the quality of life of patients, alleviating physical and emotional suffering, as well as strengthening psychosocial support for families is considered. It is emphasized that technological progress in palliative medicine should be combined with the principles of humanism, empathy and professional ethics. Modern technology is seen as a mean to foster conditions for more personalized and effective care, rather than a substitute for human participation and compassion.

Keywords: palliative care, innovation, telemedicine, robotics, artificial intelligence, quality of life.

Аннотация

В статье рассматриваются современные инновационные технологии, используемые в системе паллиативной помощи. Рассмотрено их влияние на повышение качества жизни пациентов, облегчение физических и эмоциональных страданий, а также на усиление психосоциальной поддержки семей. Подчёркивается, что технологический прогресс в паллиативной медицине должен сочетаться с принципами гуманизма, эмпатии и профессиональной этики. Современные технологии рассматриваются как средство, способствующее формированию условий для более персонализированного и эффективного ухода, а не как замена человеческому участию и состраданию.
Ключевые слова: паллиативная помощь, инновации, телемедицина, робототехника, искусственный интеллект, качество жизни.

Паллиативная медицина представляет собой особое направление здравоохранения, где научные знания, клинический опыт и достижения технологий сочетаются с гуманистическими ценностями [1, с. 12]. Это пространство профессиональной ответственности и милосердия, в котором технологии подчинены интересам человека. Главная цель паллиативной помощи заключается не в продлении жизни любой ценой, а в обеспечении её качества, облегчении страданий и поддержке пациента и его семьи в трудные периоды.

В условиях стремительного развития цифровых технологий паллиативная медицина получает новые ресурсы для повышения эффективности, доступности и непрерывности ухода. Инновационные решения позволяют специалистам быть ближе к пациенту, обеспечивая дистанционное наблюдение, консультирование и психологическую поддержку, независимо от территориальных границ [2, с. 41].

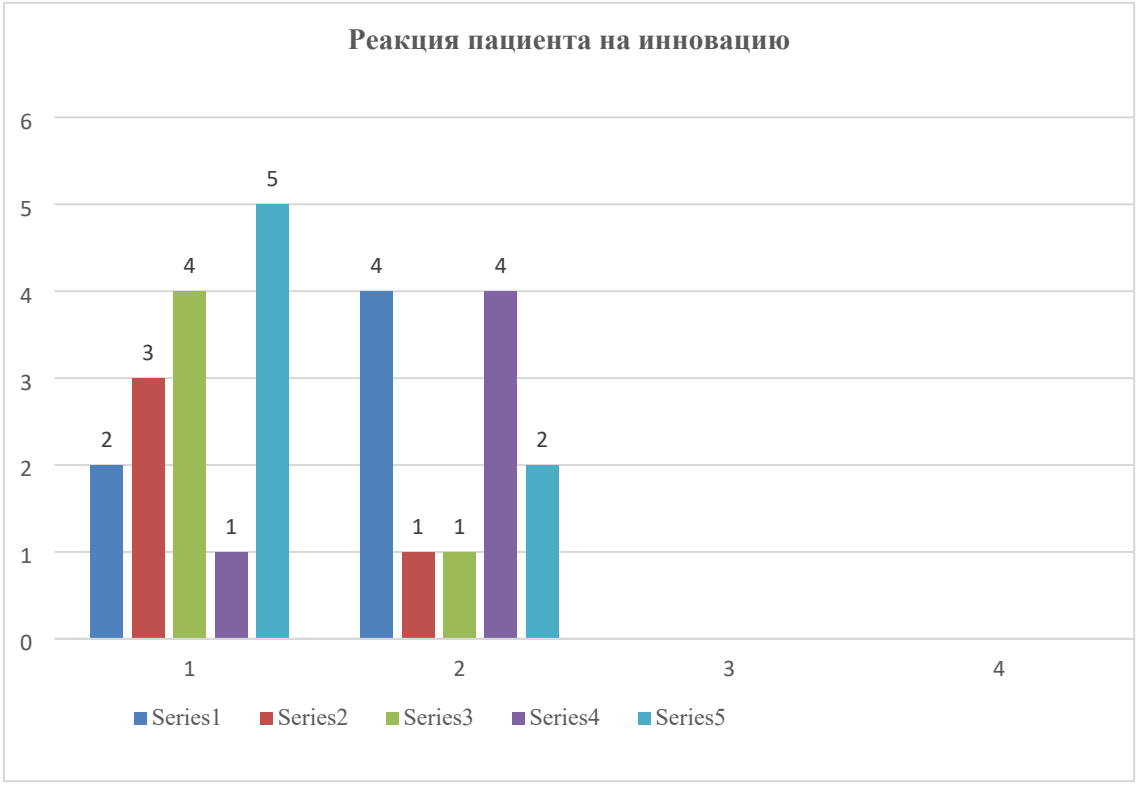
Одним из наиболее перспективных направлений считается применение телемедицинских технологий, обеспечивающих мониторинг жизненно важных показателей — частоты сердечных сокращений, насыщения крови кислородом, артериального давления и других параметров. Эти данные дают возможность своевременно выявлять изменения в состоянии пациента и предотвращать осложнения. Благодаря видеоконсультациям пациенты и их семьи получают не только медицинские рекомендации, но и эмоциональную поддержку, что снижает уровень тревожности и укрепляет доверие к медицинской системе [3, с. 59].

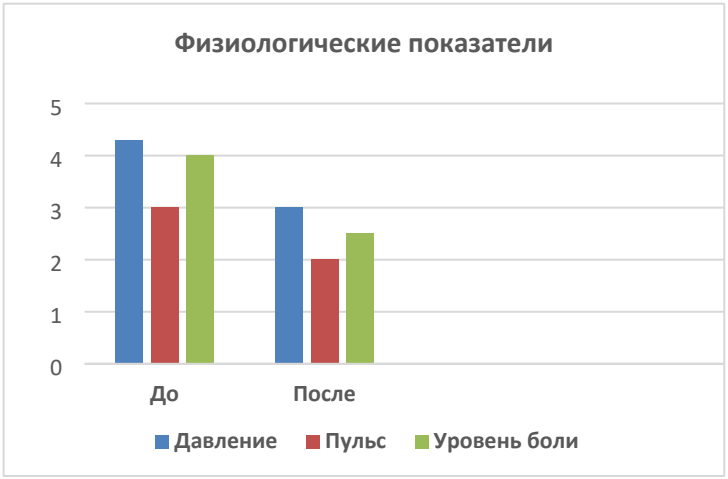
Как подчёркивает Нюта Федермессер, основатель фонда помощи хосписам «Вера»: «Суть паллиативной медицины не в том, чтобы палаты были чистые и были вымыты полы. А в том, чтобы человек, умирая, не остался один» [4, с. 102]. Эти слова точно отражают гуманистическую сущность паллиативной медицины, где технологии не подменяют

человеческое участие, а расширяют возможности заботы.

Создание электронных медицинских карт обеспечивает персонализированный и комплексный подход к уходу. Такие системы включают не только медицинские данные, но и сведения о личности пациента — его предпочтениях, духовных потребностях, особенностях общения [5, с. 37]. Цифровые платформы объединяют специалистов разных профилей, повышая эффективность междисциплинарного взаимодействия врачей, медицинских сестёр, психологов и социальных работников. Подобная интеграция способствует целостному пониманию пациента как личности, а не только носителя диагноза.

Современные устройства для ухода — роботизированные ассистенты, интеллектуальные кровати, автоматические системы контроля микроклимата — значительно повышают комфорт пациентов.





В исследовании, проведённом на базе паллиативного отделения, применение голосового помощника «Алиса» показало снижение тревожности и улучшение сна у пациентов. Взаимодействие с системой, прослушивание музыки и литературных произведений положительно повлияло на настроение и самочувствие. Эти технологии не заменяют медицинский персонал, но позволяют ему уделять больше внимания пациентам, нуждающимся в интенсивной поддержке.

Хирург и писатель Атул Гаванде справедливо заметил: «Надежда — это не план. Главная задача врача — понять, что для пациента действительно важно, и действовать исходя из этого» [6, с. 164].

Технологии виртуальной реальности (VR) открывают новые возможности в снижении боли и эмоционального напряжения. Пациенты могут «посещать» значимые места, слушать музыку, смотреть природные пейзажи. Такие программы уменьшают тревожность, депрессию и нередко снижают потребность в анальгетиках [7, с. 28].

Системы искусственного интеллекта позволяют анализировать большие массивы медицинских данных, прогнозировать развитие заболеваний и оптимизировать назначения. Однако роль врача и медицинской сестры при этом остаётся ключевой. Искусственный интеллект может обработать информацию, но только человек способен услышать боль и ответить состраданием. Доктор Жан Руссо отмечал: «Мы встречаем страдающего не как врачи, а как люди, соприкасающиеся с чужой болью» [8, с. 53].

Паллиативная помощь требует особых личностных качеств — терпения, эмпатии и эмоциональной устойчивости. Обучение будущих специалистов этому направлению формирует навыки гуманного общения и профилактики эмоционального выгорания. Современные симуляционные технологии и онлайн-платформы создают возможности для практической подготовки в условиях, приближенных к реальным [9, с. 96].

Инновационные подходы в паллиативной помощи являются важнейшим условием повышения качества жизни пациентов и их семей. Технологические достижения делают

уход более гибким и доступным, но в основе паллиативной медицины всегда остаётся человек. Как писала Элизабет Кюблер-Росс, основоположница современного подхода к паллиативной помощи: «Те, кто имеют силу и любовь сидеть рядом с умирающим в тишине, выходящей за пределы слов, знают, что этот момент не страшен, а исполнен мира» [10, с. 211].

Современные инновации делают паллиативную помощь более эффективной и человечной, но главный фактор её успеха — сострадание. Только сочетание технологического прогресса и человеческой души способно подарить пациенту не просто уход, а ощущение, что он не один.

Пусть каждая инновация напоминает нам: милосердие — это тоже наука, а наука без милосердия неполна.

Список использованный источников:

1. Всемирная организация здравоохранения. *Palliative Care: Key Facts*. Женева: WHO, 2022.
2. Крюкова Т.Л. Цифровизация в паллиативной медицине: вызовы и возможности // Медицинские технологии и инновации. 2024. № 3. С. 38–44.
3. Федермессер Н. *Про жизнь, смерть и хосписы*. М.: Альпина, 2020.
4. Федермессер Н. *Про жизнь, смерть и хосписы*. М.: Альпина, 2020. С. 102.
5. Смирнова Е.А. Электронные медицинские карты как инструмент персонализированной паллиативной помощи // *Современные проблемы здравоохранения*. 2023. № 2. С. 34–39.
6. Гаванде А. *Быть смертным. Что важно в конце жизни*. М.: Эксмо, 2022.
7. Николаева И.С. Виртуальная реальность как инструмент психосоциальной поддержки в паллиативной помощи // *Паллиативная медицина и реабилитация*. 2023. № 4. С. 25–31.
8. Rousseau J. *La souffrance et la compassion en médecine*. Paris: Masson, 2019.
9. Петрова Л.В., Ахметова Г.К. Симуляционные технологии в подготовке специалистов паллиативной медицины // *Современное медицинское образование*. 2024. № 1. С. 93–98.
10. Kübler-Ross E. *On Death and Dying*. New York: Scribner, 2014.

Сестринское дело: стандарты, вызовы и перспективы

Мусаева Анастасия[1], Оспанова Аяужан[2]

[1] Студентка, [2] научный руководитель

Усть-Каменогорский высший медицинский колледж

Аннотация

В статье рассматривается современное состояние сестринского дела в системе здравоохранения, анализируются ключевые стандарты профессиональной деятельности, а также основные вызовы, с которыми сталкиваются медицинские

сёстры. Особое внимание уделено перспективам развития сестринской профессии в Казахстане и мире.

Ключевые слова: сестринское дело, стандарты ухода, профессиональные вызовы, медицинские кадры, перспективы.

Введение

Сестринское дело является одной из важнейших составляющих системы здравоохранения. Медицинские сёстры играют ключевую роль в обеспечении ухода за пациентами, выполнении медицинских процедур, профилактике заболеваний и просветительской работе среди населения.

В последние годы в Казахстане и мире усиливается внимание к развитию сестринского образования и внедрению международных стандартов. Однако наряду с этим сохраняются вызовы — нехватка кадров, высокая нагрузка, недостаточный социальный статус профессии.

Цель данной статьи — проанализировать современное состояние сестринского дела, рассмотреть стандарты и вызовы, а также обозначить перспективы его развития.

Стандарты сестринского дела

Современные стандарты сестринской практики включают:

1. Профессиональная компетентность – владение теоретическими знаниями и практическими навыками.
2. Этические принципы – гуманизм, конфиденциальность, уважение к пациенту.
3. Клинические протоколы – выполнение ухода на основе доказательной медицины.
4. Междисциплинарное взаимодействие – работа в команде с врачами, социальными работниками, психологами.
5. Непрерывное образование – повышение квалификации и внедрение инновационных технологий ухода.

В Казахстане действуют государственные стандарты, ориентированные на международные практики, включая компетентностный подход в сестринском образовании.

Вызовы современного сестринского дела

1. Кадровый дефицит

По данным ВОЗ, во многих странах наблюдается недостаток квалифицированных медицинских сестёр. В Казахстане на тысячу жителей приходится в среднем 6–7 медсестёр, что ниже показателей развитых стран.

2. Профессиональная нагрузка

Высокая численность пациентов, бюрократическая отчётность и нехватка оборудования увеличивают нагрузку на средний медперсонал.

3. Социальный статус и престиж профессии

Несмотря на значимость работы, сестринское дело часто недооценивается обществом, что снижает привлекательность профессии для молодёжи.

4. Эмоциональное выгорание

Постоянный контакт с болью, стрессом и тяжёлыми случаями приводит к эмоциональному истощению и профессиональному выгоранию.

5. Неравномерность развития в регионах

В сельских районах медицинские сёстры выполняют гораздо больше функций из-за нехватки врачей, что повышает ответственность, но снижает качество ухода.

Перспективы развития сестринского дела

1. Модернизация образования

Введение многоуровневой системы подготовки (колледж – бакалавриат – магистратура – PhD), соответствующей международным стандартам.

2. Усиление роли медицинских сестёр

Расширение полномочий, включая возможность самостоятельного ведения пациентов с хроническими заболеваниями, оказание первичной медико-санитарной помощи.

3. Инновационные технологии

Применение телемедицины, электронных карт пациентов, цифровых систем учёта для облегчения работы медсестёр.

4. Психологическая поддержка и профилактика выгорания

Внедрение программ психологической помощи для среднего медперсонала.

5. Государственная поддержка

Повышение заработной платы, улучшение условий труда, расширение социальных гарантий для медицинских сестёр.

Международный опыт

- США: медсёстры играют ведущую роль в первичной помощи, часто выполняя функции семейных врачей.
- Европа: активно развивается институт сестринских консультантов, специализация по направлениям (онкология, гериатрия, реабилитация).
- Япония: акцент на уход за пожилыми, подготовка сестринского персонала по геронтологии.

• Скандинавские страны: высокий уровень доверия к медсёстрам, широкая самостоятельность в клинической практике.

Казахстан может адаптировать лучшие международные практики, усиливая компетенции сестринского персонала и создавая новые карьерные траектории.

Заключение

Сестринское дело — ключевой элемент системы здравоохранения. От качества работы медицинских сестёр напрямую зависит эффективность лечения, уровень удовлетворённости пациентов и общее состояние медицины в стране.

Внедрение современных стандартов, решение кадровых проблем и укрепление социального статуса профессии позволят вывести сестринское дело на новый уровень. Перспективы развития связаны с модернизацией образования, расширением полномочий, внедрением инноваций и государственной поддержкой.

Список использованных источников:

1. Всемирная организация здравоохранения. Nursing and midwifery. Geneva, 2022.
2. Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Отчёт о состоянии здравоохранения. Астана, 2023.
3. Benner P. From Novice to Expert: Excellence and Power in Clinical Nursing Practice. Addison-Wesley, 2001.
4. Аканова Г.Р. Развитие сестринского образования в Казахстане. – Алматы, 2021.
5. International Council of Nurses. Nursing Now Campaign. Geneva, 2020.
6. North N., Hughes F. International perspectives on nursing workforce. Int J Nurs Stud, 2020.

Психологическая помощь медицинской сестры родственникам и пациентам с онкологическими заболеваниями

Колесникова Олеся
Заместитель директора по воспитательной работе,
Кокшетауский высший медицинский колледж

Аңдатпа:

Мақалада онкологиялық аурулары бар науқастар мен олардың туыстарына психологиялық көмек көрсетудегі медбикенің рөлі қарастырылады. Науқастар мен олардың жақындары кездесетін негізгі психологиялық мәселелер, сондай-ақ медбике олардың психоэмоционалдық жағдайын жақсарту және өмір сапасын арттыру үшін қолдана алатын әдістер мен техникалар сипатталған.

Түйінді сөздер: онкология, психологиялық көмек, медбике, туыстар, науқастар,

психоэмоционалдық жағдай.

Аннотация:

В статье рассматривается роль медицинской сестры в оказании психологической помощи пациентам с онкологическими заболеваниями и их родственникам. Описываются основные психологические проблемы, с которыми сталкиваются пациенты и их близкие, а также методы и техники, которые медицинская сестра может использовать для улучшения их психоэмоционального состояния и повышения качества жизни.

Ключевые слова: онкология, психологическая помощь, медицинская сестра, родственники, пациенты, психоэмоциональное состояние.

Abstract:

The article discusses the role of a nurse in providing psychological support to cancer patients and their relatives. The main psychological problems faced by patients and their loved ones are described, as well as the methods and techniques that a nurse can use to improve their psychoemotional state and quality of life.

Keywords: oncology, psychological support, nurse, relatives, patients, psychoemotional state.

Онкологические заболевания – серьезный вызов для медицины и общества, оказывающий глубокое влияние на психоэмоциональное состояние пациентов и их близких [12, с. 15]. Диагноз рак вызывает широкий спектр эмоций: страх, тревогу, депрессию, гнев и беспомощность. В контексте био-психо-социальной модели здоровья Engel G.L. [6], комплексный подход к лечению, учитывающий как физическое, так и психологическое состояние, становится крайне важным. Медицинская сестра, находясь в постоянном контакте с пациентом и его семьей, играет ключевую роль в оказании психологической поддержки и адаптации к новым условиям жизни в рамках концепции "заботы, ориентированной на пациента" [9]. Психоонкология изучает психологические, социальные и поведенческие аспекты рака [7], включая эмоциональные реакции на диагноз, влияние психологических факторов на течение болезни и эффективность лечения, а также разработку и оценку психосоциальных вмешательств. Основные теоретические модели психоонкологии:

Модель стресса и совладания (Lazarus R.S. и Folkman S. [10]): Объясняет реакцию на стрессовые события (например, диагноз рака) в зависимости от оценки события и доступных ресурсов для совладания.

Теория социальной поддержки [8]: Подчеркивает важность социальной поддержки в адаптации к стрессовым событиям, улучшающей психологическое состояние и качество жизни пациентов.

Модель когнитивной переоценки [11]: Предполагает, что изменение способа мышления о стрессовом событии может снизить негативные эмоции и улучшить адаптацию. Медицинская сестра может помочь пациентам переосмыслить опыт и найти позитивные аспекты.

Пациенты с онкологией сталкиваются с многочисленными психологическими проблемами, обусловленными болезнью и ее лечением:

Страх и тревога: Перед неизвестностью, болью, смертью, побочными эффектами лечения [2, с. 67].

Депрессия: Чувство безнадежности, утрата интереса к жизни, нарушение сна и аппетита [3].

Гнев и раздражительность: Недовольство болезнью, врачами, близкими.

Чувство вины: Связанное с убеждением, что образ жизни способствовал развитию болезни.

Нарушение самооценки: Изменение внешности, потеря трудоспособности, ощущение себя обузой.

Социальная изоляция: Отдаление от друзей и коллег, страх отвержения [1].

Родственники пациентов также испытывают сильный психологический стресс, переживая за близкого, чувствуя себя беспомощными, сталкиваясь с финансовыми трудностями и необходимостью принимать сложные решения:

Тревога и депрессия: За больного, страх его потери, чувство вины [4].

Эмоциональное выгорание: Хроническая усталость, раздражительность, снижение эмпатии.

Нарушение сна и аппетита: Связанные со стрессом и переживаниями.

Социальная изоляция: Отсутствие времени и сил на общение.

Конфликты в семье: Возникающие из-за стресса и необходимости перераспределения обязанностей.

Медицинская сестра, проводя много времени с пациентом, наблюдая за его состоянием и выслушивая его жалобы, находится в уникальном положении для оказания психологической помощи. Она должна обладать:

Эмпатией: Способностью понимать и сопереживать.

Коммуникативными навыками: Умением устанавливать доверительные отношения, активно слушать, задавать вопросы и предоставлять информацию.

Наблюдательностью: Способностью замечать изменения в поведении и настроении.

Знанием основ психологии: Пониманием основных психологических проблем [5, с. 78].

Навыками психологического консультирования: Умением оказывать поддержку.

Медсестра может использовать различные методы и техники:

Активное слушание: Внимательное выслушивание, выражение сочувствия и понимания.

Эмоциональная поддержка: Поощрение к выражению чувств, создание безопасной атмосферы.

Информирование: Предоставление информации о болезни, лечении, побочных эффектах [2].

Обучение навыкам самопомощи: Методам релаксации, медитации, дыхательным упражнениям.

Помощь в решении проблем: Совместный поиск решений.

Направление к специалистам: Психологу, психотерапевту, социальному работнику.

Групповая терапия: Участие в группах поддержки [1].

Психологическая помощь должна оказываться на всех этапах лечения:

На этапе диагностики: Предоставление информации, поддержка в принятии решений, помощь в преодолении страха.

Во время лечения: Облегчение побочных эффектов, поддержка в борьбе с депрессией и тревогой, поддержание позитивного настроя.

В период ремиссии: Поддержка в адаптации к жизни после лечения, помощь в преодолении страха рецидива.

В терминальной стадии: Облегчение боли и страданий, поддержка пациента и его семьи [3].

Важно соблюдать этические принципы:

Конфиденциальность: Сохранение личной информации.

Автономия: Уважение права на принятие решений.

Благодеяние: Стремление к улучшению благополучия.

Непричинение вреда: Избежание действий, которые могут причинить вред.

Психологическая помощь медицинской сестры существенно улучшает качество жизни онкологических пациентов и их близких. Своевременная поддержка помогает адаптироваться, справляться со стрессом, сохранить надежду и веру в выздоровление. Развитие навыков психологической помощи у медсестер – приоритетное направление в здравоохранении.

Список использованныхисточников:

1. Andersen, B. L. (2002). Biobehavioral outcomes following psychological interventions for cancer patients. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70(6), 1139.
2. Epstein, R. M., & Street Jr, R. L. (2007). Patient-centered communication in cancer care: promoting healing and reducing suffering. National Cancer Institute.
3. Иванова, А. А., Петрова, И. П. (2018). Психологическая помощь в онкологии. Москва: Медицина.
4. Holland, J. C., Breitbart, W. S., Jacobsen, P. B., Lederberg, M. S., Loscalzo, M. J., & McCorkle, R. (Eds.). (2010). Psycho-oncology (2nd ed.). Oxford University Press.
5. National Comprehensive Cancer Network. (2022). NCCN Guidelines for Patients: Distress Management.
6. World Health Organization. (2020). Cancer.
7. Сидоров, П. И., Парняков, А. В. (2008). Клиническая психология. Москва: ГЭОТАР-Медиа.

Көкшетау қаласы, Қазақстан Республикасы
2025 жылғы 02 қазан

Сессияға қатысушылар, баяндамалар мен баяндамаларды қарап, қазіргі заманның әлеуметтік дамуын, профилактикалық аурулар мен пәнаралық өзара іс-қимылды, келесі атап өтеді:

1. Қазіргі заманғы тенденциялар мен сын-қатерлер:

Медбикелік және кәсіби рөлдер мен функцияларды кеңейту, басқарушылық шешімдер мен ғылыми зерттеулерге қатысу.

Клиникалық ойлауға, зерттеу жұмыстарына және кәсіптік өзара іс-қимылға қабілетті мамандардың даярлық деңгейі өсіру.

Практиканы стандарттау, күтім сапасын қамтамасыз ету, мейіргерлер арасындағы көшбасшылықты дамыту және олардың тек денсаулық сақтау жүйесінің деңгейлеріндегі үлесін мойындау қажеттілігімен байланысты сын-қатерлер өзекті болып қалуда.

2. Ұсынылған баяндамалардың тізімі:

1. Қырғыз Республикасының тәжірибесі постестрлік іске, даярлық пен практикимедициналық кестеге арналған пилоттық бағдарламаны іске асыруда белгіленді.
2. онкологиялық аурулармен ауыратын пациенттердің профилактикасы, диагностикасы, паллиативтік көмегі мен оңалтудың кеңейтілуінің маңыздылығы атап өтілді.
3. Белоруссияның онкологиялық аурулардың алдын алу және дәрігерлік-санитарлық көмек көрсетудегі құнды тәжірибесі.
4. Білім беру процесіне интеграциялық тәсілдер мен сестрлік тәжірибелерді таратудың қажеттілігін белгілеу.
5. Эпидемиологиялық ауруларда облыстық және өңірлік үрдістерге талдау жасалды, араласуды жоспарлауда, талдауда және пайдалануда медициналық шебердің рөлі баса көрсетілді
6. Паллиативтік көмектің елеулі әлеуеті атап өтілді, онда медбике мамандарының рөлі маңызды.
7. Онкологиялық ауруларға қарсы күресте қандай басымдылықтар бар, профилактикаға медбикелердің консультациялық қызметін және қоныстандыруды тартуды атап өту.
8. практикалық тәжірибелік медициналық ұйымдар келтірілген, онкологияда кеңейтілген функциялық медициналық-химсестердің моделі іске асырылады.
9. Студенттерде кәсіптік білім қалыптастыратын медбикелік білім берудегі интеграциялық зерттеулердің көрінісі

3. Ұсынымдар:

1. Облыстық онкология, скрининг, күтім, паллиативтік көмек және ағартуды қоса алғанда, мамандандырылған орталықтың функциясын ынталандыруды және кеңейтуді қолдау және дамыту.
2. Жаңа кәсіптік және қайта құру бағдарламаларына, ғылыми-зерттеу жұмыстарына даярлық жүйесін қамтамасыз ету.
3. Денсаулық сақтаудағы тәртіптік өзара іс-қимылға жәрдемдесу, оның ішінде жалпы практика дәрігерлері мен мамандандырылған мекемелердің жұмысына белсенді қатысу.
4. Кеңейтілген практикаларды нормативтік-құқықтық реттеуді дамыту, оның ішінде онкология.

5. Халықаралық және ұлттық рекомендацияларды стандарттау мен біріздендіруді ілгерілету.
6. Онкологиялық аурулардың алдын алуда, ақпараттық науқасқа және ерте пайда болу бағдарламасына қатысуды жандандыру.
7. Білім беру деңгейлерін зерттеуді қоса алғанда, арнайы даярлық жүйесіндегі ғылыми қызметтің интеграциялық жағдайларын жасау.
8. Халықаралық қызметтестік пен алмасуды қолдауға, әдістемелік және жоғары кәсіби облысты қорғауға бағытталған.

Комиссия мүшелерінің бірауыздан қабылданған қарары

Көкшетау қаласы, Қазақстан Республикасы
2025 жылғы 2 қазан

РЕЗОЛЮЦИЯ

Секции «**Роль специалистов сестринского дела: от ухода до лидерства**»
Международной конференции, посвященной 75-летию Кокшетауского высшего медицинского колледжа **«Вместе для будущего без рака — Медсёстры, Врачи, Учёные»**
В рамках 13 региональной конференции АРОСР

г. Кокшетау, Республика Казахстан
02 октября 2025 года

Участники секции, рассмотрев доклады и выступления, посвящённые современным аспектам развития сестринского дела, профилактики онкологических заболеваний и междисциплинарного взаимодействия, отмечают следующее:

1. Современные тенденции и вызовы:

- Сестринское дело сегодня претерпевает качественные изменения, включая расширение профессиональных ролей и функций, участие в управленческих решениях и научных исследованиях.
- Возрастает значимость подготовки специалистов сестринского дела, способных к клиническому мышлению, исследовательской работе и межпрофессиональному взаимодействию.
- Актуальными остаются вызовы, связанные с необходимостью стандартизации практики, обеспечением качества ухода, развитием лидерства среди медицинских сестёр и признанием их вклада на всех уровнях системы здравоохранения.

2. По итогам представленных докладов:

1. Отмечен опыт Кыргызской Республики в реализации пилотной программы по сестринскому делу, нацеленной на трансформацию подготовки и практики медицинских сестёр.
2. Подчеркнута важность **расширения роли медицинских сестёр** в профилактике, диагностике, паллиативной помощи и реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями.
3. Представлен ценный опыт Беларуси по командному подходу в профилактике онкологии на уровне первичной медико-санитарной помощи.
4. Обозначена необходимость транслирования лучших сестринских практик и интеграции новых подходов в образовательный процесс.
5. Проанализированы **глобальные и региональные тренды** в эпидемиологии онкологических заболеваний, акцентирована роль медицинских сестёр в сборе, анализе и использовании данных для планирования вмешательств.
6. Отмечен значительный потенциал **паллиативной помощи**, реализуемой через мультидисциплинарные команды, в которых специалисты сестринского дела играют ключевую роль.
7. Подчёркнута эффективность **консультативной деятельности** медицинских сестер и вовлечения населения в профилактику, как одного из приоритетов в борьбе с онкологическими заболеваниями.

8. Приведён **практический опыт медицинской организации**, где успешно реализуется модель расширенных функций медицинских сестёр в онкологии.
9. Отражён опыт **интеграции научных исследований в сестринское образование**, формирующий у студентов профессиональные и исследовательские компетенции.

3. Рекомендации:

1. **Поддерживать и развивать инициативы** по расширению функций специалистов сестринского дела в области онкологии, включая профилактику, скрининг, уход, паллиативную помощь и просвещение.
2. **Обеспечить системную подготовку** медсестёр к новым профессиональным ролям через реформу образовательных программ, развитие лидерства и исследовательских компетенций.
3. **Содействовать междисциплинарному взаимодействию** в здравоохранении, включая активное участие медицинских сестёр в работе команд врачей общей практики и специализированных учреждений.
4. **Развивать нормативно-правовую базу** для регулирования расширенных практик медицинских сестёр, в том числе в онкологии.
5. **Продвигать стандартизацию и унификацию сестринской практики**, исходя из международных и национальных рекомендаций.
6. **Активизировать участие специалистов сестринского дела в профилактике онкологических заболеваний** через обучение населения, информационные кампании и вовлечение в программы раннего выявления.
7. **Создавать условия для интеграции научной деятельности** в систему подготовки специалистов сестринского дела, включая прикладные исследования на всех уровнях образования.
8. **Поддерживать международное сотрудничество и обмен опытом**, направленные на развитие сестринского дела как самостоятельной и высокопрофессиональной области здравоохранения.

Резолюция принята единогласно участниками секции

г. Кокшетау, Республика Казахстан
2 октября 2025 года

RESOLUTION

The section "The role of nursing specialists: from nursing to leadership" of the International Conference dedicated to the 75th anniversary of Kokshetau Higher Medical College "Together for a cancer—free future - Nurses, Doctors, Scientists" Within the framework of the 13th regional conference of the AAPR

Kokshetau, Republic of Kazakhstan
October 02, 2025

The participants of the section, having reviewed reports and presentations on modern aspects of the development of nursing, cancer prevention and interdisciplinary cooperation, note the following:

1. **Current trends and challenges:**

Today, nursing is undergoing qualitative changes, including the expansion of professional roles and functions, participation in management decisions and scientific research.

The importance of training nursing professionals capable of clinical thinking, research, and interprofessional interaction is increasing.

Challenges related to the need to standardize practice, ensure quality of care, develop leadership among nurses, and recognize their contributions at all levels of the healthcare system remain relevant.

2. **Based on the results of the presented reports:**

1. The experience of the Kyrgyz Republic in the implementation of a pilot nursing program aimed at transforming the training and practice of nurses was noted.
2. The importance of expanding the role of nurses in the prevention, diagnosis, palliative care and rehabilitation of patients with cancer was emphasized.
3. The valuable experience of Belarus in the team approach to cancer prevention at the primary health care level is presented.
4. The need to translate the best nursing practices and integrate new approaches into the educational process is outlined.
5. Global and regional trends in cancer epidemiology are analyzed, and the role of nurses in collecting, analyzing, and using data for intervention planning is emphasized.
6. The significant potential of palliative care, implemented through multidisciplinary teams in which nursing specialists play a key role, was noted.
7. The effectiveness of the advisory activities of nurses and the involvement of the population in prevention is emphasized as one of the priorities in the fight against oncological diseases.
8. The practical experience of a medical organization is presented, where the model of expanded functions of nurses in oncology is successfully implemented.
9. The article reflects the experience of integrating scientific research into nursing education, which forms students' professional and research competencies.

3. Recommendations:

1. To support and develop initiatives to expand the functions of oncology nursing professionals, including prevention, screening, care, palliative care, and education.
2. To ensure the systematic training of nurses for new professional roles through the reform of educational programs, the development of leadership and research competencies.
3. Promote interdisciplinary collaboration in healthcare, including the active participation of nurses in the work of teams of general practitioners and specialized institutions.
4. To develop a regulatory framework for regulating extended nursing practices, including in oncology.
5. Promote standardization and unification of nursing practice based on international and national recommendations.

6. To enhance the participation of nursing professionals in cancer prevention through public education, information campaigns, and involvement in early detection programs.
7. Create conditions for the integration of scientific activities into the system of training nursing specialists, including applied research at all levels of education.
8. To support international cooperation and exchange of experience aimed at the development of nursing as an independent and highly professional field of healthcare.

The resolution was adopted unanimously by the participants of the section

Kokshetau, Republic of Kazakhstan
October 2, 2025

II бөлімі. 75 жылдығына арналған АРОСР Халықаралық 13-ші Аймақтық конференциясының постерлік сессиясының материалдары
Көкшетау жоғары медициналық колледжі

РазделII. Материалы Постерной сессии Международной 13-й Региональной конференции АРОСР, посвящённой 75-летию
Кокшетауского высшего медицинского колледжа

Section II. Materials of the Poster session of the 13th AROSR International Regional Conference dedicated to the 75th anniversary
Kokshetau Higher Medical College

The Effectiveness of Human papillomavirus-related Cancer Prevention Awareness Program on Knowledge and Screening Intention among Female Students and Employees of Oman College of Health Sciences, North Batinah

Abhar Al Shihhi, Ishraq Al Obeidani, Maryam Al Mamari, Manar Al Barhi, Dr. Maria Pramila D' Costa
Oman college of health sciencs

Regional Conference (with international participation) of the Asia-Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP), as part of the 75th Anniversary of Kokshetau Higher Medical College

كلية عمان للعلوم الصحية
Oman College of Health Sciences

Bridging Knowledge to Action: The Effectiveness of Human papillomavirus-related Cancer Prevention Awareness Program on Knowledge and Screening Intention Among Female Students and Employees of Oman College of Health Sciences, North Batinah.

Authors: Abhar Al Shihhi, Ishraq Al Obeidani, Maryam Al Mamari, Manar Al Barhi. **Corresponding author**: Dr. Maria Pramila D' Costa

Background

Human Papillomavirus (HPV) is a sexually transmitted disease, and is one of the most common causes attributing to mortality. The most common HPV-related cancer are cervical cancer, which is the fourth most common cancer among women in Oman. Globally and regionally, HPV prevalence varies widely, yet many women remain unaware of the virus, the vaccine, or the link to cancer. For instance, only 15.8% of women in Oman knew about HPV, and just 10.1% knew about the vaccine (Al Raisi et al., 2022)

Objectives

This study aimed to find the effectiveness of an HPV-related cancer awareness program in enhancing knowledge and screening intentions among female students and employees of OCHS NB. The research was based on the modified Theory of Planned Behavior Framework by (Ajzen, 1991)

Methodology

A Pre-experimental, one group pre-test and post-test design with cross sectional approach was employed. A total of 125 students and employees of a selected government Health Science College were chosen randomly to participate in the awareness program. Knowledge and screening intention were measured through a structured knowledge questionnaire (true and false form) and the screening intention scale (5-Point Semantic/Likert Scale) adapted from the previous studies (Ogilvie et.al, 2013; Harrison et.al, 2021) before and after implementing the awareness program, The data were analyzed using SPSS 23.0 version with descriptive statistics (frequency, percentage, mean, and standard deviation) and inferential statistics (Paired t-test, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis, ANOVA test).

Acknowledgement

We, the researchers, would like to acknowledge and express our gratitude to all faculty, staff, and students who supported and participated in this study, and to the Oman College of Health Sciences for sponsoring and supporting conference attendance

Conclusion

HPV-related cancer awareness program was effective in improving HPV related posttest knowledge and screening intentions among study participants, indicating that the education interventions can promote the proactive health behavior.

Result

Sample distribution of demographic characteristics data

This study showed that most participants, 67 (54%), were aged 21- 30, and the majority, 97 (77.6%), were single females. Most of them were from year four 38 (38%). The majority 103 (82.4%) had not attended any form of awareness program and didn't screen for STDs.

Distribution of the study sample based on pre-test knowledge among female students and employees of OCHS about HPV-related cancer prevention awareness program.

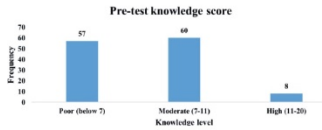


Figure 1: Bar chart showing the levels of pre- test knowledge scores

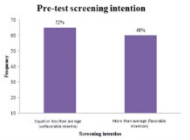


Figure 2: Bar chart showing the pre-test screening intention score among female OCHS students and employees

The effectiveness of HPV-related cancer prevention awareness program in terms of gaining knowledge and screening intention pre and post-test comparison.

Table 1: Paired 't' test showing the significance of mean difference between pre-test and post-test knowledge score at 0.5 significance level.

N=125

	Mean	Std. Deviation	Mean Difference	t value	p value
Pre-test knowledge scores	6.336	3.623			
Post-test Knowledge scores	11.696	2.499	5.36	13.491	p<0.001*

Table 2: Paired 't' test showing the significance of mean difference between pre-test and post-test screening intention of participants

N:125

	Mean	Std. Deviation	Median	mean diff	t value	p value
Pre-test	57.080	11.680	57.00			
				-8.688	-7.60727	p<0.001
Post-test	65.768	11.530	68.00			

Significant difference in pre-test knowledge and screening intentions based on demographic variables.

No significant differences were observed in the pre-test knowledge and screening intention scores based on the demographic variables ($p > 0.05$), except for student educational level ($p = 0.005$) and employee position ($p = 0.032$).

Contact emails: Maria.decosta@ochs.edu.om abharalshihhi2002@gmail.com

Науқастардың гемокульт тест тапсыруы кезіндегі мейіргерлік тәжірибе

Букен Назира[1], Мұстахым Сымбат [2]
[1] Педагог-модератор, магистрант СибММУ, [2] студент
Көкшетау жоғары медициналық колледжі

Көкшетау жоғары медициналық колледжінің 75 жылдығы аясында Asia-Pacific Cganization for Cancer Prevention (APOCP) аймақтық конференциясы (халықаралық қатысуымен)

“Науқастардың гемокульт-тест тапсыруы кезіндегі мейіргерлік тәжірибе”

Ғылыми жетекші:Букен Н.А. педагог-модератор,магистрант СибММУ, баяндаушы -Мұстахым С.Б.

Негізгі мәліметтер мен мақсаттар

Бұл зерттеу жұмысы гемокульт- тест тапсыруға науқастарды дайындаудағы мейіргерлік тәжірибеге арналды. Жұмыстың мақсаты – гемокульт тестке дайындық процесінде мейіргердің рөлін жан-жақты қарастырып, науқастарды дұрыс дайындау арқылы тест нәтижелерінің сапасын жақсарту және мейіргерлер қызметін жеңілдету жолдарын зерттеу.

Әдістеме

Зерттеу мақсаты: науқастардың гемокульт- тест тапсыруға алдын ала дайындығын зерттеу және ұсыныс беру.

Зерттеу мақсатына қол жеткізу үшін келесі міндеттер анықталды:

- тоқ ішек обыры мен оны ерте анықтау жайында әдебиеттерге шолу жасау.

-тестті тапсыру және науқастардың дайындығында орын алатын мәселелер мен қателіктерді талдау.

- науқастарға дайындық бойынша ұсыныстар әзірлеу және сенімді нәтижеге қол жеткізу.



Нәтижелер

Мәселелердің барлығын талдау арқылы жұмыс барысында жадынама әзірленді. Бұл ұсынысты іске асыру мейіргердің гемокульт-тест өткізу кезіндегі рөлін нығайтады және жалпы диагностика сапасын жақсартады.Жадынама арқылы науқастарға алдын ала дайындық пен тест тапсыру жайында ақпарат беріледі.

Инновационный подход в оказании паллиативной помощи

Сурова Яна, Ковзалова Людмила
Северо-Казахстанский высший медицинский колледж имени Жұмағали Тлеулин



Региональная конференция (с международным участием) Asia-Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP), в рамках 75-летия Кокшетауского высшего медицинского колледжа

Инновационный подход в оказании паллиативной помощи

Сурова Яна Денисовна, 3 курс, специальность «Сестринское дело»
Руководитель: Ковзалова Людмила Николаевна, преподаватель специальных дисциплин, педагог-модератор, магистр сестринского дела

Основные сведения и цели

Современные вызовы требуют внедрения инноваций: цифровые технологии, новые методы контроля боли и междисциплинарный подход.

Цель: повысить качество жизни пациентов с неизлечимыми заболеваниями за счет внедрения инновационных технологий; оценить результаты внедрения инноваций и разработать рекомендации для дальнейшего масштабирования.

Инновации в паллиативной помощи – это не только новые технологии, но и новые способы быть рядом, слушать и слышать.

Методология: аналитический метод, сравнительный метод, мониторинг и оценка



Acknowledgement

- Сбор обратной связи от пациентов и их семей.
- Оценка динамики: уменьшение жалоб на боль, улучшение психологического состояния, повышение удовлетворенности.

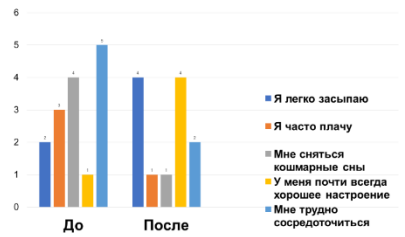
Результаты

- Формирование модели инновационного развития паллиативной медицины, пригодной для внедрения в разных регионах страны.
- Улучшение методов ухода и контроля симптомов.
- Расширение возможностей психологической и социальной поддержки пациентов и их близких.

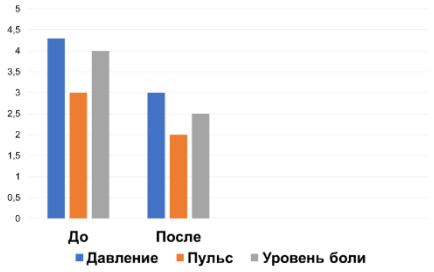




Реакция пациента на инновацию



Физиологические показатели



Заключение

Инновационный подход в паллиативной помощи является ключевым условием для повышения качества жизни пациентов и их семей, а также для развития современной системы здравоохранения.

Maintaining sleep quality in cancer patients with the help of nursing interventions

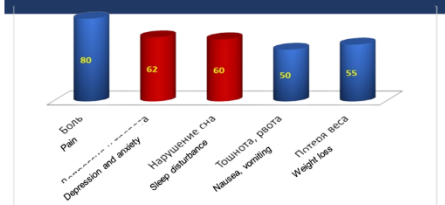
Yaroshinskaya Irina, Salimova Aruzhan
Kokshetau higher medical college, LLP “Viamedis”

Региональная конференция (с международным участием)
Asia-Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP), в рамках
75-летия Кокшетауского высшего медицинского колледжа

MAINTAINING SLEEP QUALITY IN CANCER PATIENTS WITH THE HELP OF NURSING INTERVENTIONS

Yaroshinskaya I.K.[1], *Salimova A.O.*[2]
[1] *Teacher educator of special disciplines of KVMK,* [2] *nurse "TOO Viamedis"*

Background and Objectives



Problems of cancer patients

Hypothesis:
If the nurse knows the techniques of independent nursing interventions for sleep management and uses them in palliative practice, then in general it is possible to positively change the patient's attitude to the disease, maintain the quality of sleep and life

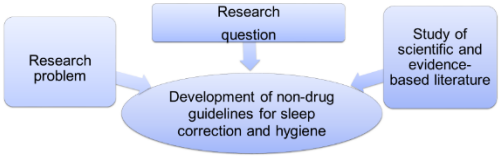
Objective: To improve sleep quality in cancer patients through independent nursing interventions

1. To analyze the quality of sleep in cancer patients.
2. To develop non-drug guidelines for sleep correction and hygiene in cancer patients
3. To assess the results of adaptation of independent nursing interventions to improve the quality of sleep.

TASKS:

Methodology

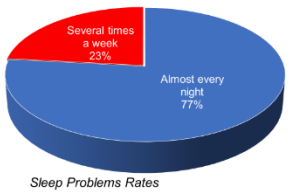
The study involved 30 oncological patients with sleep disorders (Kokshetau).
Research methods:
- quantitative and statistical analysis;
-Patient interview: (Pittsburgh Sleep Quality Questionnaire (PSQI);
- approbation of the developed guideline in clinical practice;
- one-component scale of self-assessment of sleep quality



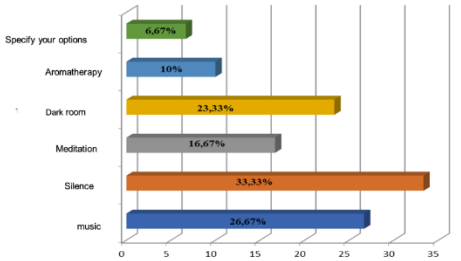
Acknowledgement

Social partners: Kokshetau Higher Medical College
City Polyclinic, Kokshetau

Outcomes

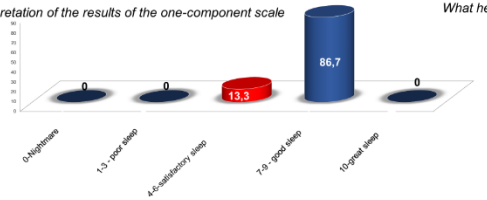


Sleep Problems Rates



What helps respondents fall asleep

Interpretation of the results of the one-component scale



Conclusion

The study showed that the use of non-drug nursing interventions is an effective direction in the correction of sleep disorders in cancer patients. The developed guideline increases the level of evidence of nursing practice, reduces the severity of sleep disorders and can be integrated into the system of training and advanced training of nurses.

Возможности улучшения практики безопасного сестринского ухода за пациентами в приемном отделении

Мокрова Инна, Кулыбекова Раушан
Кокшетауский высший медицинский колледж

Региональная конференция (с международным участием)
Asia-Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP), в рамках
75-летия Кокшетауского высшего медицинского колледжа

ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ ПРАКТИКИ БЕЗОПАСНОГО СЕСТРИНСКОГО УХОДА ЗА ПАЦИЕНТАМИ В ПРИЕМНОМ ОТДЕЛЕНИИ

Мокрова И.И.[1], Кулыбекова Р.Б.[2]

[1] педагог-исследователь специальных дисциплин, [2] медицинская сестра расширенной практики

Основные сведения и Цели

Цель: определить основные аспекты эффективности работы медицинских сестер приемного отделения многопрофильной городской больницы г. Кокшетау в рамках применения самодиагностики эмоционального выгорания





более **50%** случаев предотвратимы

Методология

✓Теоретический метод — анализ медицинской, психолого-социальной литературы по проблеме исследовательской работы.
✓Диагностические методы — методика самодиагностики выявление эмоционального выгорания.
✓Математический метод обработки результатов.



Acknowledgement

Важно рассматривать, оценивать работу и мнение медицинских сестер по созданию безопасности пациентов, с целью повышения качества оказываемой помощи. Исследования показали альтернативный метод диагностики эмоционального выгорания через методику самооценки и саморегуляции.

✓Изучить научные материалы
✓Провести анализ взаимосвязи
✓Адаптировать инструмент самодиагностики
✓Систематизировать техники саморегуляции



Важным фактором, влияющим на профессиональную деятельность медицинской сестры, является синдром эмоционального выгорания.

Результаты







Заключение

Введение методик самодиагностики предоставляет доступный и эффективный инструмент для управления психологическим благополучием медсестёр, что способствует повышению качества ухода. Интеграция стратегий эмоциональной саморегуляции в сестринскую практику позволит медицинским организациям создать более безопасные и устойчивые рабочие условия, что, в конечном итоге, принесёт пользу как сотрудникам, так и пациентам.

Сестринская практика эффективной организации психофизического скрининга детей раннего возраста на уровне ПСМП

Мокрова Инна, Козловцева Анна
Кокшетауский высший медицинский колледж

Региональная конференция (с международным участием) Asia-Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP), в рамках 75-летия Кокшетауского высшего медицинского колледжа

СЕСТРИНСКАЯ ПРАКТИКА ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО СКРИНИНГА ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА НА УРОВНЕ ПМСП

Мокрова И.И.[1], Козловцева А.Г. [2]

[1] педагог-исследователь специальных дисциплин, [2] медицинская сестра расширенной практики

Основные сведения и Цели

Цель: улучшение практики медицинской сестры кабинета развития ребенка в выявлении проблем развития в раннем возрасте. Задачи данного исследования ориентированы на качество проводимого скрининга и продуктивный охват групп детей с риском отставания в психофизическом развитии.

Многочисленные исследования показывают, что развитие мозга в первые 1000 дней жизни оказывают влияние на здоровье ребенка, его развитие и достижения на протяжении всей жизни. Некоторые дети в силу определенных обстоятельств развиваются иначе или же не так быстро, как остальные. Необходимо проводить качественный скрининг, при работе с семьей **ориентироваться на проактивный подход и раннее вмешательство.**

Методология

- Ретроспективный анализ результатов проведенных скриниговых исследований за 3 года
- Анкетирование родителей

Acknowledgement

Основываясь на поставленные цели и задачи исследования, анализируя результаты в психофизическом развитии детей раннего возраста, немаловажную роль играет слаженность работы медсестры КРР и участковой службы. Своевременная помощь и коррекция дают исключительную возможность «сгладить» имеющиеся недостатки и проблемы в развитии, а в ряде случаев даже устранить их, обеспечив тем самым полноценное развитие ребенка.

В развитии ребенка нет более важного периода, чем первые 1000 дней жизни!

Результаты





ИНСТРУМЕНТЫ СКРИНИНГА:



Заключение

- ✓психофизический скрининг является одним из ключевых аспектов своевременного выявления и направления детей в ПМПК для углубленного обследования и решения вопросов коррекционно - развивающего обучения;
- ✓большая часть родителей имеет правильное представление о психофизическом развитии и сроках его проведения, но на ряду с этим, остается контингент родителей, которые нуждаются в дополнительной информации и поддержке компетентных специалистов.

Поддержка пациентов в процессе самоменеджмента после мастэктомии

Куспанова Айгуль, Дюсенбаева Арайлым, Кадырбаева Каракат

Кокшетауский высший медицинский колледж

Региональная конференция (с международным участием)
Asia-Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP), в рамках
75-летия Кокшетауского высшего медицинского колледжа

Поддержка пациентов в процессе самоменеджмента после мастэктомии

Куспанова А.Р.[1], Дюсенбаева А.А.[2] , Кадырбаева К.А. [3]

[1]*Педагог-эксперт специальных дисциплин,* [2]*Старшая медицинская сестра хирургического отделения онкологического центра (академический бакалавр),*
[3] *педагог-модератор специальных дисциплин*

Основные сведения и Цели



Цель исследования: Улучшение качества организации обучения пациентов хирургического отделения онкоцентра по уходу после мастэктомии.



Гипотеза:
Правильно обученные пациенты способствуют созданиюблагоприятной среды для полного и быстрого восстановления после проведенной мастэктомии.

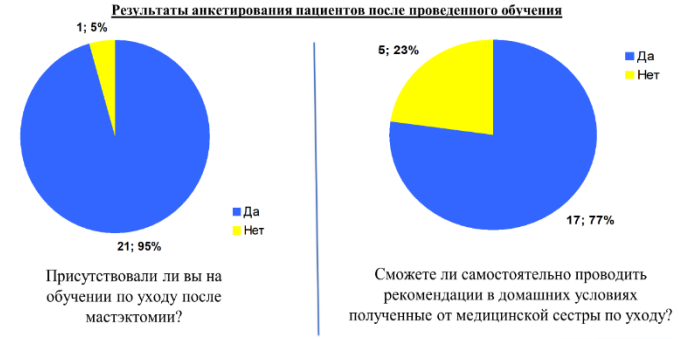
Методология

Экспериментальная часть исследования проводилась на базе ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» с пациентками хирургического отделения онкоцентра. В анкетировании приняли участие 22 женщины в возрасте 40-60 лет.
Методы исследования:
социологический опрос, анализ и статистическая обработка данных.

Acknowledgement

Социальным партнёрам МО г. Кокшетау:
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника»

Результаты



Заключение

В заключении нашей исследовательской работы , выяснили что обучении пациентов после мастэктомии заключается в разработке оптимальной программы реабилитации на раннем постгоспитальном этапе, включающая в себя комплексы лечебной физкультуры, дыхательной гимнастики и обширной антистрессовой терапии. Медицинская сестра выступает в качестве консультанта при составлении рекомендаций по режиму труда и отдыха, лечебному питанию, мерам профилактики рецидивов и советам по образу жизни после мастэктомии. Все это способствует улучшению качества жизни пациенток после операции.

Медико-психологическая реабилитация пациентов после мастоэктомии

Окасова Гульнар[1], Жага Ангелина[2]
[1] Преподаватель специальныхдисциплин, [2] студентка
Экибастузкий медицинский колледж

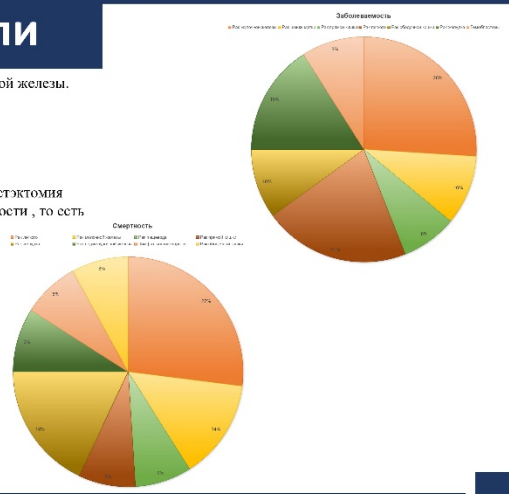
Региональная конференция (с международным участием) Asia-Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP), в рамках 75-летия Кокшетауского высшего медицинского колледжа

«Медико-психологическая реабилитация пациентов после мастэктомии» Окасова Г.К. , Жага А.И.
Преподаватель специальных дисциплин , Студентка специальность «Лечебное дело»

Основные сведения и Цели

Аннотация: рак молочной железы --это злокачественная опухоль железистой ткани молочной железы.
• Причина: возникновения изменения генома клетки , под воздействием внешних причин, и гормонов.
• Проблема : смертность от рака молочной железы стоит на втором месте. В связи с этим актуальна медико психологическая реабилитация пациентов после мастэктомии.Актуальность: по оценкам экспертов ВОЗ в мире ежегодно регистрируют от 800 тысяч до 1млн новых случаев заболевания РМЖ. • Мастэктомия является ведущим методом лечения РМЖ , и имеет частое осложнения в виде отека конечности , то есть лимфостаза.
• Научные исследования подтвердили существование четырех молекулярных подтипов РМЖ.
• Цель :изучения клинического течения лимфостаза , у женщин в возрасте от 50 лет до 65 лет после мастэктомии в позднем периоде и эффективности медико психологической реабилитации.
• Задача :выявить у женщин климактерического периода, нарушения гормонального баланса, крово и лимфообращения и разработка проект медико психологической реабилитации.





Результаты

Анализируя данные проведенного анкетирования 25 пациентов с мастэктомией в возрасте от 50 до 65 лет , выявлено у 20 женщин дисгормональное и вегетативные расстройство, наличие лимфостаза и ограничение движения в руке . После проведенного курса лечения магнитотерапии и лазерной терапии крови, соблюдения диеты , наблюдалось уменьшение отека конечности, тревожности и страха, и увеличение подвижности руки.





Методология

Объектом исследования стали пациенты находящиеся на поликлиническом этапе реабилитации.
Предметом исследования явилось выявление изменения на реовазографии сосудов верхней конечности и шеи , выявление вегетативных расстройств, ограничения движения руки на стороне операции.
• Гипотеза исследования:анализ литературных источников.
• Анкетирование пациентов прошедших диагностику методом Люшера,курс транскраниальной магнитотерапии и лазерного облучения крови.
• Статистическая обработка результатов.
• Транскраниальная магнитотерапия , и лазерное облучение крови у пациентов с мастэктомией , по истечению 6 месяцев со дня операции,положительно влияют на кровообращение, лимфодренаж, на уменьшение воспаления, и регенерацию тканей.

Acknowledgement

Выражаем благодарность коллективу КГП на ПХВ поликлиники № 3 г. Экибастуза

Заключение

Вывод: внедрение по моему проекту данной медико психологической реабилитации, а именно
1.Курса лечения транскраниальной магнитотерапии и лазерного облучения крови.
2.Введение должности генетического консультанта .
3.Введение должности молекулярного диетолога.
Даст пациентам перспесших операций , возможность ранней реабилитации и проведение генетического анализа , для выявления нарушения обмена веществ , с последующим ее устранением.

III бөлім. Онкологиялық көмекті ұйымдастырудың қазіргі тенденциялары

Раздел III. Современные тенденции организации онкологической помощи

Section 3. Current trends in the organization of oncological care

Bridging Knowledge to Action: Effectiveness of Human Papillomavirus-Related Cancer Awareness Program on Knowledge and Screening Intention among Female Students and Employees of a selected Health Sciences College, North Batinah Oman

Ishraq Hamood Al Obeidani[1], Abhar Rashid Said AL Shihhi[1], Maryam Abdallah Al Mamari, Aqdar Anwar Al Lahuri[1], Manar Ibrahim AL Barhi[1], Hamida Amin Al Lawati[1], Al Hanoof Saif Al Mamari[1] Nouf Salim Al Khanabshi[1], Lamees Dhahi Al Buraiki[1], Sami Sanad Al Zaab[1]i, Younis Nasser Al Mamari[1], Maria Pramila D'Costa[2]* PhD

[1,2] Oman College of Health Sciences North Batinah Branch

*Corresponding Author: maria.dcosta@ochs.edu.om; mariapramila@rediffmail.com

Abstract

Background: Human Papillomavirus is a major public health concern, being a leading cause of cancers. There have been knowledge gaps, limited screening, and low vaccine uptake particularly in Oman.

Objectives: This study aimed to find the effectiveness of an HPV-related cancer awareness program in enhancing knowledge and screening intentions among female students and employees of OCHS NB. The research was based on the modified Theory of Planned Behavior Framework by (Ajzen, 1991)

Methods: A pre-experimental, one group pre-test and post-test design with cross sectional approach was employed. A total of 125 students and employees of a selected government Health Science College were chosen randomly to participate in the awareness program. Knowledge and screening intention were measured through a structured knowledge questionnaire (Ogilvie et.al, 2013) and the screening intention scale with 5-Point Semantic/Likert Scale adapted from the previous studies (Harrison et.al, 2021) before and after implementing the HPV related cancer prevention awareness program. The data were analyzed using SPSS 23.0 version with descriptive statistics (frequency, percentage, mean, and standard deviation) and inferential statistics (Paired t-test, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis, ANOVA test).

Results: Out of 125 participants, the pre-test knowledge scores with a median score of seven showed, majority 60 (48%) with moderate knowledge to poor knowledge 57(45.6%) The pre-test mean screening score was 57.08 with 65(52%) participants below the average showing unfavorable intention to screen for cervical cancer/vaccination. After the awareness program, post-test knowledge significantly increased the mean knowledge scores ($M = 11.69$, $SD = 2.49$; $t_{124} = 3.491$, $p < 0.001$) and post-test mean screening intentions scores ($M = 65.77$, $SD = 11.53$; $t_{124} = 7.61$, $p < 0.001$) with a mean difference of 5.36 and 8.69 respectively. None of demographic variables influenced the pre-test knowledge and screening intentions scores except students' education level($p<.05$) and employee position, ($p<.05$) screening intention scores.

Conclusion: HPV-related cancer awareness program was effective in improving HPV related post-test knowledge and screening intentions among study participants, indicating that the education interventions can promote the proactive health behavior.

Keywords: Knowledge; Humanpapilloma Virus; awareness program, cervical cancer, screening intention, effectiveness; female students; employees.

Personalized selection of anti-cancer drugs using the patented MTAM-HFA technology for the treatment of head and neck cancer and other types of malignant tumors

Professor Chen Chien-Chung

Taipei Medical University, Taiwan

Key points:

- *By 2040, the number of cancer cases is expected to increase to 29.4 million per year.*
- *The global average survival rate is 50%.*
- *The market for anti-cancer drugs will reach USD 581 billion by 2030.*

The main problems of modern therapy:

- Lack of tools for accurate and fast selection of medicines for a specific patient.
- High cost and duration of clinical trials.
- Weak correlation between laboratory and actual clinical results.

The solution is MTAM-HFA technology:

- An innovative microtubular membrane (MTAM) obtained by electrospinning allows testing the effectiveness of anti-cancer drugs on the cells of a specific patient.
- Test results are available within 7-10 days, with up to 92% accuracy.
- Eliminates the need for trial and error in treatment.
- It is used for various types of cancer: breast, lung, colon, head and neck.

Advantages of MTAM-HFA:

- Fast and inexpensive diagnosis of optimal therapy.
- The ability to predict the individual patient's response.
- Reduction of time and costs for clinical trials (especially phase II).
- High reproducibility and reliability of results.

Scientific and practical base:

- More than 20 patents in the USA and Taiwan, including international PCT applications.
- More than 30 publications in peer-reviewed journals (SCI).
- 5 active IRB studies in Taiwan.
- A high correlation was confirmed between the test results and the clinical effect in patients.

Clinical data:

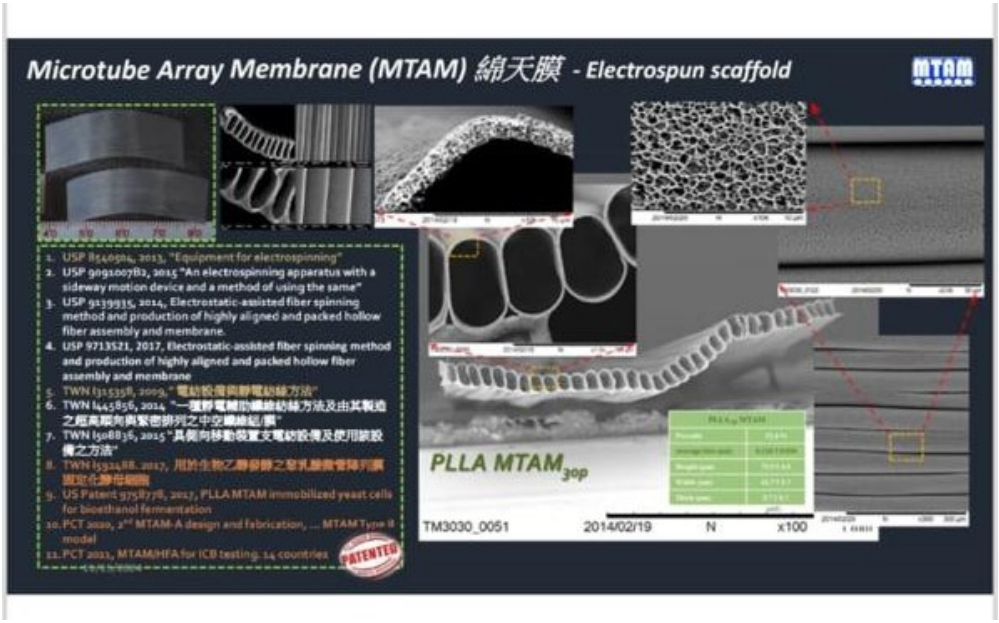
- In patients with oropharyngeal cancer (OCC), MTAM-HFA technology has identified the best drugs (e.g., 5-FU, cisplatin).
- The test results are confirmed by MRI and angiogenesis studies.

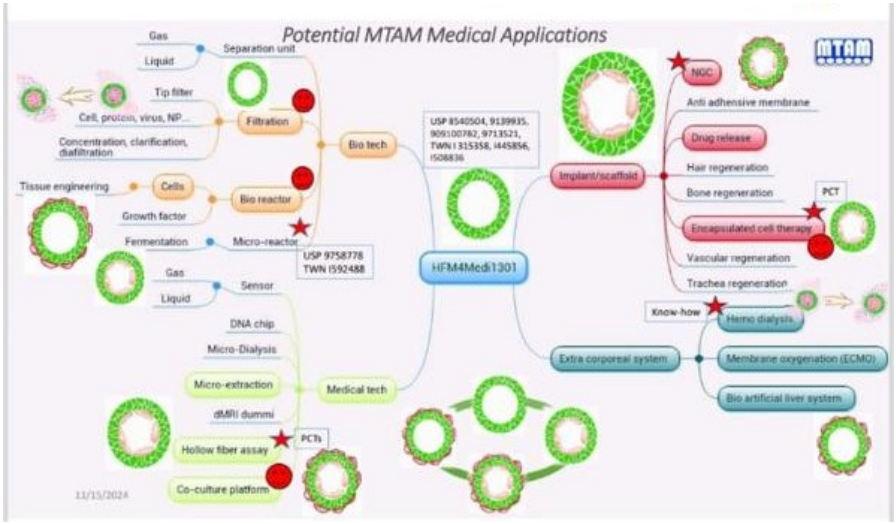
Development and recognition:

- Wins in international competitions (Guangzhou, Shanghai, Taipei MedTech, InnoVEX).
- Collaboration with clinics and research centers, including Wan Fang Hospital and BIOLasco.

Commercial strategy:

- Implementation of MTAM-HFA in the practice of personalized oncotherapy and preclinical research.
- Technology promotion in Southeast and East Asian countries





Мейіргерлік білімді трансформациялау –қатерлі ісіксіз болашаққа қадам

Коконбаева Айдана

Арнайы пән оқытушысы, Жамбыл жоғары медициналық колледжі

Андатпа

Әлемде және Қазақстанда онкологиялық аурулардың өсуі медбикелерді даярлауды қайта қарастыруды талап етеді. Қазіргі заманғы мейірбикелік практика дәлелді медицинаға, көпсалалы тәсілге және инновациялық технологияларға негізделуі керек. Мейіргерлердің (медбикелердің) білімін өзгерту қатерлі ісіксіз болашақты құрудың негізгі шарты болып табылады.

Кілт сөздер: *Онкология, дәлелді тәжірибе, мейіргерлік білім, паллиативтік күтім, онкологиялық білім беру симуляциясы.*

Аннотация

Рост онкологических заболеваний в мире и в Казахстане требует пересмотра подготовки медицинских сестёр. Современная сестринская практика должна основываться на доказательной медицине, мультидисциплинарном подходе и инновационных технологиях. Изменение знаний медсестёр является ключевым условием создания будущего без рака.

Ключевые слова: *Онкология, доказательная практика, сестринское образование, паллиативная помощь, Симуляция онкологического обучения.*

Annotation

The increase in oncological diseases worldwide and in Kazakhstan requires a reconsideration of nurse training. Modern nursing practice should be based on evidence-based

medicine, a multidisciplinary approach, and innovative technologies. Transforming nurses' knowledge is a key condition for creating a future without cancer.

Keywords: *Oncology, Evidence-based practice, nursing education, Palliative care, Oncology education simulation.*

Кіріспе

Тақырыптың өзектілігі:

Онкологиялық аурулар әлемдегі сырқаттанушылық пен өлім-жітімнің басты себептерінің бірі болып қала береді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) мәліметтері бойынша, 2023 жылы 19,3 млн-нан астам қатерлі ісік ауруы тіркелді, ал өлім саны 10 млн-нан асты. Сарапшылардың болжамдары алдын алу және ерте анықтау бойынша белсенді шараларсыз науқастардың саны тек арта түсетінін көрсетеді [1,2, с 6].

Қазақстан да осы жаһандық проблемадан тыс қалмайды. ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің Ұлттық онкологиялық тіркеліміне сәйкес жыл сайын 40 мыңнан астам жаңа жағдай қатерлі ісіктер анықталады, диспансерлік есепте 200 мыңнан астам пациент тұр. Бұл ретте жағдайлардың 60% - ға жуығы кеш сатыларда анықталады, бұл емдеу тиімділігін айтарлықтай төмендетеді және денсаулық сақтау жүйесінің шығындарын арттырады.

Қазіргі жағдайда қатерлі ісікке қарсы күрес тар медициналық қызметтен асып түседі. Алдын алу, халықты ағарту, пациенттерді сүйемелдеу және күту шаралары маңызды бола түсуде. Дәл осы жерде мейіргер пациентпен және оның отбасымен тікелей байланыста болатын маман ретінде шешуші рөл атқарады.

Негізінен дәрігердің тағайындауларын орындауға бағытталған мейіргер ісінің дәстүрлі моделі енді жаңа қиындықтарға жауап бермейді. XXI ғасырдағы мейіргер тек күтім дағдыларына ғана емес, сонымен қатар дәлелді медицина, коммуникация, психоәлеуметтік қолдау саласындағы құзыреттерге ие болуы, сондай-ақ заманауи цифрлық технологияларды меңгеруі тиіс.

Мейіргерлік білімді трансформациялау, орта медициналық буын кадрларын даярлаудың мазмұны мен әдістерін өзгерту-онкологиялық аурулармен күрес жөніндегі ұлттық бағдарламаларды табысты іске асырудың және денсаулық сақтау саласындағы орнықты даму мақсаттарына қол жеткізудің қажетті шарты. Мейіргерлердің жаңартылған құзыреттері онкологиялық науқастардың өмір сүру сапасын арттырып қана қоймай, «қатерлі ісіксіз болашақты» қалыптастыра отырып, қатерлі ісіктің алдын алуда шешуші рөл атқарады [1,2, с 8].

Негізгі бөлім

Онкологиялық аурулардың өсуі жағдайында медбикелердің дәстүрлі дайындығы

енді уақыт талабына сай келмейді. Медбике дәрігердің тағайындауларын орындаушы ғана емес, сонымен қатар профилактика, диагностика, емдеу және оңалту процесінің тәуелсіз қатысушысы болып табылады. Соңғы жылдары ДДҰ орта медициналық персоналдың құзыретін кеңейтпей, қатерлі ісікке қарсы күресте тұрақты нәтижелерге қол жеткізу мүмкін емес екенін атап өтті.

Білімді түрлендіру мыналарды қамтиды:

Білім беру бағдарламаларын жаңарту колледждер мен ЖОО-лар, онкология, психо-онкология, коммуникация бойынша модульдерді енгізу.

Онкологиялық орталықтарда курстар, тренингтер, тағылымдамалар арқылы жұмыс істейтін медбикелердің біліктілігін арттыру.

Пәнаралық тәсіл мейіргер онкологтармен, психологтармен, әлеуметтік қызметкерлермен белсенді қарым-қатынас жасағанда.

2. Онкологиядағы мейірбике ісінің жаңа парадигмасы

2.1. Дәлелді тәжірибе

Мейірбике клиникалық хаттамалармен жұмыс істей білуі, күтім стандарттарын білуі, шешім қабылдау үшін зерттеу нәтижелерін қолдана білуі керек. Мысалы, қысым жарасының дұрыс алдын алу, тамақтануды қолдау, симптомдарды бақылау пациенттердің өмір сүру сапасын жақсартады және асқынуларды азайтады [1,2, 3 с 1,2].

2.2. Цифрландыру және телемедицина

Заманауи ақпараттық жүйелер медбикеге пациенттердің электронды карталарын жүргізуге, тест нәтижелерін бақылауға, сапарларды жоспарлауға мүмкіндік береді. Телемедициналық платформалар шалғай аймақтардағы пациенттерге кеңес беруге, дәрі-дәрмектерді қабылдау және тексеруге бару туралы еске салуға мүмкіндік береді.

2.3. Психоәлеуметтік қолдау

Қатерлі ісік диагнозы әрқашан стресс болып табылады. Медбике ақпарат беруші ретінде әрекет етеді, науқас пен оның отбасына күтім жасау дағдыларын үйретеді, емдеуге ынталандырады. Психологиялық қолдау әдістерін меңгеру (белсенді тыңдау, эмпатия, стресс-менеджмент) — жаңа құзыреттердің міндетті бөлігі.

2.4. Алдын алу және скрининг

Медбике қауіп факторлары (темекі шегу, алкоголь, семіздік, төмен физикалық белсенділік) туралы халықты хабардар етуде жетекші рөл атқарады, скринингтерді ұйымдастыруға қатысады (маммография, жатыр мойны цитологиясы, колоректальды тест), вакцинация жүргізеді (HPV-ге қарсы).

3. Мейірбике ісіндегі инновациялық технологиялар

Мобильді қосымшалар: дәрі-дәрмектерді қабылдау туралы еске салғыштар, әл-

ауқат күнделігін жүргізу.

Мейірбикелік кабинеттер / емханалар: кеңес беру, стомаға күтім жасау, таңу, тамақтану.

Өзіне-өзі көмек көрсету: асқынуларды қалай тануға болады, қашан жедел көмекке жүгіну керек.

Күрделі клиникалық жағдайларды пысықтау үшін болашақ медбикелерді оқытуда симуляциялық орталықтарды пайдалану.

4. Трансформацияның күтілетін нәтижелері

Ерте анықтау арқылы өлім-жітімнің төмендеуі.

Сапалы күтімнің арқасында пациенттердің өмір сүру сапасын жақсарту.

Қоғамда алдын алу мәдениетін қалыптастыру.

Кадрлық әлеуетті нығайту. Денсаулық сақтау жүйесі.

5. Әлеуметтік-экономикалық әсер

Мейіргерлерді даярлауға және олардың құзыреттерін кеңейтуге инвестициялар экономикалық тұрғыдан негізделген: алдын алу және ерте диагностика мемлекетке қатерлі ісіктің кеш сатыларын емдеуге қарағанда арзанырақ. Мүгедектік пен өлім-жітімнің төмендеуі халықтың еңбек әлеуетін сақтайды және демографиялық көрсеткіштерді жақсартады.

Қорытынды:

Денсаулық сақтаудың заманауи тенденциялары мынаны көрсетеді: мейірбикелік білімді сапалы жаңартусыз онкологиялық аурулардың өсуіне тиімді қарсы тұру мүмкін емес. Мейірбике тек тағайындауды орындаушы ғана емес, сонымен қатар пациенттерді алдын-алу, ерте анықтау, күту және психоәлеуметтік қолдаудың белсенді қатысушысы болуы керек [3,2, с 6].

Мейіргерлік білім мен тәжірибені өзгерту-бұл елдегі жағдайды өзгертуге және қатерлі ісікке қарсы ұлттық және жаһандық мақсаттарға жетуге жақындатуға қабілетті стратегиялық шара. Дәлелді практиканы, цифрлық технологияларды енгізу, коммуникация мен халықты оқытуда құзыреттілікті дамыту-осының барлығы денсаулық сақтау жүйесі жұмысының тиімділігін және пациенттердің өмір сүру сапасын арттырады.

Осылайша, мейіргерлердің жаңартылған білімі мен дағдылары қатерлі ісіксіз болашақты құруға нақты үлес қосады. Бұл процесті Мемлекет, білім беру мекемелері және кәсіби қоғамдастық деңгейінде қолдау-онкологиялық қызмет пен ұлт денсаулығының тұрақты дамуының кепілі [4,5, с 7].

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі. «Қазақстанның онкологиялық көмекті жаңғырту жөніндегі Кешенді жоспар» (2023–2025 жж.). – Астана, 2023.

2. ҚР Денсаулық сақтау министрлігі. Онкологиялық аурулардың 2023 жылғы статистикалық деректері. – Астана, 2024.

3. Онкологиялық науқастарға мейірбикелік күтім // «C-Med» медициналық портал. – 2022. (https://c-med.mcfr.kz/article/1666-onkologiyalyk-naukastarga-meyirbikelik-kutim).

4. Паллиативті күтім (оқу құралы). – Ust.kz порталы. – 2022. (https://ust.kz/word/palliativti_komek-312280.html).

К вопросу преодоления психологической неготовности выпускников к работе в сложных условиях: из опыта работы предметного кружка «онкология и жизнь» для учащихся медицинского колледжа

Сидорская Марина

Преподаватель, Гомельский государственный медицинский колледж

Аннотация. *В работе описан опыт и проведен анализ эффективности организации кружка «Онкология и жизнь» для учащихся Гомельского медицинского колледжа как дополнения к другим формам и методами формирования знаний и повышения мотивации будущих медицинских работников. Поднимается часто возникающая проблема боязни и психологической неготовности выпускников работать в сфере онкологической помощи. Автор опирается не только на педагогический опыт, но и на многолетний практический опыт работы с пациентами онкологического стационара.*

Ключевые слова: *онкология, онкопациент, паллиативная помощь, стрессоустойчивость, эмпатия, психоэмоциональная готовность к работе.*

Введение

Каждый год, овладев теоретическими знаниями, а также практическими умениями и навыками, определенное количество выпускников учреждения образования «Гомельский государственный медицинский колледж» распределяются в онкодиспансеры, хосписы, больницы паллиативной помощи. Анализируя отзывы выпускников, необходимо отметить, что одной из трудностей для них является недостаточный уровень тех профессиональных компетенций, которые требует специфика работы в этой области медицины. В частности – это психологический аспект, моральная

и психоэмоциональная подготовленность обучающихся к работе в таких отделениях. Речь идет об уровне профессионально важных качеств коммуникативной сферы (коммуникативная компетентность); эмоционально-волевой сферы (стрессоустойчивость, эмпатия, настойчивость и т.д.); ценностно-мотивационной сферы (уважение каждого человека, стремление помогать людям и т.д.); организационно методической сферы (умение планировать свою деятельность, организовывать деятельность и взаимодействие других, представлять результаты своей работы и т. д.); познавательной сферы (умение понимать причины поведения людей, творческое мышление и т. д.).

Таким образом, работая преподавателем медицинского колледжа в современных условиях, сталкиваешься с рядом противоречий: между возросшими требованиями к качеству знаний будущего медицинского работника в сфере онкологии и сжатыми временными рамками, отведенными программой на изучение предмета «Основы общей онкологии» (48 часов); между потребностью общества в грамотных специалистах в сфере оказания медицинских услуг онкологическим пациентам и сложившимися свойствами личности обучающихся и, как следствие, их низкой мотивацией оказаться на рабочих местах в онкодиспансерах, хосписах, больницах паллиативной помощи.

Эти факторы привели к решению создать предметный кружок, основная цель которого – сформировать и совершенствовать вышеизложенные профессионально важные компетенции.

Цель – обосновать и систематизировать опыт, проанализировать эффективность работы кружка «Онкология и жизнь» для учащихся медицинского колледжа.

Материалы и методы исследования – обобщение педагогического опыта, проведение анкетирования с последующим анализом результатов.

Результаты исследования и их обсуждение

Совместно с учащимися-выпускниками Гомельского медицинского колледжа с 2018 г. проводились собрания круглого стола по вопросам психологических аспектов, касающиеся оказания медицинских услуг работниками среднего звена в онкологии. В них приняло участие более 75 учащихся. В результате анкетирования выявилась неготовность многих выпускников работать в отделениях онкологического профиля, несмотря на высокий уровень их профессиональной подготовленности в рамках выполнения медицинских манипуляций. Что и подтвердило верность решения создать кружок «Онкология и жизнь».

Для работы кружка была составлена и утверждена программа кружка. Каждое кружковое занятие имеет внутреннюю структуру, составленную согласно программе методическую разработку. Вводная часть состоит из теоретического материала,

включающего презентации, тесты, анкеты. Практическая часть включает в себя круглые столы, тренинги, практикумы.

Разработанные материалы для проведения отдельных заседаний кружка могут служить будущим медработникам пособием при работе в онкологических диспансерах и использоваться как учебное средство при конкретных ситуациях общения с пациентами онкологического профиля и их родственниками. Различные техники релаксации и другие методы профилактики и психогигиены – попросту musthave медицинской сестры при работе с пациентами онкологического профиля.

Программой предусматривается изучение извечных вопросов жизни и смерти с учетом медицинской психологии, где большое внимание уделяется формированию активной жизненной позиции в вопросах здоровья и ответственности за жизнь. Учащиеся формируют и совершенствуют такие качества как стрессоустойчивость, эмпатия, уважение каждого пациента, стремление помогать людям, умение понимать мотивы поведения пациентов онкологического профиля. их родственников. А приобретение умения устанавливать грамотную коммуникацию, апеллировать навыками психогигиены при работе с данным контингентом очевидно уже по завершению программы заседаний кружка.

По окончанию занятий в кружке проводится обязательное анонимное анкетирование участников. За время работы кружка с 2018 по 2023 годы в нем участвовало 115 учащихся.

Анализируя результаты анкетирования, можно сказать о высокой степени заинтересованности учащихся в работе кружка.

В частности 98% учащихся отметили важность поднимаемых тем на заседаниях для применения их на практике; 92% опрошенных пожелали еще больше времени уделить психологическим практикам (по стрессоустойчивости, осознанности, любви к себе, к людям и к миру в целом); 85% учащихся отметили получение ценной информации в работе и, конкретно, в выстраивании коммуникаций с пациентом (ребенком, взрослым), его родственниками, в умении понимать причины поведения пациентов онкологического профиля и их родственников. Большинство учащихся отметили получение «инсайта» уже с первого занятия в теме своего профессионального выбора, что еще больше повысило их мотивацию к работе медицинской сестрой, а самое главное – уменьшилось количество страхов в случае распределения в такие лечебные учреждения как онкологические диспансеры и медицинские учреждения паллиативной помощи и в работе с тяжелобольными пациентами.

Выводы

Подводя итог, можно говорить о том, что у кружка, как дополнения к другим формам и методами формирования знаний обучающихся, имеется масса достоинств: добровольное обучение; более мягкий инструмент (soft skills – ставит всех обучающихся в равные условия, нет критериев оценки, что приводит к снижению нервных напряжений, способствуя комфортной эмоциональной обстановке); обучающиеся имеют достаточно времени для глубокого анализа тематики; знания, полученные учащимися, выходят за рамки учебного предмета «Основы общей онкологии», профессиональной компетентности медицинской сестры в этой сфере и дают ответы на экзистенциальные вопросы, делая в свою очередь личность медицинского работника более зрелой.

Кружок «Онкология и жизнь» – средство узкой профессиональной ориентации учащихся медицинского колледжа, в которой тесно переплетаются образовательные, развивающие и воспитательные задачи.

Список использованных источников:

1. Матвейчик Т.В. Трансформация сестринского образования в истории Беларуси: от опыта прошлого – шаг в будущее: научное издание / Т.В. Матвейчик. - Минск: Ковчег, 2020. – 224с.

2. Родина, Л.А. Онкологический больной и его семья / Л.А. Родина //Вместе против рака. Профессиональный информационный журнал. Межрегиональная общественная организация «Вместе против рака» и ООО «АБВ – пресс». – 2004. – №3. – С.19-25.

3. Фоменко, А. Качество жизни онкопациентов от теории к практике. Обзор подходов и методологий исследований качества жизни людей, переживших рак, в США, Европе / А. Фоменко, И. Жихар. – Научно-исследовательское учреждение. Аналитическая группа ЦЕТ, 2014. – 205 с.

Онкологиялық пациенттердің күтімі кезіндегі мейіргердің рөлі

Дидарбекова Макпал

Арнайы пәндер оқытушысы, Жамбыл жоғары медициналық колледжі

Аннотация

Бұл мақалада онкологиялық пациенттердің күтімі кезіндегі мейіргердің рөлі қарастырылады. Онкологиялық аурулардың қазіргі қоғамдағы өзектілігі, олардың науқастардың физикалық, психологиялық және әлеуметтік жағдайына әсері сипатталған. Мейіргердің негізгі міндеттері – медициналық, гигиеналық, психологиялық және ақпараттық қолдау көрсету екендігі ашып көрсетіледі. Сонымен қатар паллиативтік күтім мен хоспис қызметіндегі мейіргердің орны талданады. Зерттеу нәтижесінде мейіргердің кәсіби шеберлігі мен жанашырлығы онкологиялық

науқастардың өмір сапасын жақсартуда шешуші рөл атқаратыны анықталды.

В данной статье рассматривается роль медицинской сестры в уходе за онкологическими больными. Описана актуальность онкологии в современном обществе, её влияние на физическое, психологическое и социальное состояние пациентов. Выявлено, что основными задачами медицинской сестры являются оказание медицинской, гигиенической, психологической и информационной поддержки. Кроме того, проанализирована роль медицинской сестры в паллиативной помощи и хосписных службах. Исследование показало, что профессиональные навыки и сострадание медицинской сестры играют решающую роль в улучшении качества жизни онкологических больных.

This article examines the role of a nurse in the care of cancer patients. The relevance of cancer in modern society, its impact on the physical, psychological and social condition of patients is described. It is revealed that the main tasks of a nurse are to provide medical, hygienic, psychological and informational support. In addition, the role of a nurse in palliative care and hospice services is analyzed. The study revealed that the professional skills and compassion of a nurse play a decisive role in improving the quality of life of cancer patients.

Кілт сөздер: онкология, мейіргер, күтім, паллиативтік көмек, пациент.

Жұмысытық өзектілігі

Қазіргі таңда онкологиялық аурулар әлемдік деңгейде қоғамдық денсаулық сақтау саласының ең өзекті мәселелерінің бірі болып отыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша, қатерлі ісік аурулары өлім-жітім себептері ішінде жүрек-қан тамыр ауруларынан кейінгі екінші орында тұр. Қазақстанда да онкологиялық сырқаттар саны жылдан жылға артып, науқастардың өмір сапасын жақсарту, ерте диагностика мен тиімді күтім ұйымдастыру қажеттілігі күн тәртібінде тұр. [1] Бұл тұрғыда мейіргердің рөлі ерекше маңызға ие. Себебі ол тек медициналық процедураларды орындап қана қоймай, науқастың психологиялық жағдайын қолдап, әлеуметтік мәселелерін шешуге көмектеседі. Онкологиялық науқастардың ұзақ әрі күрделі ем қабылдауы, химио- және сәулелік терапиядан кейінгі асқынулар, ауырсыну синдромдары мейіргердің кәсіби біліктілігі мен жанашырлығын талап етеді. [2]

Сондықтан онкологиялық науқастарға кешенді күтім көрсетудегі мейіргердің рөлін ғылыми тұрғыдан қарастыру – қазіргі медициналық тәжірибеде ғана емес, болашақта онкологиялық қызметті жетілдіруде де аса маңызды.[3]

Онкологиялық пациенттердің ерекшеліктері

Қатерлі ісікке шалдыққан науқастардың күтімі басқа сырқаттарға қарағанда анағұрлым күрделі. Себебі:
1. Физикалық қиындықтар – ауру асқынған сайын ауырсыну синдромы күшейеді, тәбеттің төмендеуі, жүрек айну, әлсіздік, салмақ жоғалту сияқты белгілер пайда болады.
2. Психологиялық әсер – науқастарда үрей, үмітсіздік, қорқыныш, кейде агрессия мен депрессия байқалады.
3. Әлеуметтік мәселелер – жұмысқа қабілеттіліктің төмендеуі, отбасындағы қатынастардың өзгеруі, материалдық қиындықтар.
4. Емдеу ерекшеліктері – хирургиялық операциялар, химиотерапия, сәулелік терапия және олардың жанама әсерлері (шаш түсу, әлсіздік, инфекцияға бейімділік).
Осы жағдайлардың барлығы науқастың толыққанды өмір сүру қабілетіне әсер етеді, сондықтан мейіргер тарапынан жан-жақты қолдау қажет. [5]

Мейіргердің рөлі

Онкологиялық науқастарға күтім жасауда мейіргердің міндеттері өте ауқымды. Ол тек дәрігердің нұсқауларын орындаушы емес, сонымен қатар науқастың сенімді серігі, психологиялық тірегі және әлеуметтік қолдаушысы болып табылады. [6]

1. Медициналық күтім:

Науқастың жалпы жағдайын тәулік бойы бақылау;

Дәрілерді уақытылы және дұрыс енгізу, олардың жанама әсерлерін қадағалау;

Химиотерапия немесе сәулелік терапиядан кейінгі асқынуларды бақылау;

Тамақтану ерекшеліктерін ескеріп, науқастың рационын қадағалау;

Инфекциялардың алдын алу мақсатында стерильділік ережелерін сақтау.

2. Гигиеналық күтім:

Жеке бас тазалығын қамтамасыз ету (жуындыру, ауыз қуысының күтімі, төсек-жайма ауыстыру);

Ұзақ уақыт төсекте жатқан науқастарда ойық жаралардың алдын алу үшін массаж және арнайы жатқызу әдістерін қолдану;

Тері мен шырышты қабаттардың зақымдануын дер кезінде байқау және алдын алу.

3. Психологиялық қолдау:

Науқастың ауруға қатысты қорқыныштарын тыңдау және онымен ашық сөйлесу;

Үміт пен сенімділікті нығайту, өмірге деген қызығушылығын арттыруға көмектесу;

Отбасы мүшелерін науқастың жағдайына бейімдеуге жәрдемдесу;

Қажет болған жағдайда психолог немесе психотерапевтпен байланысын ұйымдастыру.

4. Ақпараттық қолдау:

Науқас пен оның туыстарына күтім ережелерін үйрету;

Дәрілерді қолдану тәсілін түсіндіру;

Медициналық құжаттаманы дұрыс жүргізу және дәрігерге дер кезінде мәлімет беру;

Пациенттің құқықтарын қорғау, оның қажеттіліктерін жеткізу.

5. Рухани және әлеуметтік қолдау:

Науқастың сеніміне, діни немесе мәдени ерекшеліктеріне құрметпен қарау;

Әлеуметтік қызметтермен байланысын қамтамасыз ету (мысалы, мүгедектік рәсімдеу, әлеуметтік көмекке құжат жинау);

Отбасына күтім процесінде демеу көрсету, шаршаудың алдын алу үшін туыстарға кеңес беру.

6. Кәсіби даму рөлі:

Онкология саласындағы жаңа әдістер мен күтім стандарттарын үнемі үйрену;

Заманауи құрал-жабдықтармен жұмыс істей білу;

Мейіргерлік процесті ғылыми тұрғыда дамытуға атсалысу. [6]

Мейіргердің паллиативтік күтімдегі міндеттері:

Ауырсынуды жеңілдететін дәрілерді уақытында беру.

Тыныс алуды жеңілдету, оттегі терапиясын қолдану.

Науқастың физикалық жайлылығын қамтамасыз ету (жуындыру, төсекте жағдайын өзгерту, массаж жасау).

Рухани қолдау көрсету, діни қажеттіліктерін орындауға мүмкіндік жасау.

Отбасы мүшелерімен тығыз байланыс орнатып, оларды күтім процесіне тарту.

Хоспистік жағдайда мейіргер – науқас пен отбасы арасындағы негізгі дәнекер тұлға болып табылады. Ол тек медициналық күтім көрсетіп қана қоймай, психологиялық кеңес беріп, әлеуметтік қолдау ұйымдастырады. Көп жағдайда мейіргер пациенттің соңғы күндерін адамгершілікке толы, тыныш жағдайда өткізуіне мүмкіндік жасайды

Паллиативтік күтім және хоспис қызметі

Аурудың соңғы кезеңінде паллиативтік көмек ерекше орын алады. Оның басты мақсаты – науқасты толық айықтыру емес, ауырсынуын жеңілдету және өмір сапасын жақсарту. Мейіргердің паллиативтік күтімдегі міндеттері:

- Ауырсынуды жеңілдететін дәрілерді уақытында беру.
- Тыныс алуды жеңілдету, оттегі терапиясын қолдану.
- Науқастың физикалық жайлылығын қамтамасыз ету.
- Рухани қолдау көрсету, отбасы мүшелерімен байланыс орнату.

- Хоспистік жағдайда мейіргер – науқас пен отбасы арасындағы негізгі дәнекер тұлға болып табылады. [5]

Ұсыныс:

1.Онкологиялық науқастарға күтім көрсетуде мейіргерлердің кәсіби дайындығын арттыру мақсатында үздіксіз білім беру курстарын ұйымдастыру.

2.Химиотерапия, сәулелік терапиядан кейінгі асқынуларды жеңілдету бойынша арнайы әдістемелік нұсқаулықтарды әзірлеу.

3.Мейіргерлердің психологиялық қолдау көрсету дағдыларын жетілдіру үшін тренингтер өткізу.

4.Әрбір онкологиялық орталықта паллиативтік көмек көрсететін арнайы мейіргерлік қызметті дамыту.

5.Науқастардың отбасы мүшелерін күтім процесіне тарту және оларды оқыту жүйесін жолға қою.

6.Мейіргерлердің жұмыс жағдайын жақсарту, еңбегін материалдық және моральдық тұрғыдан қолдау.

7.Онкология саласындағы халықаралық тәжірибелерді енгізіп, мейіргерлердің шетелдік тәжірибеден өту мүмкіндіктерін кеңейту.

Қорытынды: Онкологиялық пациенттердің күтімі – ерекше жауапкершілікті талап ететін процесс. Мейіргер тек медициналық көмек көрсетуші ғана емес, сонымен қатар психологиялық, әлеуметтік қолдаушы рөлін атқарады. Оның кәсіби шеберлігі, мейірімділігі, жанашырлығы науқастың жағдайын жеңілдетіп, өмір сапасын арттыруға ықпал етеді. Сондықтан онкологиялық науқастарға күтім жасауда мейіргердің рөлі орасан зор және қоғам үшін аса құнды.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1.Қожахметова А.Ж. Мейіргер ісі негіздері. – Алматы: Эверо, 2020.
2.World Health Organization. Cancer nursing: scope and standards of practice. – Geneva: WHO, 2021.
3.Жолдасбекова С. Клиникалық мейіргер ісі. – Астана: Фолиант, 2019.
4.Pavlish C., Ceronsky L. Oncology Nursing: Patient-Centered Care. – New York: Springer, 2020.
5.Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі. Онкологиялық көмек көрсетуді ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулық. – Астана, 2022.
6.Corner J., Bailey C. Cancer Nursing: Care in Context. – Wiley-Blackwell, 2018.

Поэтапное формирование коммуникативных компетенций

учащихся медицинского колледжа с пациентами онкологического профиля в условиях симуляционного обучения

Шепелевич Виктория

Заведущая Лабораторией по отработке навыков,

Гомельский государственный медицинский колледж

Аннотация. *Статья посвящена поэтапному формированию коммуникативных компетенций с использованием симуляционных технологий, как важного средства для повышения профессионализма будущих медицинских работников среднего звена, что способствует более глубокому осмыслению профессиональной роли, снижает риск коммуникативных ошибок и повышает качество сестринского ухода.*

Ключевые слова: *коммуникация, коммуникативные компетенции, симуляционное обучение, онкологические пациенты*

Введение

Тема коммуникативной компетентности и бесконфликтного общения является одной из центральных в профессиональной деятельности медицинского специалиста. Погрешности в профессиональном общении – самый частый фактор деонтологических нарушений, конфликтных ситуаций, недовольства и жалоб пациентов и их родственников.

Онкологические заболевания представляют собой не только медицинскую, но и глубокую психологическую проблему. Пациенты, столкнувшиеся с онкологическим диагнозом, переживают широкий спектр эмоций — от страха и тревоги до отчаяния и гнева. В этой ситуации медицинская сестра становится не просто исполнителем лечебных процедур, но и важным коммуникативным звеном, способным оказать моральную поддержку, создать атмосферу доверия и облегчить эмоциональное состояние пациента.

Таким образом, очень важно в процессе обучения в медицинском колледже отрабатывать с учащимися сценарии ведения диалога с пациентами в наиболее часто встречающихся ситуациях с учетом актуальных возражений и противоречий. Для медицинских сестер, работающих с онкологическими пациентами коммуникативные сценарии, требуют особого внимания. Это не просто разговоры, а тонкие, эмоционально насыщенные взаимодействия, где каждое слово может иметь большое значение.

Актуальность

Современная система здравоохранения предъявляет определенные требования к выпускникам медицинского колледжа. Помимо базовых знаний, в повседневной практике медицинского специалиста приобретают особую значимость навыки общения.

Подготовка медицинских сестер к сложным коммуникативным диалогам с онкологическими пациентами — это не просто обучение техникам общения. Это

формирование эмоциональной устойчивости, эмпатии и способности вести диалог в условиях психологического напряжения.

Эффективная коммуникация предполагает понимание пациента и соответствующее реагирование на его поведение с целью решения профессиональных задач.

Результаты исследования

Лаборатория по отработке навыков (симуляционный центр) на базе медицинского колледжа дает учащимся возможность практиковать и совершенствовать свои коммуникативные навыки путем участия в реалистичных сценариях, имитирующих ситуации из реальной жизни.

Имитируя общение с пациентами, учащиеся могут практиковать и совершенствовать свои эмоциональные и коммуникативные навыки в контролируемой среде, прежде чем взаимодействовать с реальными пациентами. Симуляционное обучение позволяет учащимся, осваивающим различные клинические дисциплины, собираться вместе и практиковать командную работу, общение и совместное принятие решений. Посредством совместного моделирования учащиеся могут лучше понять роли друг друга, улучшить междисциплинарное взаимодействие и результаты оказания медицинской помощи пациентам.

В рамках образовательного процесса в нашем медицинском колледже разработан сквозной тренинговый курс овладения коммуникативными навыками.

В течение первого года обучения учащиеся специальностей «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Зуболечебное дело» и «Медико-профилактическое дело» изучают основы коммуникации на факультативном курсе «Введение в профессию» и в рамках учебного предмета «Медицинская психология, этика и деонтология», где на практических занятиях в тренинговой форме закрепляют навыки общения с применением методик «сюжетно-ролевая игра» и «стандартизированный пациент».

Учащиеся отрабатывают сценарии результативного и бесконфликтного ведения диалога с пациентами в наиболее часто встречающихся ситуациях с учетом самых частых возражений. При этом отсутствует риск навредить и усугубить состояние пациента, имеется возможность многократного повторения и закрепления приемов общения.

Это позволяет повысить качество отработки возражений пациента и грамотно нейтрализовать его негатив, что непосредственным образом влияет на имидж самого медицинского специалиста, так и лечебного учреждения, где он работает.

Развитие коммуникативных навыков медицинского персонала является ключевым фактором в обеспечении качественной психологической поддержки онкологических

пациентов.

Следующим шагом в развитии коммуникативных навыков является факультативный курс «Конфликтология» для учащихся выпускных групп специальностей «Сестринское дело» и «Лечебное дело».

Также для выпускников разработан курс «Коммуникации и конфликтология» в объеме 40 часов, из которых 32 часа отведены на практические занятия. На лекционных занятиях путем применения дискуссии и «мозгового штурма» определяются «проблемные ситуации», требующие качественной отработки навыков общения. На практических занятиях учащиеся в форме сюжетно-ролевой (деловой) игры отрабатывают базовые коммуникативные навыки, моделируют определенные рабочие ситуации.

Перед проведением сюжетно-ролевой (деловой) игры разрабатывается сценарий, инструктаж для каждой роли, творческие профессионально-ориентированные задания и подготавливается соответствующее материальное оснащение.

В самом начале игры преподаватель формулирует проблему, цель, знакомит с правилами игры, распределяет роли, формирует группы. Одним из условий проведения игры является вовлеченность всех учащихся в процесс, работа идет в малых группах, в которых один учащийся медицинский работник, другой – пациент. Более подготовленные учащиеся выделяются в качестве экспертов. Обычно происходит деление на несколько групп, количество которых зависит от числа заданий и количества ролей. Чаще всего группы состоят из трех-четырех человек. Например, медицинский работник, пациент и эксперт-наблюдатель. Пациента могут сопровождать родственники, если это ребенок или пожилой человек, тогда количество участников увеличивается.

После проведения игры в форме дебрифинга участники анализируют результаты. В процессе обсуждения качества коммуникации применяется обратная связь от «пациента». Эксперт-наблюдатель дает оценку составленному диалогу (скрипту). Критерии оценки преподаватель объясняет в начале проведения игры. Преподаватель оценивает работу малых групп, по решению творческих заданий с учетом предложенных ролей, и оценивает качество коммуникации. Для этого разработан чек-лист, в котором структурированы коммуникативные навыки в соответствии с этапами медицинского интервью и указаны их критерии оценивания. С помощью данного чек-листа нивелируется субъективное отношение.

Разыгрывание ролей на треннинге помогает сформировать профессиональную и коммуникативную компетентность учащихся. Это мощный и эффективный метод, позволяющий не только отработать конкретные сценарии, но и развить эмоциональную чувствительность, эмпатию и уверенность в сложных диалогах.

Далее она подкрепляется учебной практикой в стационарных условиях лечебных учреждений.

Выводы

Использование сюжетно-ролевой игры в обучении медицинских сестер навыкам общения с онкологическими пациентами является эффективным и практико-ориентированным методом. Этот подход позволяет не только отрабатывать типовые сценарии взаимодействия, но и формировать эмоциональную устойчивость, эмпатию и уверенность в сложных ситуациях. Медицинские сёстры учатся адаптировать стиль общения к индивидуальным особенностям пациента, справляться с эмоциональными реакциями и выстраивать доверительные отношения.

Лаборатория по отработке навыков (симуляционный центр) обеспечивает безопасную и благоприятную среду для развития и формирования коммуникативных компетенций будущих медицинских специалистов. Предлагая реалистичные сценарии, возможность многократного повторения и механизмы обратной связи, симуляционный центр способствует получению практического опыта управления ситуациями, которые могут возникнуть в профессиональной деятельности, без прямого воздействия на пациентов.

Такая форма обучения способствует более глубокому осмыслению профессиональной роли, снижает риск коммуникативных ошибок и повышает качество сестринского ухода. В условиях онкологической практики, где каждое слово может иметь терапевтическое значение, сюжетно-ролевая игра становится не просто учебным инструментом, а важным этапом профессионального становления.

Список использованных источников:

1. Басырова, Н.М. Модели взаимодействия с пациентами (деловая игра) / Н.М. Басырова. – Москва, 2022, 34 с.

2. Давыдов, Н.С. Навыки общения с пациентами: симуляционное обучение и оценка коммуникативных навыков в медицинском вузе: методическое руководство / под науч.ред. Н.С. Давыдова, Е.Д. Дьяченко. - Екатеринбург: АТгрупп, 2019, 128 с.

3. Дощанов, Д.Х. Роль стандартизированного пациента в оценке коммуникативной компетентности / Д.Х. Дощанов, Н. Мендалиев // Вестник Казиму. – 2015. – №3. – С. 327 – 329.

Ағарту және халықты тарту арқылы онкологиялық аурулардың алдын алу

Дуйсенгалиева Гульнар[1], Нургалиева Акжарқын[2], Дюсенбаева Айгерим[3]

[1] Арнайы пән оқытушысы,педагог –модератор,

[2] арнайы пән оқытушысы, педагог –сарапшы, [3] арнайы пән оқытушысы.

Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі

Аннотация

Бұл жұмыс онкологиялық аурулардың алдын алуда ағартушылық пен халықты белсенді тартудың маңыздылығын қарастырады. Халық арасында білім деңгейін арттыру арқылы ауруларды ерте анықтау мен алдын алу мүмкіндігі көтеріледі. Сонымен қатар, скрининг пен салауатты өмір салтын насихаттау арқылы қатерлі ісіктердің таралуын төмендетуге болады.

This paper examines the importance of education and public engagement in the prevention of oncological diseases. Raising awareness among the population contributes to early detection and prevention. Promoting screening and a healthy lifestyle can help reduce the incidence of cancer.

Мақсаты: Қазақстандағы онкологиялық профилактика жағдайын талдау; қазіргі тенденциялар мен статистика негізінде профилактиканың тиімді стратегияларын ұсыну; жаһандық ұсыныстарды ескере отырып, ұлттық контекстке бейімделген шаралар жүйесін сипаттау.

Жыл сайын онкологиялық ауруларға шалдыққан адамдар саны үнемі артып келеді. Мұндай үрдісті мамандар әртүрлі факторлармен байланыстырады: өмір сүру ұзақтығының артуы, қоршаған ортаның ластануы, зиянды әдеттер, гиподинамия, тұқым қуалаушылық және басқа да себептер.

Онкологиялық аурулардан болатын жоғары өлім-жітім, ең алдымен, науқастардың дәрігерге тым кеш жүгінуімен байланысты, мұндай кезде ауруды емдеу күрделене түседі. Алайда қазіргі медицинаның жетістіктері қатерлі ісікті ерте сатысында анықтауға және толық емдеуге, сонымен қатар көптеген обыр алдындағы жағдайларды жоюға мүмкіндік береді. Дамыған елдерде қатерлі ісікке қарсы күресте бастапқы және екінші реттік профилактикаға ерекше мән беріледі.

Бастапқы профилактика онкологиялық аурулардың даму қаупін 70–90%-ға дейін төмендетуге мүмкіндік береді.

Бастапқы профилактика – бұл ісік алды өзгерістердің алдын алу үшін қоршаған ортаның қолайсыз факторларын жою, өмір салтын түзету және ағзаның резистенттілігін арттыруға бағытталған шаралар кешені.

Онкогигиеналық профилактика – адамға канцерогендік (ісік туғызатын) заттардың әсерін болдырмауға бағытталған шаралар жиынтығы. Канцерогендердің негізгі көздерінің бірі –

темекі шегу. Темекі түтінінде 3500-ден астам химиялық қосылыс бар, олардың арасында полициклді ароматты көмірсутектер, нитроқосылыстар және ароматты аминдер бар, бұлардың барлығы күшті канцерогендер болып табылады. Зерттеулерге сәйкес, өкпе обырының 90%-ы ер адамдарда темекі шегудің салдарынан дамиды. Темекі түтіні асқазан-ішек жолы, қуық, ұйқыбез ісіктерінің де даму қаупін арттырады. Тіпті пассивті шегушілер де қауіп тобына жатады – олардың өкпе обырына шалдығу ықтималдығы екі есе жоғары.

Дұрыс инсоляция

Күн сәулесінің артық әсері тері жасушаларының трансформациясын тудыруы мүмкін, бұл меланома немесе терінің басқа да қатерлі ісіктеріне әкеледі. Жиі күнге күю немесе солярийге бару әсіресе аққұбалар мен тері обырына тұқым қуалайтын бейімділігі бар адамдар үшін қауіпті.

Алкогольді тұтыну

Алкогольді шамадан тыс қолдану асқазан-өңеш жолының, бауырдың, ұйқыбездің қатерлі ісіктерінің даму қаупін айтарлықтай арттырады. Алкоголь мен темекі шегуді бірге қолдану бұл тәуекелді бірнеше есеге көбейтеді.

Психогигиена

Адамның психикалық саулығы мен қатерлі ісік даму қаупінің арасында тығыз байланыс бар екендігі дәлелденген. Созылмалы стресс, эмоционалды күйзеліс, депрессия – иммундық жүйенің әлсіреуіне және қатерлі процестердің белсендірілуіне әкеледі.

Салауатты әрі теңгерімді тамақтан

Тағам рационы ісік дамуына елеулі әсер етеді. Майлы, қуырылған, ысталған тағамдарды, жануар майларын көп тұтыну қатерлі ісік қаупін арттырады. Алдын алу мақсатында көкөніс, жеміс-жидек, дәнді дақылдар, теңіз өнімдері, витаминдерге (A, C, E) және антиоксиданттарға бай тағамдарды көбейту ұсынылады.

Клетчатка ішектегі тағам транзитін жылдамдатып, канцерогендермен ұзақ байланысын азайтады. Селен, йод, полифенолдар (жасыл шай, бұршақ тұқымдастар), омега-3 май қышқылдары (теңіз балықтары) ісікке қарсы әсер береді.

Биохимиялық профилактика

Бұл бағыттың мақсаты – канцерогендердің бластомогендік әсерін химиялық және биологиялық препараттар арқылы бейтараптандыру. Мысалы, ауыр металдар мен канцерогендерді судан тазартуға арналған арнайы препараттарды қолдану биохимиялық профилактиканың үлгісі болып табылады.

Медико-генетикалық профилактикаТұқым қуалайтын бейімділігі бар адамдарды ерте анықтау және оларға салауатты өмір салтын ұстану, канцерогендерден аулақ болу ұсынылады.

Вакцинация

Кейбір қатерлі ісіктер (мысалы, жатыр мойны обыры) вирустық инфекциялардың салдарынан дамиды. Бүгінгі таңда адам папилломавирусына қарсы тиімді вакцина бар.

Өзін-өзі емдеуден бас тарту

Интернеттегі күмәнді ақпараттар негізінде өзін-өзі емдеу немесе емшілерге жүгіну қауіпті. Кейбір биологиялық қоспалар ісік жасушаларының өсуін стимуляциялауы мүмкін.

Екінші реттік профилактика

Екінші реттік профилактика – бұл ісік алды жағдайларды және қатерлі ісіктерді ерте кезеңде анықтауға бағытталған медициналық іс-шаралар. Скринингтік бағдарламалар (рентгенологиялық, эндоскопиялық, УДЗ, зертханалық талдаулар) ісікті уақытында анықтауға мүмкіндік береді.

Әйелдер жылына кемінде бір рет гинекологқа қаралуы тиіс. 45 жастан асқан адамдарға жасырын қанға нәжіс талдауын тапсыру ұсынылады. Отбасында қатерлі ісік жағдайлары болса, тексеру 5 жыл ертерек жүргізілуі тиіс.

Төменде профилактика туралы қазақша мақаланың толық нұсқасы, аймақтық статистика және әдебиеттер тізімі қосылған ғылыми журнал форматы. Сіз қалаған журналдың нақты талаптарына қарай оңдаулар енгізуге болады.

Онкологиялық аурулардың профилактикасы: Қазақстанның тәжірибесі мен жаһандық ұсыныстар

Жыл сайын онкологиялық ауруларға шалдыққан адамдар саны артып келеді. Бұл үрдіс бірқатар факторлармен түсіндіріледі: өмір сүру ұзақтығының ұлғаюы, қоршаған ортаның ластануы, зиянды әдеттер (темекі шегу, алкогольді асыра пайдалану), физикалық белсенділіктің төмен болуы, семіздік, генетикалық бейімділік және тағы басқа себептер. Жоғары өлім-жітім, әсіресе, науқастардың дәрігерге кеш жүгінуінен болады, өйткені бұл кезде обырды емдеу күрделене түседі.

Бастапқы (primary) және екінші (secondary) профилактика онкологиялық аурулардың таралуын төмендетудің маңызды компоненттері болып табылады. Олар обырды ерте кезеңде анықтауға, обыр алдындағы өзгерістерді жоюға, және емнің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

Қазақстан бойынша деректер GLOBOCAN / IARC, ұлттық онкологиялық регистрлер, ғылыми жарияланымдар, HPV вакцинациясы бойынша ведомстволық мәліметтерден алынды.

Статистикалық көрсеткіштер. Жасқа стандартталған сырқаттану (incidence) және өлім-жітім (mortality) көрсеткіштері, сондай-ақ обыр түрлері бойынша жағдайлар

қарастырылды.

Салыстырмалы талдау. Жаһандық ұсыныстар мен Қазақстанның денсаулық сақтау саясаты арасындағы сәйкестіктер мен айырмашылықтар анықталды.

Нәтижелер

Қазақстандағы онкологиялық аурулардың статистикасы

Барлық обыр түрлері бойынша сырқаттану мен өлім-жітім

2023 жылғы мәліметтер бойынша Қазақстанда әлемдік стандартталған (ASR World) обыр сырқаттану көрсеткіші — шамамен 162.3 на 100 000 адамға жылына.

Сол сияқты, өлім-жітім көрсеткіші — шамамен 92.1 на 100 000 адамға жылына.

Ірі обыр түрлері бойынша жағдайлар

Әйелдер арасында ең көп сырқаттану — сүт безі (breast cancer); ерлер арасында — өкпе обыры (lung cancer).

Қыздар арасында жатыр мойны обыры (cervical cancer) — әйелдердегі сырқаттану түрлері арасында екінші орында тұрған түрлердің бірі.

асқазан обырының сырқаттану көрсеткіші дүниежүзілік орташа деңгейге жақын болса да, өлім-жітім көрсеткіші ер адамдар арасында жоғары.

2020–2024 жылдар аралығында колоректалды обырға арналған скрининг бағдарламалары іске қосылып, сырқаттану көрсеткіші сәл өсті, бірақ өлім-жітім төмендеген.

HPV және жатыр мойны обыры

Қазақстанда HPV инфекциясының таралуы 44–56% аралығында деп бағаланады; ең көп кездесетін HPV типтері — 16, 18, 31.

Жатыр мойны обырының сырқаттану көрсеткіші — шамамен 19.3 на 100 000 әйелдер; өлім көрсеткіші де маңызды.

Скрининг бағдарламасы (Pap smear, HPV ДНҚ тесті) елімізде 30–70 жас аралығындағы әйелдер үшін енгізілген, бірақ қамтылу (coverage) шамамен 45–50% деңгейінде.

HPV вакцинациясы

2024 жылы Қазақстан 11 жастағы қыздарды, сондай-ақ 12–13 жастағы қыздарды кешенді (catch-up) вакцинациялау науқанын бастады.

Дүние жүзілік денсаулық сақтау ұйымы

Бұл бағдарлама басталғанға дейін HPV инфекциясының таралуы мен жатыр мойны обырының сырқаттану және өлім көрсеткіштері жоғары болған.

Жаһандық ұсыныстар мен Қазақстандағы сәйкестіктер

Ұсынымдар

Темекі шегуді төмендету WHO, IARC темекіге қарсы саясат, қоғамдық орындарда шектеу, акциздер, білім беру компаниялары. Қазақстанда темекі шегу

көрсеткіштері арасында әйелдер арасында өсім байқалады; тиісті шаралардың күшейтілуі қажет.

Алкогольді тұтынуды шектеу. Әлемдік тәжірибеде алкогольмен байланысты обыр түрлері (өсектеу, өңеш, бауыр) алдын алу саласында ережелер, шектеу саясаты маңызды

Қазақстанда алкоголь тұтыну саласында ақпарат пен бақылау механизмдері әлсіз болуы мүмкін; профилактикалық жұмыс кеңейту керек.

Салауатты тамақтану, физикалық белсенділік Көкөніс, жеміс, талшық, майлы тағамдарды шектеу; салмақ бақылау; физикалық белсенділікті арттыру ұсынылады.

Алматыда және басқа өңірлерде семіздік пен өмір салты факторларын бақылау шаралары енгізілуде, бірақ саналы ауысым үшін білім беру және қолжетімділік мәселелері бар.

Скрининг және ерте анықтау.Жатыр мойны, сүт безі, ішек обыр түрлері бойынша скрининг бағдарламаларын ұйымдастыру; оқыту, тестілеу; скрининг қамтылуын (coverage) жоғары деңгейге жеткізу (70%+). Жатыр мойны обыры бойынша скрининг бағдарламасы бар, бірақ қамтылу шамамен 45–50%. Сүт безі мен ішек обыры бойынша да скринингті кеңейту қажет.

HPV вакцинациясы Жаһандық ұсыныстар — HPV вакцинациясын мектеп бағдарламасына енгізу, қыз балаларды вакцинациялау; бұл жатыр мойны обырының сырқаттануы мен өлімін айтарлықтай төмендетеді. Қазақстан 2024 жылы HPV вакцинациясының ұлттық науқанын бастады; алғашқы қадамдар жасалып жатыр, бірақ белсенді ақпараттық жұмыс пен қамту деңгейін жоғарылату керек.

Денсаулық сақтау ұйымы Ұсынылған шаралар:

-Темекіге қарсы саясатты күшейту

-Темекінің бағасын көтеру, акциздер мен салық саясатын қайта қарастыру.

-Қоғамдық орындарда және жұмыс орындарында темекі шегуге тыйым салуды толық енгізу.

-Темекі шегудің зиянды жақтарын БАҚ пен мектептерде насихаттау.

-Алкоголь мен зиянды тағамдарды бақылау

-Алкогольді сатуды реттеу, оның жарнамасын шектеу.

-Fast food, ысталған, қуырылған тағамдардың құрамын қадағалау, азық сапасына талаптарды күшейту.

Халыққа салауатты тағамды насихаттау — көкөніс, жеміс, дәнді дақылдар, теңіз өнімдері.

-HPV вакцинациясын кеңейту

-11–13 жас аралығындағы қыздар арасында мектепте вакцинацияны жаппай жүргізу.

-Ата-аналар мен жастар арасында вакцинация жөнінде ақпараттық компаниялар

ұйымдастыру.

-Вакцина бағасын төмендету немесе тегін ету арқылы қолжетімділікті арттыру.

-Скрининг бағдарламаларын жақсарту, қамтуды арттыру

-Жатыр мойны обрысы үшін Pap smear немесе HPV тестін тегін және жиі ұйымдастыру.

-Скрининг бағдарламасының қамтылу көздерін көбейту — ауылдық жерлерде, шалғай аймақтарда мобильді скрининг, денсаулық орталықтары арқылы.

-Сүт безі обыры үшін маммография скринингін ұйымдастыру, бастапқы сатыда анықтау; халықты ерте тексерулерге ынталандыру.

-Денсаулық сақтау жүйесін нығайту

-Онкологиялық регистрлердің деректерін уақытылы, дәл, өңірлік аймаққа бөлінген түрде жинауды жетілдіру.

-Медициналық кадрлар дайындығын арттыру; диагностикалық, емдеу құралдарының заманауи нұсқаларын енгізу.

-Өмірлік сапаны жақсартатын паллиативтік және оңалту қызметтерін дамыту.

-Қоғамдық білім беру және психологиялық қолдау

-Халық арасында обыр қаупі туралы білім беру; зиянды әдеттердің әсерін түсіндіру.

-Психогигиена: стресс басқару, психологиялық қолдау жүйесін дамыту.

-Ортақ қауымдастықтарда (мектеп, жұмыс орындары, ауылдық округтер) профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру.

Қорытынды

Қазақстан — онкологиялық аурулар бойынша сырқаттану мен өлім-жітім көрсеткіштері бойынша орташа табысты елдер категориясына жатады. Елде обыр түрлерінің ішінде сүт безі, өкпе, жатыр мойны, асқазан, ішек обырлары басым. Жатыр мойны обыры бойынша скрининг пен HPV вакцинациясының енгізілуі — маңызды қадамдар, бірақ олардың толық әсер етуі үшін қамту деңгейі мен қоғамдық сананың жоғары болуы қажет.

Бастапқы профилактика шараларын жақсартып, зиянды факторларды жою, өмір салтын өзгерту, дұрыс тамақтану, физикалық белсенділік, темекі мен алкогольді азайту арқылы сырқаттану көрсеткішін айтарлықтай төмендетуге болады. Екінші реттік профилактика — скрининг пен ерте анықтау — өлім-жітімді төмендету үшін маңызды құрал.

Ұлттық саясат деңгейінде профилактика шараларына инвестиция салу, медициналық және қоғамдық инфрақұрылымды күшейту, білім беру және ақпараттық жұмыс — барлығы обыр жүктемесін азайтудың басты жолдары.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

Global Cancer Observatory: “Kazakhstan Fact Sheet”. International Agency for Research on Cancer, 2024.
gco.iarc.who.int
Kassymbekova F., et al. “Burden of major cancer types in Almaty, Kazakhstan”, Scientific Reports, 2024. Nature
Zhetpisbayeva I., et al. “Cervical cancer trend in the Republic of Kazakhstan”, Scientific Reports, 2024. Nature
Turmakhanbetov BM., et al. “Incidence of malignant neoplasms and organizational …”, [журнал атауы], 2024.
ScienceDirect
WHO Europe: Kazakhstan launches national HPV vaccination campaign (2024-2025).
Всемирная организация здравоохранения
Igissin N., et al. “Epidemiology of Breast Cancer Mortality in Kazakhstan”, 2023.
PMC
HPV Centre. “Kazakhstan: Human Papillomavirus and Related Diseases Report”, 2023.
hpvcentre.netТақырыптың өзектілігі

Медико-психологическая реабилитация пациентов после мастэктомиии

Окасова Гульнар

Преподаватель специальных дисциплин, Экибастузский медицинский колледж

Введение

Проблема реабилитации больных после мастэктомии является одной из главных в комплексе с другими видами лечения РМЖ. Своевременно проведенная медико - психологическая реабилитация приводит к уменьшению числа осложнений и повышает качество жизни пациентов с РМЖ.

В связи с этим актуальна медико-психологическая реабилитация пациентов после мастэктомии.

Ключевые слова: м*астэктомия, лимфостаз, траскраниальная магнитотерапия, лазерное облучение крови.*

Аннотация

Рак молочной железы — это злокачественная опухоль железистой ткани молочной железы. Причина: возникновения изменения генома клетки, под воздействием внешних причин, и гормонов. Проблема: смертность от рака молочной железы стоит на втором месте. В связи с этим актуальна медико психологическая реабилитация пациентов после мастэктомии.

Структура заболеваемости и смертности





Актуальность: по оценкам экспертов ВОЗ в мире ежегодно регистрируют от 800 тысяч до 1млн новых случаев заболевания РМЖ.

Мастэктомия является ведущим методом лечения РМЖ, и имеет частое осложнения в виде отека конечности, то есть лимфостаза.

Научные исследования подтвердили существование четырех молекулярных подтипов РМЖ.

Цель: изучение клинического течения лимфостаза, у женщин в возрасте от 50 лет до 65 лет после мастэктомии в позднем периоде и эффективности медико-психологической реабилитации.

Задача: выявить у женщин климактерического периода, нарушения гормонального баланса, крово- и лимфообращения и разработка проекта медико психологической реабилитации.

Объектом исследования стали пациенты находящиеся на поликлиническом этапе реабилитации. Предметом исследования явилось выявление изменения на реовазографии сосудов верхней конечности и шеи. И выявление вегетативных расстройств, ограничения движения руки на стороне операции.

Гипотеза исследования: анализ литературных источников.

Анкетирование пациентов, прошедших диагностику методом Люшера, курс транскраниальной магнитотерапии и лазерного облучения крови. Статистическая обработка результатов.

Транскраниальная магнитотерапия, и лазерное облучение крови у пациентов с мастэктомией, по истечению 6 месяцев со дня операции, положительно влияют на кровообращение, лимфодренаж, на уменьшение воспаления, и регенерацию тканей.

Анализируя данные проведенного анкетирования 25 пациентов с мастэктомией в возрасте от 50 до 65 лет, выявлено у 20 женщин дисгормональное и вегетативные расстройство, наличие лимфостаза и ограничение движения в руке.

После проведенного курса лечения магнитотерапии и лазерной терапии крови, соблюдения диеты, наблюдалось уменьшение отека конечности, тревожности и страха, и увеличение подвижности руки.

Выводы

Внедрение по моему проекту данной медико-психологической реабилитации, а именно:

1. Курса лечения транскраниальной магнитотерапии и лазерной облучения крови.

2. Введение должности генетического консультанта.

3. Введение должности молекулярного диетолога, даст пациентам перенесших операций, возможность ранней реабилитации и проведение генетического анализа, для выявления нарушения обмена, с последующим ее устранением.

Список использованных источников:

1. Медицинская Реабилитация - В.М.Боголюбов (2007) г.Москва «Бином» [5, с.130].

2. Физиотерапия и Курортология - В.М.Боголюбов (2021) г. Москва «Бином» [3, с.125].

3. Физическая и реабилитационная медицина - Г.Н. Пономаренко (2016) г.Москва «ГЭОТАР-Медиа» [31, с. 546].

4. Частная Физиотерапия - Г.Н.Пономаренко (2005) г.Москва «Медицина» [10, с.368].

Онкологиядағы профилактиканың заманауи және өзекті мәселелері

Андакулова Куралай, Серкебаева Айгуль, Ахметова Улбосын, Нурбаева Рабига

Арнайы пәндер оқытушылары

Жамбыл жоғары медициналық колледжі

Аннотация

Қазіргі таңда онкологиялық аурулар жүрек – қан тамырлары ауруларынан кейін екінші орын алуда. Қатерлі ісік ешқандай жас мөлшерін таңдамайды, үлкеннің де, жастың да, балалардың да арасында орын алып, көптеген өмірді өлім құшағына алуда. Осыған байлысты әлем дәрігерлері онкологиялық аурулармен яғни қатерлі ісікпен жұмыла бірігіп күресуде.

Маңызды сөздер: о*нкологиялық аурулар, қатерлі ісік, алдын алу, папиллома вирусы, скрининг.*

Тақырыптың өзектілігі

Соңғы жылдары онкологиялық аурулардың алдын алу, келер ұрпағымыздың дені сау болып, денсаулықты сақтаудың маңызды факторы болып отыр. Өйткені, егіде адамнан кішкентай сәбилерге дейін осы қатерлі ісікке шалдығып ауру өзінің артында көптеген қайғы мен қасыретті азайтып тоқсал қою үшін дәрігерлер аурудың алдын алып, оларды ерте диагностикалап, ем-шара жасаумен кеңінен күрес жүргізуде.

Онкологиялық аурулар – ағзадағы жасушалардың бақылаусыз бөлінуі мен қатерлі ісік түзілуінен пайда болатын патология. Қатерлі ісіктердің алдын алу – халық денсаулығын сақтаудағы маңызды бағыттардың бірі.

Әлемнің мыңдаған зерттеушілері обыр ауруының этиологиясын, диагностикалаудың жоғарғы шегін анықтап, ерте емдеу мәселелерін жан жақты зерттеп, қарастырып ерен еңбек етуде.

Халықаралық обырға қарсы одақ бастамасымен жыл сайын 4 ақпанда - Дүниежүзілік обырға қарсы күрес күні аталып өтеді.

2024 жылғы Ұлттық скринингтік бағдарламаның орындалу барысында келесі ақпараттар алынды:

- жатыр мойынының ісікалды ауруы және обырын ерте анықтауға тексерумен 376 552 адам (100,3%) қамтылып; 21 832 науқас (5,8%) анықталып; «Д» есепке 15981адам (92,3%) алынды.

– сүт безінің ісікалды ауруы және обырын ерте анықтауға жоспарланған 389 352 әйел (99,6%) қаралып, тексерілгендердің ішінен 100 689 немесе 25,9% науқас анықталып; диспансерлік есепке 85 891 әйел (85,3%) алынды.

– тоқ және тік ішектің ісікалды аурулары мен обырын ерте анықтауға

796 781 еркек пен әйел (101,4%) тексеріліп; тоқ ішектің обыры мен ісікалды ауруының 1 925 оқиғасы (0,2%) анықталып; анықталған науқастардың ішінен диспансерлік есепке 1 870 немесе 97,1% адам алынды.

Тіркелген онкологиялық аурулардың динамикасын зерттеу кезінде бастапқы диагностиканың жақсаруына байланысты ҚР онкологиялық аурушаңдылық деңгейін анықтау орта есеппен 7-ден 11%-ға дейін артатыны болжануда.

Ғылым мен медицина біріге отырып аянбай халық денсаулығын сақтау үшін жүргізіп жаткан жұмыстары нәтижесінде онкологиялық аурулардың басым бөлігін емдеуге мүмкіндік болып отыр. Қатерлі ісік – онкологиялық аурулардың кең тобының жалпы атауы. Осы еңбек жолында фармация саласы да өз үлестерін қосып, өлім көрсеткіштерін төмендету мақсатыда өз еңбектерін аянбай атқаруда обырға қарсы дәрі - дәрмектердің науқасқа улылығы төмен, қауіпсіз ем, жедел әсерін басты бағытқа алып отыр.

Олар:

1.Темекі шегу мен алкогольды сусындардан бас тарту.

2. Өсімдік негізіндегі және майы аз әртүрлі пайдалы тағамдарды тұтынып, тұзды, ысталған, қуырылған тағамдарды шектеу.

3. Үнемі жаттығулар жасау, артық салмақтан арылу.

4. Ұйқы режимин сақтау.

5. Күн сәулесінің әсерін шектеу.

6. Тұрақты медициналық тексеруден скринингтен уақытылы өту.

Скринингтен өту – белгілі бір жастағы сау адамдарға қауіп факторлары мен ауруларды әсіресе, қатерлі ісікті ерте және ауру сатыларын анықтауға бағытталған медициналық тексеру. Қазақстанда жатыр мойыны обыры, сүт безі обыры, тоқ ішек обыры, асқазан мен өңеш обыры, қуық асты безі обыры, бауыр обырына скрининг жүргізіледі.

Барлық уақытта есте сақтау керек – қатерлі ісік – өлім үкімі емес! Ерте кезеңдерде анықталған қатерлі ісік емделетін ауру болып табылады. Қазіргі уақытта қатерлі ісіктің алдын алудың, диагностикалаудың және емдеудің заманауи әдістері бар, олар әсіресе аурудың бастапқы кезеңінде жақсы нәтижелерге қол жеткізе алады.

Медициналық көмекті тиімдірек көрсету және аурулардың дамуын болдырмау үшін алдын алу шараларының үш негізгі кезеңі анықталды.

Бастапқы профилактика салауатты өмір салтын сақтауды және жаман әдеттерді жоюды қамтиды.

Біріншілік профилактика - аурудың пайда болу қаупін төмендетуге бағытталған шаралар:

- Салауатты өмір салтын сақтау: дұрыс тамақтану, темекі шегуден бас тарту, алкоголь тұтынуды азайту, дене белсенділігін арттыру.
- Қоршаған орта факторларын азайту: қауіпті химиялық заттармен жұмыста қорғаныш құралдарын пайдалану, радиация әсерін төмендету, күн сәулесінен қорғану (меланоманы алдын алу).
- Инфекцияға қарсы шаралар: В гепатитіне қарсы (бауыр обырының алдын алу) және адам папиллома вирусына (HPV) қарсы (жатыр мойны обырының алдын алу) вакцинациялар.

Екінші профилактика - белгілі бір ісіктің даму қаупі бар адамдарды бақылауды, сондай - ақ ісік алды жағдайларды және қатерлі ісіктің ерте формаларын емдеуді және уақытылы диагностикалауды қамтиды.

Ауруды ерте кезеңде анықтау арқылы тиімді емдеуді қамтамасыз ету:

- Скринингтік бағдарламалар
- Әйелдерге: маммография, Пап-тест, HPV-тест.
- Ерлерге: PSA (простата обырына).

• Барлық халыққа: колоноскопия (ішек обырына), төмен дозалы КТ (өкпе обырына, темекі тартушыларға), диспансерлік бақылау, қауіп тобына кіретін адамдарды (тұқым қуалаушылық, кәсіби зиянды факторлар, бұрынғы аурулар) жүйелі тексеру.

Үшінші профилактика - қатерлі ісіктерді емдеуден өткен науқастарға қатысты, ол ісіктердің қайталануы мен метастаздарының алдын алудан, сондай-ақ емделген науқастарда ісіктердің басқа түрлерінің пайда болмауын қадағалауын қамтиды.

Қатерлі ісікпен ауырған адамдардың өмір сапасын жақсарту, асқынуларды болдырмау: қайталама ісік дамуын алдын алу үшін тұрақты бақылау, хирургиялық, химиотерапиялық, сәулелік емнен кейін оңалту шаралары, психологиялық көмек, әлеуметтік қолдау, паллиативтік көмек (ауырсынуды басу, өмір сапасын арттыру).

Дәл қазіргі деректерге сәйкес ракты тұқым қуалаушы ауру деп те санайды, клеткадағы тектік қасиеттің бұзылуынан болады. Бұлардың бәрі молекулалық деңгейде жүреді. Осыған байланысты тұқым қуалайтын қатер болса (мысалы ата-анасында онкология болған жағдайда), жоспарлы тексерулер жүргізу.

Соңғы кезде обыр ауруы жасөспірімдер арасында кең орын алуда.

Еліміздің болашағы жасөспірімдермен жастардын өмірін сақтау, қазіргі уақытта үлкен бағытта болуда. Осы күрес жолында:

1. Жасөспірімдер мен ата-аналарына онкологиялық аурулар туралы қарапайым түсінікті тілде ақпарат беру.

2. Әлеуметтік желілер мен мектеп бағдарламасы арқылы насихаттау жұмысын жүргізу.

3. Иммунизация (HPV адам папиллома вирусы) яғни вакцинация жүргізу жасөспірім қыздар арасында жатыр мойыны обырының алдын алуда үлкен оң көрсеткіш көрсетуде.

4. Жасөспірімдерге психологиялық қолдау көрсету, жасөспірімдердің стресске төзімділігін арттыру.

5. Эмоционалды және әлеуметтік қолдау, әсіресе созылмалы ауруы бар балаларға жәрдем беру.

6. Дене өзгерістеріне назар аударып уақытылы дәрігерге қаралу. Мысалы лимфа түйіндерінің ұлғаюы т.б.

Заманауи әдістер мен жетістіктер

Генетикалық скрининг – тұқым қуалаушылыққа бейімділікті анықтау, иммунопрофилактика – обырға қарсы жаңа вакциналар әзірлеу, жасанды интеллект көмегімен диагностика, өмір салтын бақылау үшін мобильді қосымшалар (қадам санауыш, диета бақылау).

Өз- өзіңді қатерлі ісіктен осы іс-шараларды орындап, қорғай біліңіз!

1. Аптасына кемінде 3 рет дене шынықтыру және спортпен шұғылданыңыз.

2. Күнделікті рациондағы ет пен қантты азайтыңыз.

3. Көкөністер мен жемістерді көбірек тұтыныңыз.

4. Теріні тікелей күн сәулесінен қорғаңыз.

5. Жаман әдеттерден арылыңыз (темекі шегу, алкогольді ішу)

6. Жыл сайын өкпе флюорографиясынан өтіңіз.

Қорытынды

Баяндаманы қорытындылай келе, жүргізіліп жатқан ерен еңбек арқасында дүниежүзіне қайғы қасірет әкеліп отырған ауруды алдын алу шараларын қалтықсыз сақтап, орындап отырса, уақытылы дәрігерге көрініп, ерте диагностикалап ауруды жеңуге болады.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. «Асыл Ана» жобасы — Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты сүт безі қатерлі ісігі туралы қазақ тілінде ақпарат беретін сайт.

2. Қатерлі ісіктің алдын алу жолдары. Н. Үсенова.

3. «Онкологиялық аурулармен күрес: Қазақстандағы ахуал және әлемдік тәжірибе» — El.kz сайты.

4. Сүт безі қатерлі ісігінің қауіпті факторлары. Шертаева А.Б., Оспанова Д.А., Гржибовский

Адам папилломавирусы (АПВ)

Аймурзиева Манчук[1], Кусанова Айгерим[2], Алмаханбетова Зарина[2]
[1]Басқарма төрағасының оқу-тәжірибе жұмысы жөніндегі орынбасары,
[2]арнайы пән оқытушылары.
Батыс Қазақстан Жоғары Медициналық колледжі

Өзектілігі

«Вакцинация – ата-аналар үшін балаларын жұқпалы аурулардың ауыр зардаптарынан қорғаудың жалғыз, ең тиімді әдісі. Вакциналарды ойлап шығару – медицинаның ең үлкен жетістігі деп білеміз. 21-ғасырда кейбір ата-аналар балаларын вакцинациялаудың тиімділігі мен қажеттілігіне қатысты әлі де күмәнданып келеді. «Иммундау-өмірді ғана құтқарып қоймай, сондай-ақ балаларға, әйелдерге және отбасыларға өркендеуге мүмкіндік беріп келеді. Соның бірі-Адам папилломавирусы.

Зерттеу барысы

БҚО бойынша 2022-2024 жж. Аралықтарындағы «әйел жатыр мойны обырына» қарсы жүргізілген шаралардың көрсеткіші мен нәтижесі.

Папилломавирусты инфекция – еркектер мен әйелдердің 70%-да кездесетін инфекция. Бұл инфекция 18-30 жастағылар арасында жиірек байқалады. Кесел көбінесе симптомсыз түрде өтеді. Папилломавирустар әйелдердің қынабында, жатырында, уретрада, гениталдық сүйелдер дамуын қоздырып, еркектерде – жыныс мүшесінің айналасы мен ұмасын зақымдайды.

Негізгі онкогенді қаупті HPV штаммдары:

- Жоғары онкогенді қауіпті штаммдары (16, 18, 31, 33 және т.б.);
- Төмен онкогенді қауіпті штаммдары (6, 11, 32, 40-44, 72).

Вирустардың төмен онкогенді штамдары сүйелдер, тері папилломаларын, жоғары онкогенді түрлері аногенитальды аймақта, әйелдерде жатыр мойнында, ерлерде жыныс мүшелерінде кондиломаларды тудырады. Ағзаға вирустың 16, 18, 31, 33 типті штамдары ұзақ уақыт әсер еткен жағдайда жатыр мойны дисплазиясын, кейін жатыр мойны обырының ауыр ағымына алып келеді.

Диаграмма-1

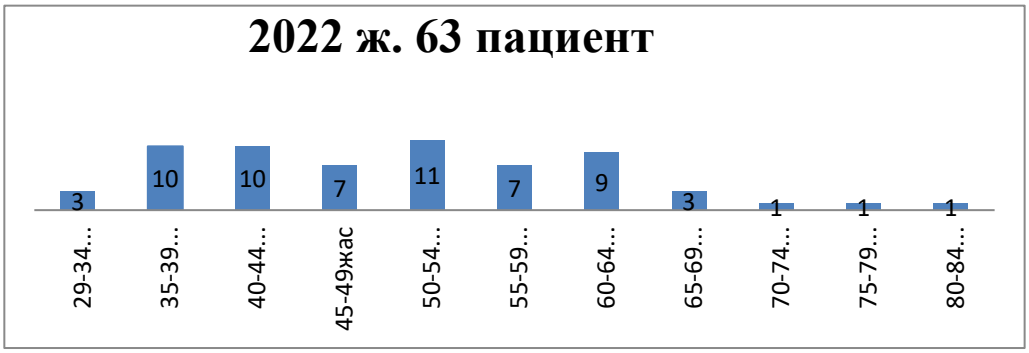


Диаграмма-2

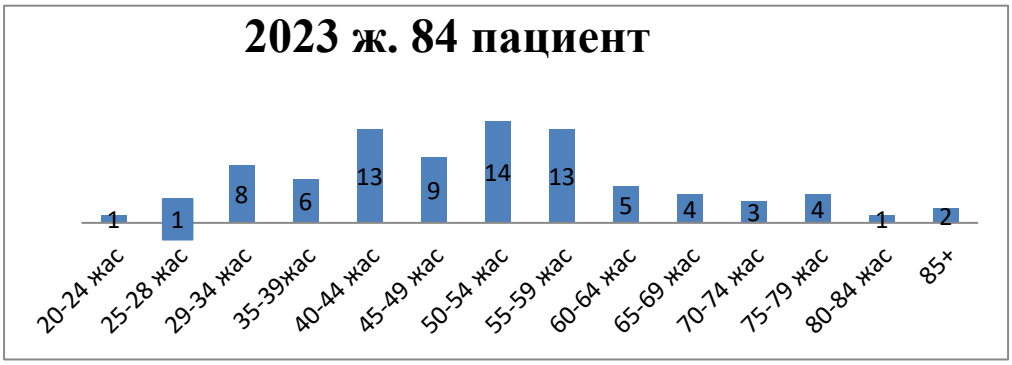
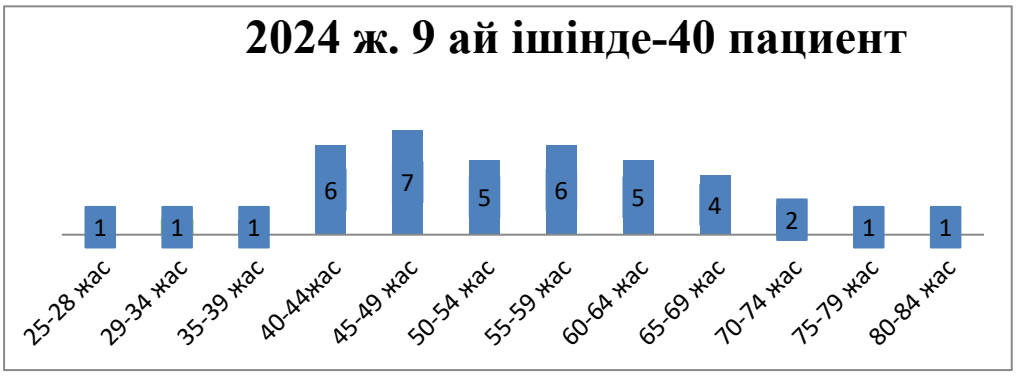


Диаграмма-3



БҚО 2022-2024 жж. аралықтарындағы жатыр мойны обырының сандық көрсеткіштері (Диаграмма 1-3)

Жұғу жолдары:

-Негізгі жұғу жолдары – жыныстық қатынас арқылы;

-Вертикалды жұғу жолы – Адам папиллома вирусы жұқтырған немесе тасымалдаушы әйелдің босану кезінде босану жолы арқылы туылған нәрестеге жұғуы;

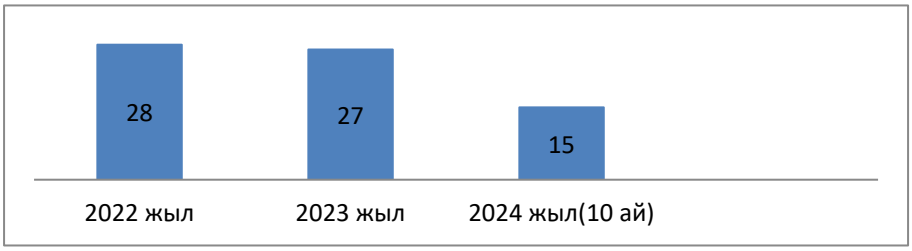
-Аутоинокуляция – эпиляция немесе қырыну кезінде;

-Тұрмыстық заттармен байланыс – Адам папиллома вирусы қоршаған ортада біраз уақыт өмір сүретіндіктен, қоғамдық ортада (монша, спорт залы, бассейн, т.б.);

-Байланыс – инфекция терідегі немесе кілегей қабаттардағы жарақат беті арқылы жұғуы (жаралар, көгерулер);

Әр екі күн сайын 1 әйел жатыр мойны обырынан қайтыс болады. Ауырсыну белгілері еленбейтін бұл дерт жылына 600 қыз-келіншектің өмірін қияды. Науқастардың 15% ауруы асқынғанда ғана дәрігерлерге жүгінеді екен.

Диаграмма-4



БҚО 2022-2024 жж. аралықтарындағы жатыр мойны обырынан қайтыс

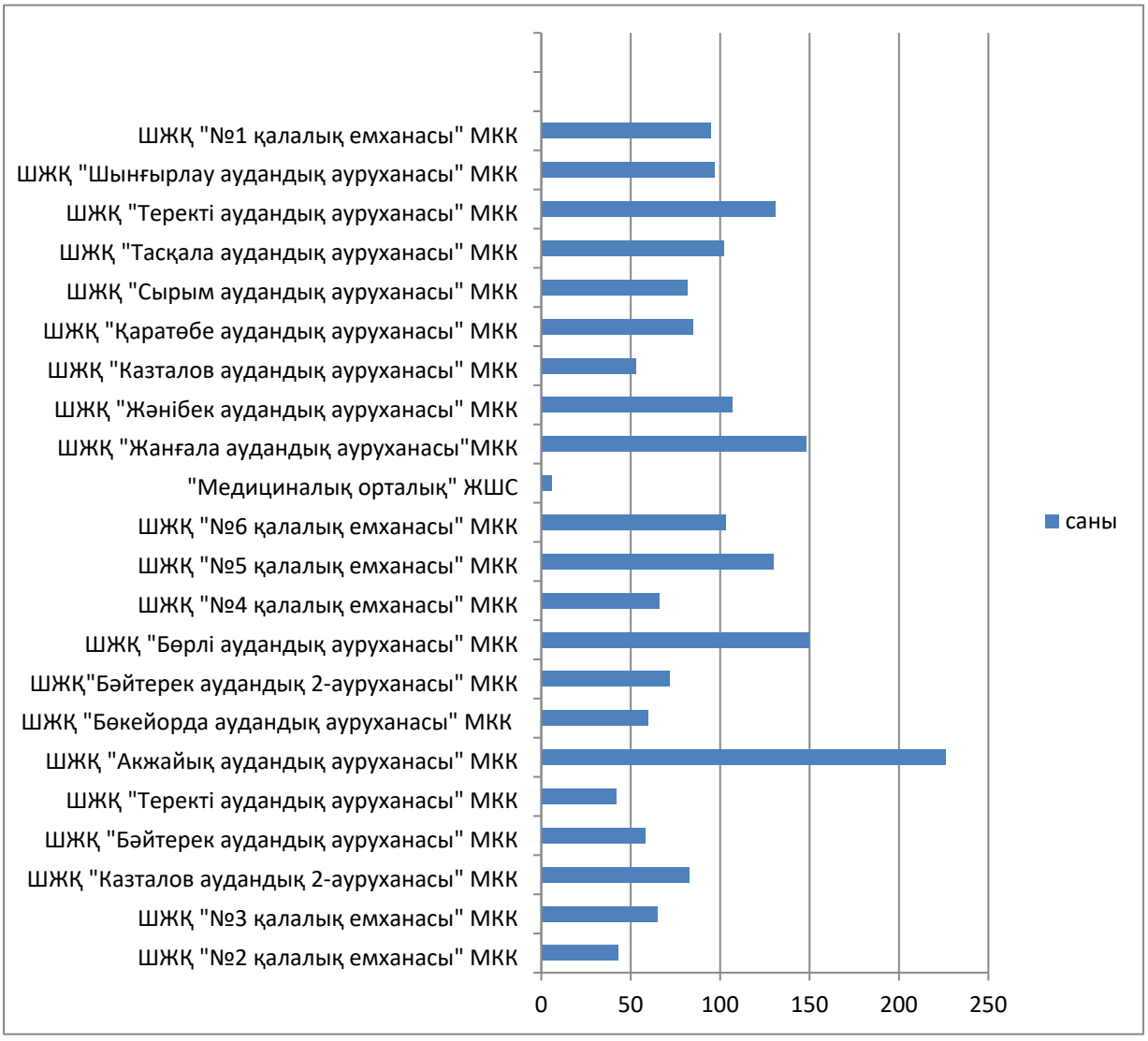
болғандардың сандық көрсеткіштері (Диаграмма 4)

2023 ж. Батыс Қазақстан облысында онкологиялық аурулардың таралу дәрежесі бойынша «жатыр мойны обыры» бесінші орында, бірінші орында - сүт безі обыры, екінші-өкпе обыры, үшінші – асқазан обыры, төртінші – тік ішек обыры алып отыр.

БҚО 2024жылдың қазан айына дейінгі әйелдердегі «жатыр мойын обырының» көрсеткіші-684.

Адам папилломавирусына қарсы екпе - жатыр мойны обырының алдын алуына, жатыр обырының пайда болуын төмендетуіне зор мүмкіндік береді. 2006 жылдан бері әлем бойынша Адам папилломавирусына қарсы екпені 100 млн аса адам алған, 270 млн доза вакцина қолданылған. Орталық Азия елдері бойынша адам папилломавирусына қарсы екпе Армения, Грузия, Молдава, Түркіменстан, Қырғыстан, Өзбекстан елдерінде күнтізбеге енгізіліп, қолданылауда. Әлемнің 135 елі адам папилломавирусы қарсы екпені күнтізбеге енгізген.

Диаграмма-5



БҚО бойынша қазіргі таңда адам папиллома вирусына қарсы екпе алғандардың

сандық көрсеткіштері– 2004 адам. (Диаграмма-4)

Адам папилломавирусына қарсы вакцина дәрігермен кеңескеннен кейін ата-аналарының жазбаша келісімімен мектептердің медициналық пункттерінде 11 жастан асқан қыздарға егіледі. Қыздардың ата-аналары вакцинация процедурасы кезінде медициналық кабинетте бірге бола алады.

Алдын алу шаралары:

-Жыныстық қатынаста тек бір жыныстық серіктес болғаны дұрыс. Бұл әдіс жыныстық жолмен берілетін барлық инфекциялардан, оның ішінде адам папиллома вирусынан қорғауға мүмкіндік береді.

-Тосқауыл контрацепциясын қолдану – жеңіл, қолжетімді, бірақ инфекциядан 100% қорғай бермейді. Науқас тіпті зақымдалған теріге тиген кезде де вирус жұқтыруы мүмкін.

-Мерзімді профилактикалық тексерулер. Әйелдерді гинекологиялық тексеруден тұрақты түрде өтуі керек. Лабораторлы тексерулер адам папиломавируснының ДНҚ-сын ПЦР әдісімен билогиялық жұғынды, яғни цервикальды аймақтан жұғынды, гисто-цитологиялық тексерулер жүргізе отырып, аурудың алғашқы белгілерін анықтап, оны емдеуді уақтылы бастауға болады.

Қорытынды

Бұл мақала негізінде ресми мәліметтеріне талдау жасай отырып, Батыс Қазақстан облысы бойынша «әйел жатыр мойны обырынан» алдын алу жолдарына бағыттадық. Ғалымдардың зерттеулері бойынша адам папилломавирусын жұқтырудың жоғарғы шегі көбіне 16-20 жас аралығында екен. Вакцинаны жасөспірім қыздарға қолданудың өзіндік себебі бар. Егер екпе алғашқы жыныстық қатынасқа дейін жасалса, қатерлі ісікті болдырмауға кепілдік береді. Ал жыныстық қатынастан кейін салынса, әсері алғашқыдай болмауы мүмкін. Сондықтан жастардың жыныстық қатынасқа ерте түсуіне байланысты екпе егу 11-13 жастағы қыздардан бастап жатыр. Қазіргі таңда қатерлі ісік аурулары күрт көбейіп қана қоймай, жасарып келеді. Ертеректе 40-50 жастағы әйелдерде кездессе, қазір 22-25 жастағы қыз-келіншектерде де байқалып келеді.

Адам папилломавирусына қарсы вакцинация "Медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде профилактикалық егуге жататын халық топтары, оларды жүргізу қағидалары, мерзімдері және міндетті профилактикалық егулер жүргізілетін аурулардың тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 24 қыркүйектегі № 612 қаулысымен бекіткен. Вакцинация жасау тегін, әрі келісімінен кейін ғана жүргізіледі. Қазақстан Республикасында 351 мың доза сатып алу үшін 9,7 млрд теңге бөлінді. Аталған вакцинация республикалық бюджеттен бөлінеді. БҚО бойынша қажеттілік есебі 11 мын дозаға 308 млнды құраған. Адам папилломавирусына қарсы

вакциналар фертильдікке әсер етпейді. Керісінше, олар әйелдің денсаулығы мен фертильдігін қорғауға көмектесетіні айқын. 2006 жылы Адам папилломавирусына қарсы алғашқы вакцина тіркелгенге дейін жүргізілген клиникалық сынақтар, сондай-ақ қауіпсіздік мониторингі және оны енгізгеннен кейінгі зерттеулер вакцинаның әйелдерде ұрпақты болу проблемаларын тудырмайтынын растаған болатын. Шын мәнінде, Адам папилломавирусына қарсы вакцина жатыр мойнының қатерлі ісікке дейінгі өзгерістерін жоюға көмектеседі.

Жатыр мойны обырын емдеу (жатыр мойны мен жатырды толығымен алып тастау, химиялық-терапия және/немесе сәулелік терапия) әйелдің бала туу мүмкіндігін жоғалтуына әкеледі. Дер кезінде осы вакцинаны алатын болса, елімізде жатыр мойнының қатерлі ісікке дейінгі зақымдануын хирургиялық емдеу әйелдің жүктілігін қиындатпауы мүмкін, кейін жүктілік кезінде консервативті емдеу немесе хирургиялық араласу мерзімінен бұрын босануға және ұрықтан айырылу қаупін азайтатыны белгілі.

«Дені сау ұрпақ -дені сау анадан туады»

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. www.unicef.org
2. https://www.uralskweek.kz/kz/2024
3. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
4. 2023 жылда Қазақстан Республикасының Денсаулығы және денсаулық сақтау ұйымдарының қызметі (статистика)
5. https://ru.wikipedia.org
6. https://ile-tany.kz/2024/
7. Грецева О.П., Костин А.А. «Адам папилломавирусымен байланысты қатерлі ісіктерден туындаған ауру және өлім» 2019; 4 (3)

Онкологиялық аурулардың алдын алу бойынша колледж базасындағы ағарту жұмыстары

Жармаганбетова Галия, Оразбекова Салтанат

Арнайы пәндер оқытушылары, Қызылорда медициналық жоғары колледжі

Аннотация

Мақалада колледж базасында онкологиялық аурулардың алдын алу мақсатында жүргізілетін ағарту жұмыстары қарастырылған. Студенттердің денсаулық мәдениетін қалыптастыру, зиянды әдеттерден сақтандыру және онкологиялық аурулар

туралы білімдерін арттыру әдістері талданады. Сонымен қатар, алдын алу шараларының тиімділігін арттыру жолдары ұсынылады.

Тірек сөздер: *онкологиялық аурулар, алдын алу, ағарту жұмыстары, денсаулық, студенттер.*

В статье рассматриваются просветительские мероприятия, проводимые на базе колледжа с целью профилактики онкологических заболеваний. Анализируются методы формирования у студентов культуры здоровья, предупреждения вредных привычек и повышения их знаний об онкологических заболеваниях. Кроме того, предлагаются пути повышения эффективности профилактических мероприятий.

Ключевые слова: *онкологические заболевания, профилактика, просветительская работа, здоровье, студенты.*

The article examines educational activities conducted at the college level aimed at preventing oncological diseases. Methods for developing students' health culture, preventing harmful habits, and increasing their knowledge about oncological diseases are analyzed. In addition, ways to enhance the effectiveness of preventive measures are proposed.

Keywords*: Oncological diseases, prevention, educational activities, health, students.*

Зерттеу жұмысының өзектілігі

Онкологиялық аурулар – қазіргі замандағы ең өзекті медициналық және әлеуметтік мәселелердің бірі. Қазақстанда қатерлі ісік аурулары өлім-жітім себептерінің арасында жүрек-қан тамыр ауруларынан кейінгі екінші орында тұр. Жастардың онкологиялық сауаттылығы төмен деңгейде болғандықтан, қауіпті әдеттерге бейімділік жиі кездеседі. Сондықтан колледж базасында онкологиялық аурулардың алдын алу мақсатында жүйелі ағарту жұмыстарын жүргізу – уақыт талабына сай өзекті мәселе.

Зерттеудің мақсаты

Колледж студенттері арасында онкологиялық аурулардың алдын алу бойынша ағарту жұмыстарының қажеттілігін ғылыми тұрғыда негіздеу және олардың тиімділігін арттыру жолдарын көрсету.

Зерттеудің міндеттері:

1. Онкологиялық аурулардың алдын алу мәселелерін ғылыми-теориялық тұрғыда талдау;
2. Колледж деңгейінде ағарту жұмыстарының негізгі бағыттарын айқындау;
3. Салауатты өмір салтын насихаттаудың тиімді әдістерін анықтау;
4. Жастардың онкологиялық сауаттылығын арттыруға бағытталған шаралардың нәтижелілігін бағалау.

Зерттеудің теориялық маңыздылығы

Мақалада онкологиялық аурулардың алдын алу ұғымы, оның ғылыми негіздері және ағарту жұмыстарының қоғамдағы орны қарастырылған. Зерттеу нәтижелері жастардың онкологиялық сауаттылығын арттыруға бағытталған білім беру жүйесіндегі жаңа ғылыми тұжырымдар жасауға ықпал етеді.

Зерттеудің практикалық маңыздылығы

Жүргізілген зерттеу колледж базасында ағарту іс-шараларын ұйымдастыруда нақты әдістемелік ұсыныстар береді. Мұғалімдер, психологтар және медицина қызметкерлері осы материалдарды студенттер арасында профилактикалық жұмыстар жүргізуде тәжірибеде қолдана алады.

Қазіргі таңда онкологиялық аурулар әлемдік деңгейде ең өзекті медициналық-әлеуметтік мәселелердің біріне айналды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректері бойынша жыл сайын миллиондаған адамдар қатерлі ісіктен көз жұмады. Ал елімізде онкологиялық аурулар барлық аурулардың құрылымында 7-орында, ал өлім-жітім көрсеткіші бойынша қан айналым жүйесі ауруларынан кейін 2-орында тұр. Қазіргі таңда Қазақстанда онкологиялық аурулар бойынша 205 мыңнан астам пациент динамикалық бақылауда. Жыл сайын 37 мыңнан астам жаңа жағдай тіркеледі. Әйелдердің арасында аурушаңдық ерлерге қарағанда сәл жоғары болып, 57%-ды құрайды. Еңбекке қабілетті адамдардың сырқаттануы 56%-ды құрап отыр [3]. Медицина тілінде онкология грек тілінен аударғанда «қатерлі ісік және ілім» дегенді білдіреді. Обыр жасушалары тез көбейіп, белгілі бір уақытта қан және лимфа тамырлары арқылы ағзаның басқа мүшелеріне таралып немесе метастаз жасайды [4]. Бұл жағдай денсаулық сақтау саласы мамандарын ғана емес, бүкіл қоғамды алаңдатады. Қатерлі ісікпен күресте ең басты қадам – аурудың алдын алу, яғни халық арасында ағарту жұмыстарын жүргізу, сауатты түсіндіру, салауатты өмір салтын насихаттау.

Онкологиялық аурулардың алдын алу қазіргі заманғы қоғамдық денсаулық сақтаудың стратегиялық бағыты болып табылады. Қатерлі ісік аурулары тек медициналық тұрғыдан ғана емес, сонымен бірге әлеуметтік, психологиялық және мәдени қырларымен де ерекшеленетін кешенді мәселе болып саналады. Оның алдын алу шараларын дұрыс ұйымдастыру қоғамның жалпы денсаулығын нығайтуға, медициналық шығындарды азайтуға және халықтың өмір сүру ұзақтығын арттыруға ықпал етеді. Біріншіден, аурудың ерте анықталуының маңызы ерекше. Көптеген онкологиялық аурулар алғашқы кезеңдерінде анықталған жағдайда тиімді емделеді. Скринингтік тексерулер мен профилактикалық медициналық бақылауларды уақытылы жүргізу адам өмірін сақтап қалуға мүмкіндік береді. Сондықтан жастардың ерте диагностикаға мән беруі олардың

болашақ денсаулығы үшін маңызды қадам болып табылады. Екіншіден, салауатты өмір салтын қалыптастыру онкологиялық аурулардың алдын алуда шешуші рөл атқарады. Дұрыс тамақтану, темекі мен алкогольден бас тарту, тұрақты физикалық белсенділік – қатерлі ісік қаупін айтарлықтай төмендететін негізгі факторлар. Бұл тұрғыда білім беру мекемелерінде жастарды спорттық іс-шараларға тарту, дене шынықтыруды күнделікті әдетке айналдыру және зиянды әдеттердің зиянын түсіндіру аса маңызды. Үшіншіден, ақпараттық сауаттылық деңгейін көтеру де алдын алу шараларының құрамдас бөлігі болып табылады. Жастардың онкологиялық аурулардың себептері, белгілері мен алдын алу жолдары туралы білімін арттыру оларды қауіпті жағдайлардан сақтануға жетелейді. Мысалы, ультракүлгін сәулелердің зияны, артық салмақтың қауіптілігі немесе химиялық қоспаларға бай тағамдарды шамадан тыс пайдалану жайлы ақпараттың жеткілікті болуы дұрыс өмірлік таңдау жасауға мүмкіндік береді. Төртіншіден, жастардың денсаулығын сақтау – қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуы үшін маңызды фактор. Жас ұрпақтың денсаулығы олардың болашақтағы еңбекке қабілеттілігін, кәсіби жетістіктерін және өмір сапасын анықтайды. Денсаулығы мықты жастар – мемлекет үшін экономикалық әрі демографиялық тұрақтылықтың кепілі [4, 57]. Сонымен қатар онкологиялық аурулардың алдын алу психологиялық тұрғыдан да ерекше мәнге ие. Ауруға деген қорқыныш, үрей мен уайым адамдардың өмір сүру сапасына кері әсер етеді. Ал алдын алу шаралары бұл үрейді азайтып, сенімділік пен жауапкершілік сезімін қалыптастырады. Мәдени тұрғыдан алғанда да салауатты өмір салтын ұстану – қоғамның құндылықтар жүйесін нығайтып, денсаулықты бірінші орынға қоятын жаңа дәстүр қалыптастырады.

Колледж базасындағы ағарту жұмыстарының бағыттары

Колледж студенттерімен онкологиялық аурулардың алдын алу бойынша ағарту жұмыстары жүйелі әрі кешенді түрде ұйымдастырылуы қажет. Мұндай іс-шаралар тек ақпарат берумен шектелмей, студенттердің өмір салтын өзгертуге, денсаулыққа деген жауапкершілік сезімін арттыруға және салауатты әдеттерді қалыптастыруға бағытталуы тиіс. Ағарту жұмыстарының негізгі бағыттарын төмендегідей топтастыруға болады:

1. Дәрістер мен семинарлар. Колледжде онкологиялық аурулар жөнінде ғылыми негізделген білім беру – ағарту жұмыстарының басты бағыттарының бірі. Ол үшін тәжірибелі медициналық мамандарды, дәрігер-онкологтарды, валеологтарды шақырып, студенттерге қатерлі ісік ауруларының себептері, белгілері, даму кезеңдері мен ерте диагностиканың рөлі туралы дәрістер оқу маңызды. Сонымен қатар студенттердің өздігінен ізденуін дамыту мақсатында семинарлар мен пікірталастар ұйымдастыру қажет. Бұл іс-шараларда студенттер ғылыми деректерге сүйеніп баяндамалар жасайды, өз көзқарасын білдіреді және денсаулықты сақтау жолдары жөнінде тәжірибе алмасады.

2. Ақпараттық-бұқаралық кампаниялар. Ақпараттық-ағартушылық жұмыстың тиімділігі студенттердің күнделікті ортасында дұрыс ақпараттың үнемі көрініп тұруына байланысты. Осы мақсатта қатерлі ісік ауруларының алдын алу жолдары туралы плакаттар, буклеттер, ақпараттық жаднамалар шығару, колледж ішінде арнайы стендтер орнату қажет. Бұған қоса, жастардың көп қолданатын әлеуметтік желілерінде студенттік парақшалар ашып, сол арқылы пайдалы мәліметтер мен бейнероликтер тарату ағарту жұмысының ауқымын кеңейтеді. Бұл бағыт студенттердің ақпаратты тек тыңдаушы емес, таратушы рөлін де атқаруына мүмкіндік береді.

3. Салауатты өмір салтын насихаттау. Онкологиялық аурулардың басты алдын алу жолдарының бірі – зиянды әдеттерден бас тартып, дені сау өмір салтын қалыптастыру. Осыған байланысты студенттерге темекі мен алкогольдің адам ағзасына тигізер зиянын ғылыми деректермен түсіндіру маңызды. Мысалы, темекі шегу – екінші қатерлі ісіктің негізгі себептерінің бірі болып саналады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректеріне сәйкес, әрбір бесінші қатерлі ісік елімізде темекіге байланысты пайда болады. Дұрыс тамақтанбау – фаст-фуд, өңделген өнімдер және канцерогенді тағамдар (мысалы, қызыл және өңделген ет) асқазан мен тоқ ішек қатерлі ісігінің дамуына әсер етеді [1, 61]. Дұрыс тамақтану мәдениетін қалыптастыру үшін арнайы тренингтер, тамақтану кестелері, пайдалы тағам үлгілері ұсынылуы тиіс. Сонымен қатар спорттық жарыстар, дене шынықтыру сабақтарынан тыс белсенді жаттығулар ұйымдастыру студенттердің физикалық жағдайын жақсартып қана қоймай, ұжымдық ынтымақты да арттырады.

4. Психологиялық қолдау. Арнайы мамандардың қатысуымен студенттерге арналған жеке және топтық консультациялар, өмірлік құндылықтарды дәріптейтін мотивациялық тренингтер өткізу олардың өзін-өзі дамытуына, сенімділігін арттыруға ықпал етеді. Психологиялық қолдау студенттердің күйзеліске қарсы тұру қабілетін күшейтіп, салауатты әдеттерді қабылдауын жеңілдетеді.

5. Медициналық тексерулер. Колледж студенттері үшін жоспарлы медициналық тексерулерді жүйелі түрде ұйымдастыру – ауруды ерте анықтаудың тиімді жолы. Скринингтік бағдарламаларға қатысу, профилактикалық шараларға көңіл бөлу жастардың денсаулығын бақылауға мүмкіндік береді. Сонымен бірге студенттерге өз ағзасын жүйелі тексерудің маңызы түсіндіріліп, медициналық мәдениет қалыптастыруға ерекше мән берілуі тиіс. Осы бағыттардың барлығы өзара тығыз байланыста жүргізілгенде ғана колледж студенттері арасында онкологиялық аурулардың алдын алуға бағытталған ағарту жұмыстары шынайы нәтиже береді.

Қорытындылай келе, жүргізілген зерттеу көрсеткендей, колледж базасында онкологиялық аурулардың алдын алу бойынша ағарту жұмыстары студенттердің

денсаулығына жауапкершілік сезімін қалыптастыруда, салауатты өмір салтын насихаттауда және медициналық сауаттылығын арттыруда маңызды рөл атқарады. Колледжде жүйелі түрде ұйымдастырылған ағарту шаралары студенттердің онкологиялық аурулар жайлы білімін кеңейтеді, зиянды әдеттерден бас тартуға ынталандырады, өз денсаулығына жауапкершілікпен қарауын қалыптастырады және қоршаған ортасына денсаулық мәдениетін таратуға ықпал етеді.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Онкология и радиология Казахстана. №2 (44) 2017;

2. Халықаралық онкологиялық ұйым (WHO). (2023). Cancer Prevention Guidelines. Geneva: WHO;

3. https://primeminister.kz/news/azastanda-soy-20-zhylda-onkologiyaly-aurulardan-bolatyn-lim-zhitim-33-a-tmendedi-23189

4. In The World of Science and Education. 2025. https://cyberleninka.ru/article/n/onkologiyaly-aurulardy-aldyn-aluda-skriningti-ma-yzy/viewer

Химиотерапиядан кейінгі кезеңдегі пациенттердің күтімі мен тамақтануында мейіргердің білім деңгейі

Аманова Динара, Прманова Шакизада

Арнайы пәндер оқытушылары, Қызылорда медициналық жоғары колледжі

Кілт сөздер: *онкология ауру, химиотерапия әсері, мейіргерлік күтім, химиотерапиядан кейінгі пациентті тамақтандыру, стресс, алдын алу,шетелдік тәжірибелер.*

Аннотация

Химиотерапия қатерлі ісік асқынуының алдын алу және күресте тиімді пайдалануға, сондай-ақ онкологиялық ауруларды емдеуде қажетті нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Жоғары білікті мамандардың бірлескен күш – жігерімен, пациенттің ауыр сырқатын жеңуде сенімділігімен, туған-туысқандары мен жақындарының махаббаты мен қамқорлығымен-ауруды жеңуге қол жеткізіледі.

Химиотерапия позволяет эффективно использовать ее в профилактике и борьбе с онкологическими осложнениями, а также добиться желаемых результатов в лечении онкологических заболеваний. Совместными усилиями высококвалифицированных

специалистов достигается уверенность в преодолении тяжелой болезни пациента, любовь и забота родных и близких-преодоление болезни.

Chemotherapy makes it possible to effectively use it in the prevention and control of oncological complications, as well as to achieve the desired results in the treatment of oncological diseases. Through the joint efforts of highly qualified specialists, confidence is achieved in overcoming the patient's serious illness, and the love and care of relatives and friends helps to overcome the disease.

Тақырыптың өзектілігі

Дүние жүзіндегі онкологиялық аурулар жүрек – қан тамырлары патологиясынан кейінгі өлім – жітім бойынша екінші орында. Қатерлі ісік әлемдегі негізгі инфекциялық емес аурулардың біріне айналды. 2030 жылға дейін бүкіл әлемде жылына 26 миллион жаңа қатерлі ісік ауруы және 17 миллион қатерлі ісік ауруынан қайтыс болады деген болжам бар. Дегенмен, тиімді алдын алу және скринингтік қызметтердегі, сондай ақ негізгі дәрі - дәрмектер мен медициналық құрылғыларға қол жеткізудегі және қатерлі ісікпен тиімді күресу үшін қажетті мамандандырылған жұмыс күшіндегі айырмашылықтар ашық тіпті АҚШ сияқты табысы жоғары елдерде де. Қатерлі ісік ауыртпалығы 2018 жылы 18,1миллионнан 2040 жылы 29,4 миллионға артады деп күтілуде. Табысы төмен және орташа елдердегі қатерлі ісік ауруларының кем дегенде 30 %–ы адам папилломавирусы және гепатит сияқты инфекциялардан туындайды, ал темекіні пайдалану қатерлі ісіктен болатын өлімнің себебі 25% құрайды және олардың барлығы келесі жаһандық дағдарыс ретінде анықтайтын факторлар.

Статистикалық мәліметтер:

Қатерлі ісік Америка Құрама Штаттарында қоғамға қатты әсер етеді. 2022 жылы Қытай мен АҚШ-та сәйкесінше шамамен 4 820 000 және 2 370 000 Жаңа қатерлі ісік және 3 210 000 және 640 000 қатерлі ісік өлімі болады. Қатерлі ісіктің ең көп таралған түрлері - Қытайдағы өкпе рагы және АҚШ - тағы сүт безі қатерлі ісігі, ал өкпе рагы екі елде де қатерлі ісік өлімінің негізгі себебі болып табылады. АҚШ-та жас бойынша стандартталған өкпе және колоректальды қатерлі ісік аурулары мен өлім-жітім көрсеткіштері жақында айтарлықтай төмендеді, бірақ бауыр қатерлі ісігінің көрсеткіштері аздап өсті. Қытайда асқазан, бауыр және өңеш қатерлі ісігінің көрсеткіштері біртіндеп төмендеді, бірақ бүкіл халық арасында колоректальды қатерлі ісік, ерлерде простата обыры және әйелдерде қатерлі ісіктің басқа жеті түрінің көрсеткіштері өсті. Ересектердің көбеюі және халықтың қартаюы қатерлі ісік ауруынан болатын өлім-жітімнің өсуін анықтайтын негізгі факторлар

болды, ал өлім-жітім екі елде де қатерлі ісік ауруынан болатын өлім-жітімнің төмендеуіне ықпал етті.

Қатерлі ісік - 2020 жылы қатерлі ісік диагнозы Еуропаның 4,8 миллион тұрғынына қойылды. Бұл күніне 13000 адам, сағатына 546 адам, минутына 9 адам. Біздің әрқайсымыз қатерлі ісікке шалдыққан адамдармен жеке таныспыз. Қазіргі уақытта Батыс Еуропаның әрбір үшінші тұрғыны және Шығыс Еуропаның әрбір төртінші тұрғыны өмір бойы қатерлі ісікке шалдығады.

Пандемияның алғашқы кезеңдерінде жұқпалы емес ауруларға байланысты қызмет көрсетудегі іркілістер әлемнің 163 елінің 122-сінде байқалды, ал Еуропа өңірі елдерінің үштен бірінде мұндай іркілістер онкологиялық көмек көрсетуге толық немесе ішінара әсер етті.

Алайда, қатерлі ісік ауруы белгілі бір елдердегі өлімнің жалпы деңгейімен байланысты емес. Кейбір аймақтарда қатерлі ісікпен ауыратын науқастарды емдеуге және олардың өмір сүру мүмкіндігін жақсартуға арналған ресурстар көп. Мысалы, Еуропа мен Солтүстік Америкада ісіктердің жалпы санына қарағанда қатерлі ісік ауруының өлім-жітімі төмен, ал Азия мен Африкада қатерлі ісік ауруының өлім-жітімі көп [7].

Темекі шегу ең маңызды қауіп факторы болып қала береді, бұл өкпенің қатерлі ісігінен өлімнің 20% құрайды. Алкогольді тұтыну Еуропа мен Америкада өлімнің ең көп таралған себебі болып табылады, ал дұрыс тамақтанбау және семіздік халықтың табысы төмен және орташа елдерде қауіп факторларына айналуда. Сонымен қатар, инфекциялар жаһандық деңгейде қатерлі ісік ауруының 18% - ына жауап береді, ал кедей аймақтарда бұл пайыз әлдеқайда жоғары [8].

2018 жылы Африка елдерінде 752000 жаңа қатерлі ісік ауруы (жалпы әлемдік көрсеткіштің 4%) және 506000 қатерлі ісік ауруы тіркелді. Аймақта онкологиялық ауыртпалықтың жалпы құрылымында сүт безі, жатыр мойны және простата қатерлі ісігі басым болғанымен, Африка елдерінде қатерлі ісік профилі өте алуан түрлі [6].

Үндістанда осы аурумен өмір сүретін адамдардың саны шамамен 2,25 миллион адамды құрайды. Үндістанда бір әйел әр 8 минут сайын жатыр мойны обырынан қайтыс болады. Үндістанда темекі шегуден болатын өлім-жітім күніне 3500-ден астам адамға бағаланады. Темекі шегу 2018 жылы 317 928 адамның өліміне әкелді (шамамен) [7].

Дүниежүзілік обыр обсерваториясының мәліметтері бойынша, қатерлі ісік - Қытайдағы өлім-жітімнің негізгі себебі, 2018 жылы 4 285 033 жаңа жағдай тіркеліп, 2 865 174 адам қайтыс болған. Алайда денсаулық сақтаудың жақсарғанына және онкологиялық ауруларға қарсы күреске қаражаттың ұлғаюына қарамастан Қытайдағы қатерлі ісік ауыртпалығы жоғары болып қала береді. Қатерлі ісік өлімінің 30% -ға жуығы өкпе

рагымен байланысты болды. Қалалық және ауылдық жерлерде өкпенің қатерлі ісігі ең көп таралған қатерлі ісік және өлімнің негізгі себебі болып қала берді [8].

Қатерлі ісік Австралиядағы аурудың негізгі себептерінің бірі болып табылады және жеке адамдарға, отбасыларға және қоғамға айтарлықтай әлеуметтік және экономикалық әсер етеді. Себебі соңғы жылдары Австралия қатерлі ісік ауруының статистикасы бойынша көш бастап келе жтқан елдердің қатарында.Австралияда онкологиялық аурулардың жасы бойынша стандартталған әлемдегі ең жоғары көрсеткіш бар-100000 адамға шаққанда 452,4 жағдай. Австралияда әлемдегі сүт безі қатерлі ісігі мен меланоманың ең жоғары көрсеткіштері бар.

Ресей сонымен бірге Дүниежүзілік банк анықтағандай, табысы жоғары және экономикасы дамып келе жатқан ел. Бірақ, осы айырмашылыққа қарамастан, өмір сүру ұзақтығы елдің өсіп келе жатқан байлығына сәйкес өскен жоқ, атап айтқанда, қатерлі ісік барлық өлімнің 15% құрайды. Ресейде қатерлі ісік ауруынан болатын өлім-жітім Еуропа мен АҚШ-қа қарағанда едәуір жоғары. Барлық онкологиялық науқастардың төрттен бір бөлігі (26%) диагноз қойылғаннан кейін бір жыл ішінде қайтыс болады, дегенмен бұл көрсеткіш географиялық аймақ бойынша айтарлықтай өзгереді.

Халықтың қартаюы және экономикалық дамумен байланысты өмір салты өзгерген Азия елдерінде қатерлі ісік маңызды денсаулық сақтау проблемасына айналуда. 2018-2022 жылдарға арналған онкологиялық аурулармен күрес жөніндегі кешенді жоспардың іс-шараларын іске асыру барысында қатерлі ісіктерден болатын өлім-жітімді 9%-ға төмендетудің оң үрдісі бар, деп хабарлады профессор. Д.Қайдарованың мәліметінше, Қазақстанда жыл сайын 35 мыңнан астам адам обырға шалдығады, онкологиялық есепте 200 мың қазақстандық тұрады. ҚР-да онкологиядан өлім-жітім алдыңғы қатарда болып табылады және үшінші орында тұр. Онкологиялық сырқаттанушылық құрылымында бірінші орында дәстүрлі түрде сүт безі обыры (13,2%, 5166 жағдай); екінші орында – өкпе обыры (10,0%, 3926 жағдай), үшінші орында – колоректалдық обыр (9,3%, 3654 жағдай), төртінші орында – асқазан обыры (7,4%, 2912 жағдай) тұр. Бүгінгі күні қатерлі ісік ауруы Қазақстандағы мезгілсіз өлімнің негізгі себептерінің бірі болып табылады. Бұл Қазақстандағы қатерлі ісік проблемасы туралы жалпы хабардар ету қажеттілігін көрсетеді. Қатерлі ісік аурулары Қазақстандағы қарт және егде жастағы адамдардың ауруы болып қала береді.

Бүгінгі күні, яғни 2017 жылы Ресей халқының өлім-жітім себептерінің құрылымында қатерлі ісіктер жарақаттар мен уланулардан озып, қанайналым жүйесі ауруларынан кейін екінші орында тұр. [65]

Қатерлі ісік аурулары, егер олар жеңілдетілмесе, қайғы-қасіретке, ыңғайсыздыққа және эмоционалды, әлеуметтік және рухани салдарға, сондай-ақ пациенттер мен олардың отбасыларының мүгедектігіне әкелуі мүмкін көптеген проблемаларға тап болады. Жан-жақты күтімнің арқасында пациенттер мен олардың отбасы мүшелерінің өмір сапасы жақсаруы және лайықты түрде қамтамасыз етілуі мүмкін.

Зерттеу мақсаты

Химиотерапиядан кейінгі кезеңдегі пациенттердің күтімі мен тамақтануында мейіргердің білім деңгейі.

Тәсілдер мен материалдар

Зертеуге Қызылорда облыстық онкология орталығының емделушілері 24 адам қатысты,сауалнама онлайн түрде уатцап желісі арқылы жүргізілді. Сауалнама барысында химиотерапиядан кейінгі кезеңдегі пациенттердің күтімі мен тамақтануында мейіргердің білім деңгейі қандай екені анықталды.

Пациенттерге арналған сауалнама 15 сұрақтан тұрды. Әр сұраққа бірнеше жауап берілді. Респонденттерге ыңғайлы болу және сауалнама нәтижелерін жақсарту үшін пациенттерге екі тілде - қазақ және орыс тілдерінде сауалнама дайындалды. Сауалнама жасырын түрде өткізілді, зерттеуге қатысушылар кездейсоқ таңдалған. Зерттеуге қатысушылардан зерттеуге рұқсат беруге жазбаша түрде келісім алынды.

З**ерттеу түрі:** сапалық

Зерттеу дизайны: сапалы зерттеу, феноменалдық; популяцияға негізделген мақсатты таңдау.

Зерттеу объектісі: Қызылорда облысының онкология орталығы.

Орталық заманауи жаңа жоғары технологиялық жабдықтармен жабдықталған. Медициналық көмектің көлемі мен талаптарына сәйкес келеді. Бөлімше қызметкерлері жаңа теориялық білім алу мен практикалық дайындықта үнемі жетілдіріледі.

Зерттеу құралы

Сауалнама екі мақалаға сүйене отырып жасалынды, яғни доцент Н.В.Востриковаың жетекшілігімен «Химиотерапиядан кейінгі пациенттерді мейіргерлердің күтуін ұйымдастыру ерекшеліктері» және А.В.Мысливцева мен В.Г.Заиканың «Онкологиялық патологиясы бар пациенттердің эмоционалдық жағдайына химиотерапияның әсері».

«Химиотерапиядан кейінгі пациенттерді мейіргерлердің күтуін ұйымдастыру ерекшеліктері» тақырыбы бойынша зерттеу 2019 жылдың қараша айынан желтоқсан айына дейін жүргізілді. Зерттеу Ростов ғылыми-зерттеу онкологиялық институтының

урологиялық бөлімінде 2013 жылдың қыркүйек айынан 2014 жылдың сәуір айына дейін жүргізілді.

Зерттеуге РФ Ресейдің Алтай өлкесі бойынша КТБ-12 МСЧ-22 ФСИН базасындағы стационар жағдайында онкологиялық емделіп жатқан пациенттер мен Ростов ғылыми-зерттеу онкологиялық институтының урологиялық бөлімінде жатақан пациенттер қатысты. Осы зерттеулердегі сауалнама сұрақтарының үлгісі зерттеуде қолданылады.

Қорытынды

Бұл жұмыста мейірбикенің онкологиялық науқастарға күтім жасау ерекшеліктері зерттелді. Қарастырылып отырған мәселенің өзектілігі өте үлкен және қатерлі ісіктермен сырқаттанушылықтың артуына байланысты онкологиялық науқастарға мамандандырылған көмек көрсету қажеттілігі артып келеді, мейірбикелік күтімге ерекше назар аударылады, өйткені мейірбике дәрігердің көмекшісі ғана емес, сонымен қатар сауатты, өздігінен жұмыс істейтін маман.

Зерттеу жұмысының нәтижесі бойынша химиотерапиядан кейінгі кезеңдегі пациенттердің күтімі мен тамақтануында мейіргердің білім деңгейі 80 % құрады. Қатерлі ісік ауруларын емдеу барысында дәрігердің тағайындауымен қатар пациенттің тамақтануы мен күтімі маңызды рөл атқарады. Пациенттердің психологиялық жағдайы да емдеу барысына әсер етеді.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. ^ «Қатерлі ісіктің алдын алу және ерте анықтау фактілері мен сандары 2017-18» (PDF). *Cancer.org. 1 сәуір, 2017.*

2. ^ *Danaei G, Vander Hoorn S, Lopez AD, Murray CJ, Ezzati M (2005). «Әлемдегі қатерлі ісік ауруының себептері: мінез-құлық пен экологиялық қауіпті тоғыз фактордың салыстырмалы қаупін бағалау». Лансет. 366 (9499): 1784–93.* doi:10.1016 / S0140-6736 (05) 67725-2. PMID 16298215.

3. ^ *Doll R, Peto R (1981). «Қатерлі ісік ауруының себептері: қазіргі кездегі Америка Құрама Штаттарындағы қатерлі ісіктің алдын-алу қаупінің сандық бағалары». Дж. Натл. Қатерлі ісік ауруы. 66 (6): 1191–308.* doi:10.1093 / jnci / 66.6.1192. PMID 7017215.

4. ^ *Anand P, Kunnumakkara AB, Kunnumakara AB, Sundaram C, Harikumar KB, Tharakan ST, Lai OS, Sung B, Aggarwal BB (2008).* «Қатерлі ісік - бұл өмір салтын өзгертуді қажет ететін алдын-алатын ауру». *Фарм. Res. 25 (9): 2097–116.* doi:10.1007 / s11095-008-9661-9. PMC 2515569. PMID 18626751.

5. ^ «CRISPR генді өңдеу құралы қатерлі ісік иммунотерапиясын жақсартуға көмектеседі». *Ұлттық онкологиялық институт. 2017-03-20*. Алынған 2018-03-09.

6. ^ «ДДҰ-ның аурулары мен жарақаттарының елдерінің бағалауы». *Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы. 2009*. Алынған 11 қараша 2009.

7. ^ «Қатерлі ісіктің алдын алу». *2014-02-12.*

8. ^ а б *Куши Л.Х., Дойл С, МакКулоу М және т.б. (2012). «Қатерлі ісік ауруларының алдын алу үшін тамақтану және физикалық белсенділік бойынша американдық қатерлі ісік қоғамы туралы нұсқаулық: сау тамақ таңдау және физикалық белсенділікпен қатерлі ісік қаупін азайту». CA Cancer клиникасы. 62 (1): 30–67.* doi:10.3322 / caac.20140. PMID 22237782.

Паллиативті көмектің амбулаторлы жағдайда ұйымдастырудағы мейіргердің қызметі

Касимова Камила, оқытушы

Шымкент қ. Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Жоғары медицина колледжі» МКК

Аннотация

Қазіргі таңда паллиативті көмекті қажет ететін адамдар саны артуда. Паллиативті көмек – қауіпті аурудан зардап шегетін науқас үшін мамандандырылған медициналық қызмет көрсету, диагнозға қарамай аурудың белгілерін жеңілдету, емделушінің және оның отбасының өмір сапалығын жақсарту. Ресми деректерге сүйенсек, бүгінгі күні әлемде 20 млн науқас ауруы әбден асқынып, ем қонудан кеткен шақта көмекті қажет етеді екен.

Кілт сөздер: паллиативті көмек, мейіргерлік күтім, амбулаторлы көмек, мультидисциплинарлы команда, қатерлі ісік.

В настоящее время растет число людей, нуждающихся в паллиативной помощи. Паллиативная помощь-это специализированное медицинское обслуживание пациента, страдающего опасным заболеванием, облегчение симптомов заболевания независимо от диагноза, улучшение качества жизни пациента и его семьи.

Ключевые слова: паллиативная помощь, сестринский уход, амбулаторная помощь, мультидисциплинарная команда, рак.

Currently, the number of people in need of palliative care is growing. Palliative care is specialized medical care for a patient suffering from a dangerous disease, relief of symptoms of the disease regardless of the diagnosis, improvement of the quality of life of the patient and his family.

Keywords: palliative care, nursing care, outpatient care, multidisciplinary team, cancer.

Кіріспе

Қазіргі қоғамдық пікір осындай, медицинаның қазіргі деңгейіне қол жеткізгеніне қарамастан, қатерлі ісік диагнозы (аурудың сатысына қарамастан) өмірдің ерте аяқталуына әкелетін өлім үкімі ретінде қарастырылады. Алайда, бұл олай емес, ерте кезеңде анықталған қатерлі ісік емделеді, ал онкологиялық аурудың асқынған түрі бар науқастарға келетін болсақ, мұнда бәрі әлі де жоғалған жоқ және үмітсіз. [1] Науқастың қасіретін жеңілдетуге, оның адамдық қадір-қасиетін сақтауға, оның қажеттіліктерін анықтауға және оның соңғы кезеңінде өмір сүру сапасын сақтауға бағытталған паллиативтік шаралар кешені бар. Сонымен қатар паллиативтік көмектің міндеттеріне науқастың отбасына әлеуметтік-психологиялық қолдау көрсету кіреді [2]. Терминалды сатыдағы қатерлі ісікпен науқас отбасылық дисфункцияның себебі болады, өйткені бұл туыстары мен достары үшін үлкен моральдық күйзеліс тудырады, сонымен қатар экономикалық, әлеуметтік және психологиялық қиындықтарды тудырады, бұл олардың өмір сүру сапасының төмендеуіне әкелуі мүмкін. бүкіл отбасы. [3]. Науқасқа жаны ашитын, жанашыр туыстары көбіне дәрменсіз күйде, мұндай жағдайларда қалай әрекет ету керектігін білмей, мәселені шешудің түрлі жолдарына жүгінеді, бірақ үмітсіз күйде қалады. Науқастың туыстары, көбінесе терең моральдық бұзылу жағдайында, науқасқа қалай дұрыс күтім жасау керектігін білмей, ауыр жүкті иықтарына алады, қай жерде ауырған дұрыс: үйде немесе астында дәрігерлер мен медбикелердің бақылауында, егер науқас не істеу керек ауырсынудан зардап шегеді ме? Көпсалалы паллиативтік көмек тобын құру туралы мәселе бірнеше рет көтерілді, ол ауыр онкологиялық науқастарға үйіне баруға мүмкіндік береді [4].

Мақсаты

Шымкент қаласы тұрғындарының паллиативтік көмек туралы білім деңгейін зерделеу және анонимді сауалнама нәтижелері бойынша паллиативтік көмектің көп бейінді командасын құру қажеттілігін анықтау.

Материалдар мен зерттеу әдістері

Шымкент қаласы тұрғындарының паллиативтік көмек туралы білім деңгейін зерделеу және паллиативтік көмектің көп бейінді командасын құру қажеттілігін анықтау үшін тұрғындар арасында екі кезеңде анонимді сауалнама жүргізілді. Қадамдар паллиативтік көмек туралы қысқаша ақпараттық хабарламамен бөлінген. Кездейсоқ іріктеу әдісімен зерттеуге Шымкент қаласының тұрғындары 18 бен 45 жас аралығындағы 50 респондент қатысты. Респонденттердің орта жасы 30 ± жас. Респонденттердің 27 (54%) ер адам, 23 (46%) әйел адам. Ұсынылатын команда құрамы: 1 паллиативтік көмек маманы, 1 онколог, қоғамдық дәрігер, 1 медбике, 1 психолог, 1 әлеуметтік қызметкер, 1 волонтер, 1 заңгер. Қажет болса, діни қызметкерді қосуға болады [3].

Нәтижелері

Алынған мәліметтерді талдау кезіндегі нәтижелері: сауалнамаға қатысқан респонденттердің жартысынан көбі паллиативтік көмектің не екенін біледі. 50 респонденттен: 31 (62%) паллиативтік көмектің дұрыс тұжырымдамасын таңдады; 9 (18%) паллиативтік көмектің не екенін білмейді; 6 (12%) респондент паллиативтік көмекті шетелде тегін емделу деп есептесе, 4 (8%) респондент жалғызбасты адамдарға тегін көмек көрсетумен айналысатын ұйым деп есептеді. Респонденттерге паллиативтік көмек туралы қысқаша ақпараттық хабарламадан кейін қатысушылар екінші кезеңге қатысуды ұйғарды. Екінші кезеңде барлығы дерлік мультидисциплинарлық паллиативтік көмек тобын құру қажет деп жауап берді: 46 респондент (92%) «иә», 4 респондент (8%) «жоқ» деп жауап берді «Иә, мультидисциплинарлық паллиативтік көмек тобын құру қажет» деп жауап берген респонденттер өз пікірлерін келесі дәлелдермен түсіндірді; 31 (62%) респондент мультидисциплинарлы паллиативтік көмек көрсету тобы қаржылық қиындықтарға тап болған науқастар мен олардың жақындарына жақсы қолдау болып табылады деп есептейді; мультидисциплинарлық паллиативтік көмек тобы суицид деңгейін төмендетеді деп 7 (14%) жауап берді; 6 (12%) паллиативтік көмектің көп бейінді командасы терминалдық кезеңде пациенттердің өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған жаңа мемлекеттік бағдарламалар мен заңдарды әзірлеуге көмектеседі деп есептейді; 2 (4%) мультидисциплинарлық паллиативтік көмек командасы медициналық көмектің сапасын арттыруға көмектеседі деп есептейді.

«Көп бейінді паллиативтік көмек тобын құрудың қажеті жоқ» деп жауап берген респонденттер келесі дәлелдерді ұсынды. 2 (4%) респондент мультидисциплинарлық паллиативтік көмек тобын құрудың қажеті жоқ, өйткені оны қаржыландыру жоқ, 1 (2%) респондент көпсалалы паллиативтік көмек бригадасын құрудың қажеті жоқ, өйткені қалада жақсы қолжетімді медициналық мекемелер бар деп жауап берді; 1 (2%) респондент мультидисциплинарлық паллиативтік көмек бригадасын құрудың қажеті жоқ, себебі медициналық кадрлардың тапшылығы проблемасы бар деп жауап берді.

Қорытынды

Сауалнама нәтижелерін зерделей келе, Еуропа елдерінде ол ұзақ уақыт бойы көрсетіліп, хосписте табысты қызмет атқарса да, Шымкент қаласының тұрғындары паллиативтік көмек түсінігімен әлі де таныс емес деген қорытынды жасауға болады. Көпсалалы паллиативтік көмек командасын құру идеясына келетін болсақ, респонденттердің 100% қолдауы болды. Көп бейінді паллиативтік көмек тобын құру науқастар мен олардың отбасыларының өмір сүру сапасын айтарлықтай жақсартуға мүмкіндік береді.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

A. Кайдарова Д.Р., Кунирова Г.Ж. Паллиативная помощь в Казахстане: этапы развития и текущие вызовы. Онкология и радиология Казахстана, 2016, 41 (3), 114-121.

B. Уашева А.К., Кумарова Г. Х. Современные аспекты паллиативной помощи и сестринского ухода. Социальная поддержка пациентов, нуждающихся в паллиативной памощи на уровне ПМСП. 2013 г. С.: 187-189.О.Ю.

C. Кузнецовой Под редакцией профессора О.Ю. Паллиативная помощь в амбулаторных условиях. Москва ГЭОТАР - Медиа 2021. - ISBN 978-5-9704-5948-5.

D. Ходаревская Ю.А. о Некоторых проблемах оказания паллиативной помощи инкурабельным онкобольным 4-ой клинической группы и их родственникам в рф//система ценностей современного общества. - 2015.-№43.-с.126-132

Организация паллиативной помощи и мультидисциплинарное взаимодействие

Куспекова Айнур[1], Оспанова Аяужан [2]

[1] Студентка, [2] научный руководитель.

Усть-Каменогорский высший медицинский колледж

Аннотация

В статье рассматриваются современные подходы к организации паллиативной помощи, её значение для повышения качества жизни пациентов с тяжёлыми и неизлечимыми заболеваниями. Отмечается важность мультидисциплинарного взаимодействия врачей, медсестёр, психологов и социальных работников.

Ключевые слова: паллиативная помощь, мультидисциплинарная команда, качество жизни, уход.

Введение

Паллиативная помощь — это особая область медицины и социальной поддержки, направленная на улучшение качества жизни пациентов, страдающих от тяжёлых и неизлечимых заболеваний, а также членов их семей. Главная цель паллиативной помощи заключается не в продлении жизни любой ценой, а в облегчении страданий и создании максимально комфортных условий для пациента.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно более 40 миллионов человек во всём мире нуждаются в паллиативной помощи, однако лишь 14% получают её в полном объёме. В Казахстане развитие паллиативной медицины является

одной из приоритетных задач здравоохранения, однако остаются трудности, связанные с кадровым обеспечением, инфраструктурой и информированностью населения.

Основные принципы паллиативной помощи

Ключевые принципы организации паллиативной помощи включают:

1. Приоритет качества жизни – цель помощи заключается в облегчении боли, уменьшении физического и психологического страдания.
2. Комплексный подход – учитываются медицинские, психологические, социальные и духовные потребности пациента.
3. Поддержка семьи – помощь направлена не только на пациента, но и на его близких.
4. Доступность и преемственность – паллиативная помощь должна оказываться на всех уровнях здравоохранения.
5. Мультидисциплинарность – взаимодействие специалистов разных профилей.

Организация паллиативной помощи в Казахстане

На сегодняшний день паллиативная помощь в Казахстане развивается по нескольким направлениям:

- специализированные хосписы и отделения в медицинских учреждениях;
- выездные службы паллиативной помощи на дому;
- патронажные службы и социальное сопровождение;
- центры консультативной поддержки для пациентов и их родственников.

Несмотря на предпринимаемые меры, остаются значительные проблемы: ограниченное количество хосписов, нехватка подготовленных специалистов, недостаток финансирования и низкая информированность общества о возможностях паллиативной помощи.

Мультидисциплинарная команда в паллиативной помощи

Одним из ключевых условий эффективности паллиативной медицины является слаженная работа мультидисциплинарной команды.

В состав команды обычно входят:

- врач-терапевт или онколог;
- медицинская сестра;
- психолог или психотерапевт;
- социальный работник;
- при необходимости — юрист и духовный наставник.
- Распределение ролей в команде:

- врач отвечает за контроль боли и симптоматическое лечение;
- медсестра обеспечивает уход, мониторинг состояния и выполнение назначений;
- психолог помогает справляться с тревогой, депрессией и страхом;
- социальный работник решает вопросы правовой и социальной поддержки семьи;
- духовный наставник оказывает моральную поддержку, если это важно для пациента и его близких.

Мультидисциплинарный подход позволяет комплексно охватить все потребности пациента, а также уменьшить нагрузку на семью.

Международный опыт

Опыт развитых стран показывает эффективность интеграции паллиативной помощи в систему здравоохранения:

- Великобритания: сеть хосписов, финансируемых как государством, так и благотворительными фондами.
- Канада: акцент на выездные службы и домашний уход, позволяющий пациентам оставаться в привычной среде.
- Германия: паллиативная помощь включена в систему обязательного медицинского страхования.

Эти примеры демонстрируют, что государственная поддержка в сочетании с мультидисциплинарным взаимодействием повышает эффективность системы паллиативной медицины.

Перспективы развития в Казахстане

Для дальнейшего совершенствования системы паллиативной помощи в Казахстане необходимо:

- увеличить количество хосписов и выездных служб;
- расширить подготовку кадров по специальности «паллиативная медицина»;
- внедрить программы повышения квалификации для медицинских сестёр и социальных работников;
- активнее привлекать волонтёров и неправительственные организации;
- проводить просветительские кампании для населения.

Заключение

Паллиативная помощь является неотъемлемой частью современной медицины, направленной на улучшение качества жизни пациентов с тяжёлыми и неизлечимыми

заболеваниями. Эффективность её организации напрямую связана с междисциплинарным взаимодействием специалистов, а также с уровнем государственной и общественной поддержки.

Для Казахстана ключевыми задачами остаются расширение инфраструктуры, подготовка кадров и развитие мультидисциплинарных команд. Только в условиях комплексного подхода можно обеспечить достойное качество жизни пациентам и их семьям.

Список использованных источников:

1. Всемирная организация здравоохранения. Palliative care. Geneva, 2023.
2. Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Концепция развития паллиативной помощи. Астана, 2022.
3. Connor S.R., Bermedo M.C.S. Global atlas of palliative care. WHPCA, 2020.
4. Раджабова Л.М. Паллиативная медицина. – Алматы, 2021. – 256 с.
5. Knaul F.M. et al. Alleviating the access abyss in palliative care and pain relief. The Lancet Commission, 2018.

Сохранение качества сна у онкологических пациентов с помощью сестринских вмешательств

Ярошинская Ирина[1], Салимова Аружан[2]

[1] Преподаватель специальных дисциплин Кокшетауского высшего медицинского колледжа, [2]медицинская сестра ТОО «Viamedis»

Аннотация: В работе представлены данные исследования, касающиеся практики сестринского дела, направленной на оказание помощи онкологическим пациентам. Исследование включало разработку эффективных методов немедикаментозного вмешательства.

Ключевые слова: качество сна, инсомния, улучшение сна, гайдлайны

Согласно данным Казахстанской ассоциации паллиативной помощи, ежегодная потребность в паллиативной помощи составляет до 128 тысяч пациентов, включая до 9 тысяч детей, при этом помощь получают не более 25%. В перспективных реалиях Министерством здравоохранения Республики Казахстан разрабатывается Дорожная карта развития паллиативной медицинской помощи населению на 2026–2028 годы.

Исследовательское направление определила проблема показателя высокого уровня тревожности у пациентов с онкологическими заболеваниями, которые негативно отражаются на большей части аспектов качества жизни пациентов в том числе и качестве

их сна. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), бессонницей страдают до 15-20% всего мирового населения, а каждый второй взрослый человек на планете испытывает один или несколько симптомов нарушения сна. В МКБ-10, под инсомнией понимается совокупность первичных психогенных состояний, характеризующихся эмоционально обусловленным нарушением качества, длительности и ритма сна. От 30% до 60% пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями, испытывают различные формы нарушений сна. [1, с.201]

В последние годы растет интерес к немедикаментозным методам улучшения сна, особенно в сфере сестринской практики. Освоение медицинской сестрой навыков независимых сестринских вмешательств для управления сном и их применение в паллиативной практике могут положительно воздействовать на пациента, изменить его отношение к болезни, улучшить качество сна и качество жизни. [1, с.104] Исследовательский вопрос состоял в том: можно ли улучшить качество сна у пациентов с онкологическими заболеваниями с помощью нефармакологических методов?

Исследование проводилось на клинической базе ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» г. Кокшетау, участок № 103, который обслуживает 2330 взрослого населения от 18 лет и старше. На первом этапе исследования с использованием Питтсбургского опросника по оценке качества сна был проведён анализ состояния качества сна у 30 пациентов состоящих на онкологическом учёте. [2, с.45]

Результаты анализа опроса свидетельствовал о том, что 76,67% изучаемой группы испытывают проблемы со сном "почти каждую ночь", и 23,33% пациентов отмечают, что они сталкиваются с этими проблемами "несколько раз в неделю". Это подтверждает, что онкологические пациенты действительно часто сталкиваются с нарушениями сна, и это может быть связано как с самой болезнью, так и с побочными эффектами лечения. Качество сна у пациентов с онкологическими заболеваниями может ухудшаться под воздействием различных факторов, таких как психологический стресс, боль, побочные эффекты лечения, изменения в режиме сна.

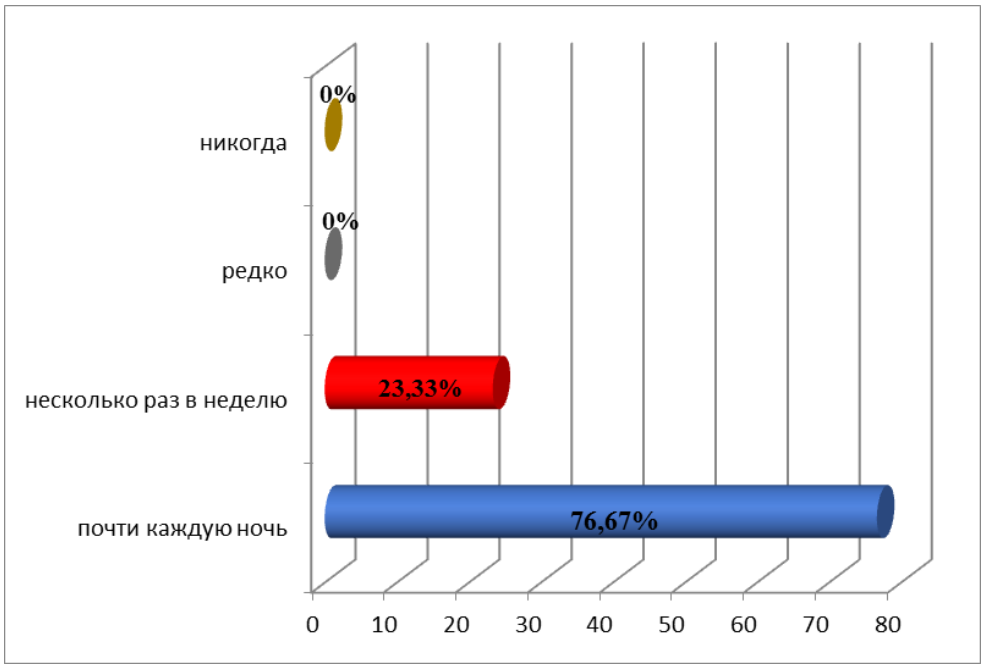


Рисунок 1- Показатели частоты проблем со сном

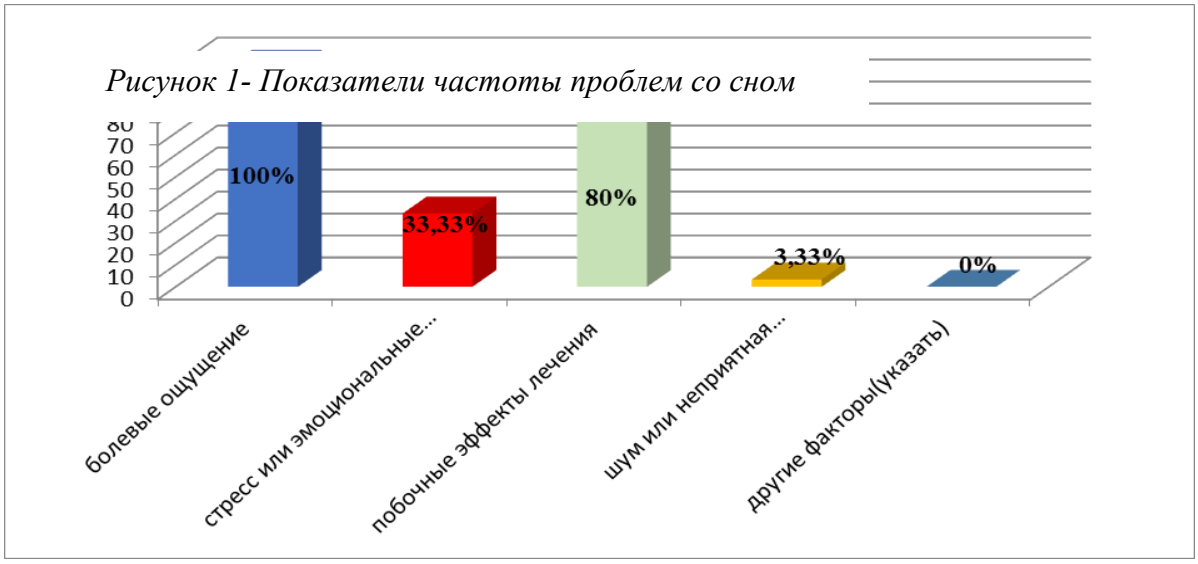


Рисунок 2–Факторы влияющие на качество сна

Важно отметить, что 100% опрошенных пациентов указывают на то, что боль и дискомфорт, связанные с раком и его лечением, мешают им спать и приводят к пробуждениям. 33,33% респондентов отметили "стресс и эмоциональные проблемы", так как диагноз рака и лечение вызывает эмоциональный стресс и тревожность, что напрямую связано с качеством сна. 80% пациентов ответили, что побочные эффекты медикаментозных вмешательств используемых при лечении рака влияют на их сон, вызывая бессонницу или сонливость в неподходящее время суток. "Шум или неприятная обстановка в спальне" мешают полноценному засыпанию и сну у 3,33% пациентов.

Исходя из анализа, подтверждающего существующую проблему, акцент был сделан на исследовательском вопросе и проведен исследовательский эксперимент, который состоял

из тщательного изучения научной и доказательной литературы, систематизации и разработки немедикаментозных гайдлайнов по коррекции и гигиене сна. В период трёхмесячного эксперимента испытуемый мог изучить, выбрать, применить предложенные гайдлайны в формате рекомендаций, инструкций, пикторгамм, практических приёмов.

Эффективность и доказательность эксперимента завершалась использованием однокомпонентной шкалы https://diseases.medelement.com/material, где респондентов просили оценить качество сна по 10 бальной шкале. [3, с.775]

Проведённая исследовательская работа позволила сделать выводы:

1. Изучение исследовательских данных и ВОЗ подтверждаются статистикой о нарушении качества сна у онкологических пациентов от 30% до 60%.
2. Анализ проведённого исследования показал что проблемы сна тревожат каждого пациента: 76,67 % «почти каждую ночь», 23,33% пациентов указывают на «несколько раз в неделю».
3. 86,7 % пациентов отметили улучшение и стабильность сна с использованием предложенных рекомендаций, что подтверждает их позитивность и призывает к расширению применения безопасных независимых сестринских вмешательств.

Увеличение выживаемости при онкологических заболеваниях означает необходимость сосредотачиваться не только на повышении шансов на выживание, но и на обеспечении комфортного качества жизни для пациентов. [2, с.45]. В этой задаче медицинские сестры играют важную роль, так как сестринская практика включает в себя близкие отношения с пациентами и обучение им немедикаментозным методам, улучшения их физического и психического состояния, что следует рассматривать как особую компетенцию.

Список использованных источников:

1. Аллахьяри Дж., Ширани Н., Саргхолзаи Ф.Д., Камалинежад С., Рахдар З. Качество сна и связанные с ним факторы у онкологических больных: систематический обзор . Пренса Мед Арджент 2018; (с.201, с. 104).
2. Синкявичюте Э.Р врач-психотерапевт Гигиена сна статья- 2023.
3. Induru R.R., Walsh D. Cancer-related insomnia // Am. J. Hosp. Palliat. Care. 2014. Vol. 31, N. 7. P. 777–785.

Сестринское дело как движущая сила изменений: от повседневного ухода к стратегическому лидерству в борьбе с раком

Кадырбаева Каракат, Раимбекова Умут
Преподаватели специальных дисциплин
Кокшетауский высший медицинский колледж

Аннотация

В условиях растущего глобального бремени онкологических заболеваний традиционные модели медицинской помощи становятся недостаточными. Сестринское дело в онкологии трансформируется из вспомогательной клинической функции в одну из ключевых движущих сил стратегических изменений в системе здравоохранения.

Целью данной статьи является анализ современного состояния и перспектив развития сестринского лидерства в онкологической практике. Рассмотрены вопросы эволюции профессиональной роли медицинсой сестры, расширение функциональных обязанностей, барьеры внедрения лидерских моделей в практической деятельности, а также доказательства эффективности участия медицинских сестёр в управлении онкологической помощью. Выводы подчеркивают необходимость развития лидерских компетенций среди сестринского персонала и формирования устойчивой инфраструктуры поддержки профессионального роста.

Ключевые слова: *онкология, сестринское дело, медицинская сестра, стратегическое лидерство, уход за пациентами, система здравоохранения.*

Аннотация

Онкологиялық аурулардың жаһандық ауыртпалығы артып келе жатқан жағдайда, медициналық көмектің дәстүрлі үлгілері жеткіліксіз болады. Онкологиядағы мейірбике здравоохранения көмекші клиникалық функциядан Денсаулық сақтау жүйесіндегі стратегиялық өзгерістердің негізгі қозғаушы күштерінің біріне айналады.

Бұл мақаланың мақсаты онкологиялық тәжірибеде мейірбикелік көшбасшылықты дамытудың қазіргі жағдайы мен перспективаларын талдау болып табылады. Мейірбикенің кәсіби рөлінің эволюциясы, функционалдық міндеттерін кеңейту, практикалық қызметте көшбасшылық модельдерді енгізудегі кедергілер, сондай-ақ мейірбикелердің онкологиялық көмекті басқаруға қатысуының тиімділігі туралы дәлелдер қарастырылды. Қорытындылар мейірбике қызметкерлері арасында көшбасшылық құзыреттілікті дамыту және кәсіби өсуді қолдаудың тұрақты инфрақұрылымын қалыптастыру қажеттілігін көрсетеді.

Түйін сөздер: онкология, мейірбике ісі, мейірбике, стратегиялық көшбасшылық,

пациенттерге күтім жасау

Annotation

In the context of the growing global burden of cancer, traditional models of medical care are becoming insufficient. Oncology nursing is being transformed from an auxiliary clinical function into one of the key driving forces of strategic changes in the healthcare system.

The purpose of this article is to analyze the current state and prospects for the development of nursing leadership in oncological practice. The issues of the evolution of the professional role of a nurse, the expansion of functional responsibilities, barriers to the introduction of leadership models in practice, as well as evidence of the effectiveness of nurses' participation in cancer care management are considered. The findings emphasize the need to develop leadership competencies among nursing staff and create a sustainable infrastructure to support professional growth.

Keywords: oncology, nursing, nurse, strategic leadership, patient care, healthcare system.

Введение

Онкологические заболевания входят в число ведущих причин смертности в мире и продолжают представлять значимую медицинскую, социальную и экономическую проблему.

Почему важна трансформация роли сестринского дела:

- изменения в онкологической службе: внедрение новых методов лечения (таргетная терапия, иммунотерапия, персонализированная медицина), увеличение длительности жизни пациентов, повышение числа выживших — все это ставит новые задачи перед медицинскими сестрами;
- социальные ожидания: пациенты больше информированы, хотят участвовать в принятии решений, нуждаются в психологической поддержке, ориентированы на качество жизни;
- сложность и нагрузка: сокращение времени госпитализации, переход к амбулаторному лечению, рост требований к навыкам: коммуникационные, лидерские, технологические.

Современные методы лечения требуют не только высокотехнологичных вмешательств, но и скоординированного, пациентоориентированного подхода. И в этом контексте особую роль играют медицинские сестры, которые всё чаще участвуют не только в клинической практике, но и в управлении, образовании, исследовательской деятельности и стратегическом планировании.

В мировой практике наблюдается устойчивый тренд к расширению роли медицинской сестры в онкологии — от базового ухода к активному участию в разработке и внедрении клинических протоколов, управлении качеством медицинских услуг и адвокации интересов пациента.

Сестринское дело в онкологии уже не ограничивается клиническими обязанностями. Оно включает:

Клиническое принятие решений **-** медицинская сестра обладает клинической автономией: участвуют в диагностике и скрининге рака, в оценке состояния, отслеживает динамику, оценивает побочные эффекты, предлагает коррекцию ухода и профилактику осложнений.

Пациентоориентированный подход **-** сестры становятся основным звеном коммуникации между пациентом, семьей и командой. Они адаптируют информацию, помогают пациенту ориентироваться в лечении, сопровождают пациента по пути диагностики – лечения – реабилитации – выживания, обеспечивают эмоциональную поддержку.

Образование и наставничество - опытные медицинские сёстры обучают коллег, внедряют современные практики, участвуют в разработке профессиональных стандартов и протоколов, ведут образовательную работу среди пациентов.

Лидерство в системе здравоохранения - онкологические медицинские сёстры могут занимать управленческие и стратегические должности, участвовать в создании политики, внедрении новых моделей ухода и реформировании системы.

Однако в условиях отечественной системы здравоохранения этот потенциал до сих пор реализуется не в полной мере. И настоящее исследование направлено на систематизацию данных о роли и возможностях сестринского лидерства в онкологической помощи, выявление существующих барьеров и перспектив дальнейшего развития.

Методы

В рамках данной обзорной статьи проведен анализ международной и отечественной литературы, касающейся вопросов расширения роли медсестёр в онкологической практике. Использованы данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), международных профессиональных ассоциаций, исследования роли медсестёр-онкологов в США, Гонконге, Северной Америк.

Результаты и обсуждение

1. Эволюция роли медицинской сестры в онкологической помощи

Исторически сестринская практика в онкологии фокусировалась на оказании паллиативной помощи и поддержании базовых функций пациента. Современные реалии продиктовали необходимость пересмотра этой парадигмы. Сегодня медсестры участвуют в следующих аспектах онкологической помощи:

- мониторинг побочных эффектов лечения;
- ведение пациентских маршрутов;

- координация мультидисциплинарной помощи;
- психоэмоциональная поддержка и обучение пациентов;
- клинический аудит и контроль качества.

2. Лидерство и управленческий потенциал

Медицинские сестры в развитых системах здравоохранения выполняют функции лидеров изменений. Они принимают участие в разработке стратегий, повышают эффективность работы команд, способствуют сокращению времени до начала лечения, улучшают коммуникацию между уровнями системы. Например, внедрение пациентских маршрутов в онкологических клиниках США и Канады позволило снизить среднее время от постановки диагноза до начала терапии на 25–30%.

3. Барьеры реализации лидерского потенциала

Основными ограничивающими факторами являются:

- нормативно-правовые ограничения профессиональных полномочий;
- недостаточная доступность специализированных образовательных программ;
- перегрузка персонала и недостаток кадров;
- низкий уровень признания лидерской роли меицинских сестёр на системном уровне;
- отсутствие поддержки на уровне управленческих структур;
- культурные и институциональные стереотипы.

Для преодоления этих барьеров необходима системная работа, включая развитие образования, создание карьерных маршрутов и поддержку со стороны руководства.

4. Международные инициативы и стратегические подходы

ВОЗ и международные профессиональные ассоциации подчеркивают важность развития лидерского потенциала медсестёр. В ряде стран реализуются целевые программы:

- магистерские и докторские программы по клиническому лидерству;
- программы менторства и наставничества;
- вовлечение медсестёр в научно-исследовательскую деятельность;
- интеграция медсестёр в управление проектами по борьбе с раком.

Заключение

Сестринское дело в онкологии проходит глубокую трансформацию. Сестринская практика уже не просто часть ухода — это движущая сила изменений в онкологии, мост между пациентом, клиникой и системой здравоохранения. Медицинские сестры становятся активными участниками стратегических процессов, влияя на результаты лечения, доступность помощи и удовлетворённость пациентов. Для реализации этого

потенциала необходимы системные усилия: нормативное признание расширенных функций, инвестиции в образовательную политику, формирование культуры лидерства внутри профессионального сообщества.

Развитие сестринского лидерства в онкологической практике — ключ к построению устойчивой, ориентированной на пациента, высокоэффективной модели здравоохранения.

Список использованных источников:

1. WHO. State of the World's Nursing Report. Geneva: World Health Organization; 2020.

2.Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Концепция развития паллиативной помощи. Астана, 2022.

3. Коннор С.Р., Бермедо М.К.С. Глобальный атлас паллиативной помощи. WHPCA, 2020

4. Oncology Nursing Society (ONS). Nursing Leadership and Change Management. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ons.org

Regional Cooperation and Capacity Building: China–Central Asia Practical Exploration of Cervical and Breast Cancer Control

Dr. YANG Yao

School of Population Medicine & Public Health, Chinese Academy of Medical Sciences/Peking Union Medical College

Abstract

Background: The global burden of cancer, particularly cervical and breast cancer, is rising disproportionately in low- and middle-income countries (LMICs). Health systems in these settings face systemic barriers, including technology gaps, financing constraints, and workforce shortages, which hinder effective cancer control.

Objective: This presentation elucidates a practical framework for regional cooperation and capacity building initiated by China with Central Asian nations and Shanghai Cooperation Organization (SCO) member states, aimed at strengthening cervical and breast cancer prevention and control.

Methods: The approach is grounded in a "capacity-first" cooperation architecture, emphasizing context adaptation, progressive technology adoption, and data-driven learning. Key interventions include: 1) joint research and technology transfer (e.g., deployment of Chinese HPV vaccines and screening techniques); 2) structured capacity-building programs featuring theoretical lectures, practical skills training, and field visits for public health and clinical professionals from the region; and 3) efforts towards policy harmonization and cross-border data

sharing.

Results: Preliminary outcomes from training sessions held in Urumqi (2024-2025) demonstrate high effectiveness, with a 90% participant satisfaction rate, a 75% knowledge improvement rate, and an 80% program recommendation rate. The initiative has successfully raised awareness among Central Asian clinicians and established a sustainable cross-country professional network. However, real-world obstacles such as power asymmetries and policy fragmentation persist.

Conclusion: Regional collaboration is a viable strategy to mitigate the cancer burden in resource-limited contexts. Moving forward, a new framework is advocated, which positions health as a strategic investment, strengthens regional coordination platforms, and fosters inclusive, multi-stakeholder governance to ensure long-term impact and health equity.

Accelerating the elimination of cervical cancer in low-health-resources countries and areas

Prof. Youlin QIAO

School of Population Medicine and Public Health, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College

Abstract

Background: The global burden of cervical cancer disproportionately affects low- and middle-income countries (LMICs), where 85% of new cases and 88% of deaths occur. Significant health inequities and systemic barriers hinder the implementation of effective prevention and control programs in these low-health-resource settings.

Objective: This presentation outlines a multi-faceted approach, led by Chinese academic institutions, to accelerate the elimination of cervical cancer in LMICs, aligning with the World Health Organization's (WHO) global elimination strategy.

Methods: The strategy integrates scientific innovation with robust capacity building and international collaboration. Key technological innovations promoted include self-sampling for HPV testing and thermal ablation for treatment of precancerous lesions, which are cost-effective and suitable for low-resource settings. Capacity-building efforts are demonstrated through extensive training programs for healthcare workers from "Belt and Road" countries, including Myanmar, Laos, and Cambodia. Furthermore, China's expertise has been leveraged to support national program design in countries like Mongolia, Kyrgyzstan, and Nepal through partnerships

with WHO and other international bodies.

Results: Practical implementation has established screening and treatment demonstration projects in multiple Southeast Asian countries. These initiatives have facilitated the transfer of Chinese HPV vaccines and screening technologies, built local healthcare capacity, and fostered a collaborative network for cervical cancer prevention. China's experience and technological solutions have gained international recognition and are being adapted to local contexts in partner countries.

Conclusion: The elimination of cervical cancer in low-health-resource settings is achievable through a combined approach of deploying context-appropriate technological innovations and strengthening local health systems via international cooperation and capacity building. China's role in this global effort, particularly through South-South collaboration, provides a viable model for accelerating progress towards the WHO's 2030 elimination targets.

Көкшетау жоғары медициналық колледжінің 75 жылдығына халықаралық және 13 Өңірлік АРОСР "қатерлі ісіксіз болашақ үшін бірге-медбикелер, дәрігерлер, ғалымдар" конференциясының
Резолюциясы

2025 жылғы 2-3 қазан, Көкшетау қаласы

1. Конференцияның қорытындылары

1. Орталық Азияда онкологиялық қызметті дамытудың стратегиялық маңыздылығы және «Обырсыз болашақ үшін күш біріктірейік» ұранымен дәрігерлердің, ғалымдардың, медбикелердің және қоғамның күш-жігерін біріктіру қажеттігі атап өтілді.

2.Көкшетау жоғары медициналық колледжінің жаңа буын мамандарын даярлауды және студенттердің зерттеу құзыреттерін дамытуды қамтамасыз ететін білім беру және ғылыми орталық ретіндегі маңызды рөлі атап өтілді.

3. Негізгі бағыттар қаралды:

медбикелердің рөлін күтуден көшбасшылыққа қарай кеңейту;

қазіргі заманғы ғылыми деректер негізінде онкологиялық көмекті трансформациялау;

сырқаттардың алдын алу, диагностика және оңалту саласындағы пәнаралық ынтымақтастықтау;

жатыр мойны обырының алдын алудың тиімді шарасы ретінде ҚПБ-ға қарсы вакцинацияны енгізудің өңірлік тәжірибелеу.

2. Конференцияның ұсынымдары

1. Көшбасшылыққа, зерттеу қызметіне және пәнаралық командаларға қатысуға баса назар аудара отырып, медбикелерді даярлау және қайта даярлау бағдарламаларын дамыту.

2. Тәжірибе алмасу, бірлескен ғылыми зерттеулер және онкологиялық ауруларды диагностикалау мен емдеудің инновациялық әдістерін енгізу үшін өңірлік және халықаралық ынтымақтастықты нығайту.

3. Табысы төмен және орташа деңгейдегі елдерге ерекше назар аудара отырып, скрининг пен вакцинациялаудың ұлттық бағдарламаларын, оның ішінде ҚБЖ-ға қарсы вакцинациялау бағдарламаларын қолдау және кеңейту.

4. Онкологиялық оңалтуды дамытуға, «patientnavigation» модельдерін енгізуге және пациенттердің өмір сүру сапасын жақсартуға жәрдемдесу.

5.АРОСР шеңберінде ғылыми материалдарды жариялауды жалғастыру және онкологиялық аурулардың алдын алу және емдеу саласындағы үздік практикаларды тарату.

3. Шешім

1. Осы қарарды конференцияның барлық қатысушылары қабылдайды және одан әрі іске асыру үшін Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне, өңірлік денсаулық сақтау органдарына және АРОСР атқарушы комитетіне жібереді.

2. Ұйымдастырушылар мен қатысушыларға онкологиялық ғылым мен медициналық білім беруді дамытуға қосқан үлесі үшін алғыс білдіріледі.

Комиссия мүшелерінің бірауыздан қабылданған қарары

Көкшетау қаласы, Қазақстан Республикасы 2025 жылғы 3 қазан

РЕЗОЛЮЦИЯ

Международной конференции, посвящённой 75-летию Кокшетауского высшего медицинского колледжа,
и 13-й региональной конференции Азиатско-Тихоокеанской организации по профилактике рака (APOCP)
2–3 октября 2025 года, г. Кокшетау

1. Итоги конференции

1. Отмечено стратегическое значение развития онкологической службы в Центральной Азии и необходимость объединения усилий врачей, учёных, медицинских сестёр и общества под девизом «Объединим усилия ради будущего без рака».
2. Подчёркнута важная роль Кокшетауского высшего медицинского колледжа как образовательного и научного центра, обеспечивающего подготовку специалистов нового поколения и развитие исследовательских компетенций студентов.
3. Рассмотрены ключевые направления:
   - расширение роли медицинских сестёр от ухода к лидерству;
   - трансформация онкологической помощи на основе современных научных данных;
   - междисциплинарное сотрудничество в области профилактики, диагностики и реабилитации;
   - региональный опыт внедрения вакцинации против ВПЧ как эффективной меры профилактики рака шейки матки.

2. Рекомендации конференции

1. Развивать программы подготовки и переподготовки медицинских сестёр с акцентом на лидерство, исследовательскую деятельность и участие в междисциплинарных командах.
2. Укреплять региональное и международное сотрудничество для обмена опытом, совместных научных исследований и внедрения инновационных методов диагностики и лечения онкологических заболеваний.
3. Поддерживать и расширять национальные программы скрининга и вакцинации, в том числе программы вакцинации против ВПЧ, уделяя особое внимание странам с низким и средним уровнем дохода.
4. Содействовать развитию онкологической реабилитации, внедрению моделей «patient navigation» и улучшению качества жизни пациентов.
5. Продолжить публикацию научных материалов в рамках APOCP и распространять лучшие практики в сфере профилактики и лечения онкологических заболеваний.

3. Решение

1. Настоящая резолюция принимается всеми участниками конференции и направляется в Министерство здравоохранения Республики Казахстан, региональные органы здравоохранения и в исполнительный комитет APOCP для дальнейшей реализации.
2. Организаторам и участникам выражается благодарность за вклад в развитие онкологической науки и медицинского образования.

Резолюция принята единогласно участниками секции

г. Кокшетау, Республика Казахстан 3 октября 2025 года

RESOLUTION

The International Conference dedicated to the 75th anniversary of Kokshetau Higher Medical College

and the 13th Regional Conference of the Asia-Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP)

on October 2-3, 2025, Kokshetau

1. Conference results

1. The strategic importance of the development of cancer services in Central Asia and the need to unite the efforts of doctors, scientists, nurses and society under the motto "Join forces for a cancer-free future" were noted.

2. The important role of Kokshetau Higher Medical College as an educational and scientific center providing training for a new generation of specialists and the development of students' research competencies was emphasized.

3. The key directions are considered:

- Expanding the role of nurses from nursing to leadership;
- transformation of oncological care based on modern scientific data;
- interdisciplinary cooperation in the field of prevention, diagnosis and rehabilitation;
- regional experience in the introduction of HPV vaccination as an effective measure for the prevention of cervical cancer.

2. Conference Recommendations

1. To develop training and retraining programs for nurses with an emphasis on leadership, research and participation in interdisciplinary teams.

2. Strengthen regional and international cooperation for the exchange of experience, joint scientific research and the introduction of innovative methods for the diagnosis and treatment of oncological diseases.

3. Support and expand national screening and vaccination programmes, including HPV vaccination programmes, with a particular focus on low- and middle-income countries.

4. To promote the development of oncological rehabilitation, the introduction of "patient navigation" models and the improvement of patients' quality of life.

5. Continue publishing scientific materials within the framework of APOCP and disseminate best practices in the field of cancer prevention and treatment.

3. The solution

1. This resolution is adopted by all participants of the conference and sent to the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan, regional health authorities and the APOCP Executive

Committee for further implementation.

2. The organizers and participants are grateful for their contribution to the development of oncological science and medical education.

The resolution was adopted unanimously by the participants
of the Kokshetau section, Republic of Kazakhstan on October 3, 2025

МАЗМҰНЫ/ СОДЕРЖАНИЕ/ CONTENT

Expanding the role of nurses in healthcare systems……5
Dairov Amantai
Қазіргі заманғы білім беру стандарттарын енгізу: мультидисциплинарлық өзара әрекеттесу тәжірибесі……8

Байгульжина Жазира, Сейсембекова Маншук, Жумагалиева Асия

Реализация совместного образовательного проекта «Школа команды врача общей практики» как основа формирования профессиональных компетенций будущих медицинских специалистов……..11
Куликова Марина, Бакалец Наталья
Опыт кокшетауского высшего медицинского колледжа по организации трудоустройства выпускников колледжа……16
Махметова Гульмира
Стрессоустойчивость, как важный фактор эффективной профессиональной деятельности и сохранения профессионального долголетия медицинских работников среднего звена.19
Курзанова Светлана, Куликова Марина
Сестринское дело в онкологии: практика, сопровождение, лидерская позиция в мультидисциплинарной команде……22
Байгульжина Жазира, Сейсембекова Маншук, Жумагалиева Асия

Опыт интеграции сестринских исследований в образовательном процессе прикладного бакалавриата: формирование профессиональных и исследовательских компетенций у студентов……27
Мокрова Инна
Практико-ориентированное сестринское исследование влияния диспансеризации на снижение нагрузки служб экстренной помощи……31
Головина Оксана, Дыдыгина Елена, Досмұқан Алуа
Инновационные технологии в паллиативной помощи: синтез науки, технологий и милосердия……36
Ковзалова Людмила Николаевна
Сестринское дело: стандарты, вызовы и перспективы……...40
Мусаева Анастасия, Оспанова Аяужан
Психологическая помощь медицинской сестры родственникам и пациентам с онкологическимизаболеваниями……43
Колесникова Олеся
"Мейіргер ісі мамандарының рөлі: күтімнен көшбасшылыққа дейін"секциясының резолюциясы……..48
Резолюция секции «Роль специалистов сестринского дела: от ухода до лидерства»…...50
Resolution of the section "The role of nursing specialists: from nursing to leadership"……52
II бөлімі. 75 жылдығына арналған АРОСР Халықаралық 13-ші Аймақтық конференциясының постерлік сессиясының материалдары Көкшетау жоғары медициналық колледжі/РазделII. Материалы Постерной сессии Международной 13-й Региональной конференции АРОСР, посвящённой 75-летию Кокшетауского высшего медицинского колледжа/Section II. Materials of the Poster session of the 13th AROSR international Regional Conference dedicated to the 75th anniversary Kokshetau Higher Medical College……54
The Effectiveness of Human papillomavirus-related Cancer Prevention Awareness Program on Knowledge and Screening Intention among Female Students and Employees of Oman College of Health Sciences, North Batinah……..55
Abhar Al Shihhi, Ishraq Al Obeidani, Maryam Al Mamari, Manar Al Barhi, Dr. Maria Pramila D' Costa

Введите текст

Науқастардың гемокульт тест тапсыруы кезіндегі мейіргерлік тәжірибе…….……56
Букен Назира, Мұстахым Сымбат
Инновационный подход в оказании паллиативной помощи……57
Сурова Яна, Ковзалова Людмила
Maintaining sleep quality in cancer patients with the help of nursing interventions……..…58
Yaroshinskaya Irina, Salimova Aruzhan
Возможности улучшения практики безопасного сестринского ухода за пациентами в приемном отделении…….59
Мокрова Инна, Кулыбекова Раушан
Сестринская практика эффективной организации психофизического скрининга детей раннего возраста на уровне ПСМП……..……60
Мокрова Инна, Козловцева Анна
Поддержка пациентов в процессе самоменеджмента после мастэктомии
Куспанова Айгуль, Дюсенбаева Арайлым, Кадырбаева Каракат……61
Медико-психологическая реабилитация пациентов после мастоэктомии……...…….62
Окасова Гульнар, Жага Ангелина
III бөлім. Онкологиялық көмекті ұйымдастырудың қазіргі тенденциялары/Раздел III. Современные тенденции организации онкологической помощи/Section 3. Current trends in the organization of oncological care……63
Bridging Knowledge to Action: Effectiveness of Human Papillomavirus-Related Cancer Awareness Program on Knowledge and Screening Intention among Female Students and Employees of a selected Health Sciences College……..63
Ishraq Hamood Al Obeidani, Abhar Rashid Said AL Shihhi, Maryam Abdallah Al Mamari, Aqdar Anwar Al Lahuri, Manar Ibrahim AL Barhi, Hamida Amin Al Lawati, Al Hanoof Saif Al Mamari[1] Nouf Salim Al Khanabshi, Lamees Dhahi Al Buraiki, Sami Sanad Al Zaabi, Younis Nasser Al Mamari, Maria Pramila D'Costa
Personalized selection of anti-cancer drugs using the patented MTAM-HFA technology for the treatment of head and neck cancer and other types of malignant tumors……...64
Professor Chen Chien-Chung
Мейіргерлік білімді трансформациялау –қатерлі ісіксіз болашаққа қадам……66
Коконбаева Айдана
К вопросу преодоления психологической неготовности выпускников к работе в сложных условиях: из опыта работы предметного кружка «онкология и жизнь» для учащихся медицинского колледжа……70
Сидорская Марина
Онкологиялық пациенттердің күтімі кезіндегі мейіргердің рөлі…….73
Дидарбекова Макпал
Поэтапное формирование коммуникативных компетенций учащихся медицинского колледжа с пациентами онкологического профиля в условиях симуляционного обучения…….78
Шепелевич Виктория
Ағарту және халықты тарту арқылы онкологиялық аурулардың алдын алу……..…82
Дуйсенгалиева Гульнар, Нургалиева Акжарқын, Дюсенбаева Айгерим
Медико-психологическая реабилитация пациентов после мастэктомиии……..88
Окасова Гульнар
Онкологиядағы профилактиканың заманауи және өзекті мәселелері……91
Андакулова Куралай, Серкебаева Айгуль, Ахметова Улбосын, Нурбаева Рабига
Адам папилломавирусы (АПВ)……96
Аймурзиева Манчук, Кусанова Айгерим, Алмаханбетова Зарина
Онкологиялық аурулардың алдын алу бойынша колледж базасындағы ағарту жұмыстары……..100
Жармаганбетова Галия, Оразбекова Салтанат
Химиотерапиядан кейінгі кезеңдегі пациенттердің күтімі мен тамақтануында

мейіргердің білім деңгейі……...105
Аманова Динара, Прманова Шакизада
Паллиативті көмектің амбулаторлы жағдайда ұйымдастырудағы мейіргердің қызметі...……...111
Касимова Камила
Организация паллиативной помощи и мультидисциплинарное взаимодействие……114
Куспекова Айнур, Оспанова Аяужан
Сохранение качества сна у онкологических пациентов с помощью сестринских вмешательств…...……117
Ярошинская Ирина, Салимова Аружан
Сестринское дело как движущая сила изменений: от повседневного ухода к стратегическому лидерству в борьбе с раком..……121
Кадырбаева Каракат, Раимбекова Умут
Regional Cooperation and Capacity Building: China–Central Asia Practical Exploration of Cervical and Breast Cancer Control
Dr. YANG Yao…….....…….……..125
Accelerating the elimination of cervical cancer in low-health-resources countries and areas
Prof. Youlin QIAO…...……126
Көкшетау жоғары медициналық колледжінің 75 жылдығына халықаралық және 13 Өңірлік АРОСР "қатерлі ісіксіз болашақ үшін бірге-медбикелер, дәрігерлер, ғалымдар" конференциясының Резолюциясы…….....……..128
Резолюция Международной конференции, посвящённой 75-летию Кокшетауского высшего медицинского колледжа и 13-й региональной конференции Азиатско-Тихоокеанской организации по профилактике рака (АРОСР)……...129
Resolution of The International Conference dedicated to the 75th anniversary of Kokshetau Higher Medical College and the 13th Regional Conference of the Asia-Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP)…….130